

Anestesiologia — banco SBA

Prova para avaliação de modelo · sem gabarito

Este documento traz **1003 questões de anestesiologia** extraídas de provas da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Elas vêm em dois formatos: **V/F** — um enunciado seguido de uma assertiva. Responda **V** se a assertiva for verdadeira e **F** se for falsa.

ME — um enunciado seguido de quatro alternativas. Responda com a **letra** da alternativa correta: A, B, C ou D. **Como devolver as respostas**

Uma linha por questão, no formato **ID: RESPOSTA**, exatamente assim: q0001: V

q0002: F

q0003: C Responda **todas** as questões, na ordem, sem pular. Se estiver em dúvida, escolha a resposta mais provável em vez de deixar em branco — item sem resposta conta como erro. Não escreva justificativa: só o ID e a resposta.

q0001 [V/F]

Sobre as complicações durante a anestesia para cirurgias bucomaxilofaciais:

Assertiva: o apoio do laringoscópio nos dentes superiores poderá implicar em luxações, danos às coroas dentárias ou de próteses, impacto da maxila ou fratura dos meios de osteossintese empregados em cirurgias bucomaxilofaciais anteriores.

q0002 [V/F]

Sobre as complicações da anestesia:

Assertiva: o radical fluoreto é incluído na molécula de todos os anestésicos inalatórios com a finalidade de reduzir a inflamabilidade.

q0003 [V/F]

Com relação ao risco profissional do anestesiológista:

Assertiva: ficha anestésica esmeradamente preenchida e preferência por trabalhos em conjunto com outros anestesiológistas são características que podem indicar abuso ilícito de substâncias pelo anestesista.

q0004 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgias urológicas responda:

Assertiva: nos casos de cirurgia para nefrectomia em que o haja trombo tumoral intravascular supradiaphragmático, a colocação de um cateter da artéria pulmonar logo no início da cirurgia é mandatório, uma vez que há clara necessidade de monitorização hemodinâmica invasiva.

q0005 [V/F]

Sobre o choque séptico:

Assertiva: o choque séptico é um choque distributivo associado a um agente infeccioso, caracterizado por diminuição do débito cardíaco.

q0006 [V/F]

Sobre a mecânica respiratória e controle da respiração, julgue os itens:

Assertiva: os músculos responsáveis pela inspiração são o diafragma e os músculos intercostais internos.

q0007 [V/F]

Em relação aos agonistas opioides utilizados em analgesia pós-operatória, sabe-se:

Assertiva: O tramadol pelo seu mecanismo de ação, tem efeitos analgésicos e antidepressivos.

q0008 [V/F]

Sobre a pré-oxigenação do paciente durante a indução anestésica:

Assertiva: certas circunstâncias, podem limitar a eficácia da pré-oxigenação, como paciente que experimenta claustrofobia com a máscara facial; o uso de máscaras exclusivamente nasais; vazamentos ao redor da máscara facial, tão pequenos quanto 4 mm (seção transversal).

q0009 [V/F]

Sobre a avaliação pré-operatória:

Assertiva: a hipoventilação da obesidade (Síndrome de Pickwick) é causada por obstrução mecânica da via aérea, semelhante à apnéia obstrutiva do sono.

q0010 [V/F]

Quanto ao posicionamento dos pacientes durante a cirurgia:

Assertiva: posição sentada e presença de forame oval patente levam a um risco aumentado de embolia arterial paradoxal.

q0011 [V/F]

Sobre anestesia venosa:

Assertiva: na modalidade TCI plasma, a k_{e0} não influencia no cálculo do bolus administrado.

q0012 [V/F]

Homem, 48 anos, 70 kg, 170cm, deu entrada no centro cirúrgico com extensas queimaduras face, pescoço e tórax há 72 h, será submetido a desbridamento e curativo das queimaduras, apresentou aproximadamente 50% de superfície corporal queimada. Segue a figura, após a indução anestésica. Sobre anestesia para cirurgia plástica no paciente queimado, responda:

Assertiva: o volume de distribuição de muitos fármacos, como propofol e fentanil, aumenta em pacientes queimados devido à diminuição da albumina e a expansão do volume extravascular.

q0013 [V/F]

Sobre o íon potássio, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: a insulina exerce efeito protetor na hiperpotassemia por meio do aumento da captação de potássio pelas células hepáticas e musculares.

q0014 [V/F]

Sobre o propofol, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: o local extra-hepático mais importante do metabolismo de propofol é o rim.

q0015 [V/F]

Homem de 52 anos, com IMC 38 kg/m², antecedente de apneia obstrutiva do sono e refluxo gastroesofágico, será submetido a esofagogastroduodenoscopia (EGD) com previsão de mucosectomia gástrica. O exame será realizado fora do centro cirúrgico, com uso de bisturi elétrico. Com base no quadro clínico, avalie as alternativas:

Assertiva: o uso de bisturi elétrico na endoscopia alta exige precauções contra incêndio de via aérea.

q0016 [V/F]

A respeito da anestesia para procedimentos Bucomaxilofaciais:

Assertiva: a intubação orotraqueal com tubo pré-moldado com conector apontando para os pés do paciente é indicada para cirurgias de articulação temporomandibular.

q0017 [V/F]

Um paciente de 35 anos, sem comorbidades conhecidas, foi submetido a um procedimento cirúrgico para reparo de uma hérnia inguinal. Durante a cirurgia, foi administrada lidocaína a 1% como anestésico local. Após a administração, o paciente desenvolveu uma perda temporária da sensação na área operada, seguida por uma recuperação gradual após o término da cirurgia. Sobre os efeitos eletrofisiológicos dos anestésicos locais:

Assertiva: o bloqueio fásico não é reversível quando a estimulação é diminuída ou interrompida.

q0018 [V/F]

Com relação à qualidade na prática da anestesia:

Assertiva: Donabedian propôs uma sistematização de melhoria baseada em três dimensões fundamentais de qualidade: estrutura, processos e resultados.

q0019 [V/F]

De acordo com as zonas de West, na posição ereta, considerando que PA = pressão alveolar; Ppa = pressão da artéria pulmonar; e Ppv=pressão na veia pulmonar:

Assertiva: zona 1 = PA > Ppa > Ppv

q0020 [V/F]

Considerando as zonas pulmonares de West:

Assertiva: Situações onde zona I exista haverá efeito shunt.

q0021 [V/F]

Em relação à farmacologia dos anestésicos inalatórios:

Assertiva: o volume minuto ventilatório aumenta 3L/min por cada 1 mmHg de aumento do PaCO₂.

q0022 [V/F]

Sobre o Estatuto da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA):

Assertiva: é direito do membro adjunto prestar concurso para obtenção do Título Superior em Anestesiologia.

q0023 [V/F]

Com relação aos bloqueios oculares:

Assertiva: a acinesia do músculo elevador das pálpebras ocorre pelo bloqueio do nervo oculomotor.

q0024 [V/F]

Após uma parada cardiorrespiratória e reanimação:

Assertiva: hipertermia (febre) deve ser evitada e controlada ativamente.

q0025 [V/F]

Sobre os equipamentos para infusão alvo controlada (Target-Controlled-Infusion)- TCI observa-se que:

Assertiva: na infusão efeito, a constante Ke₀ é um determinante do bolus inicial do fármaco.

q0026 [V/F]

Sobre o propofol, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: o propofol diminui a pre e a pós-carga cardíacas por ação direta na musculatura lisa vascular (arterial e venosa) e por diminuição do tônus simpático.

q0027 [V/F]

Considerando as zonas pulmonares de West:

Assertiva: Na zona III a pressão arterial pulmonar e a pressão venosa pulmonar excedem a pressão alveolar, como resultado há perfusão durante a sístole e a diástole.

q0028 [V/F]

Com relação à farmacologia dos anestésicos venosos.

Assertiva: Propofol em baixas doses (10mg IV) deprime atividade medular espinal e por esse mecanismo é efetivo no tratamento de prurido associado a opioides intratecais.

q0029 [V/F]

Com relação à farmacologia dos anestésicos venosos:

Assertiva: propofol é um fármaco insolúvel em água e requer um veículo lipídico para emulsificação.

q0030 [V/F]

Analise o gráfico abaixo da curva de tempo de meia vida contexto sensível (tempo para a concentração plasmática diminuir em 50% a partir de uma infusão que mantém uma concentração constante) das drogas anestésicas:

Assertiva: B é a curva do Alfentanil.

q0031 [V/F]

Em relação à farmacologia dos anestésicos inalatórios:

Assertiva: a diminuição do consumo de oxigênio é de 10 a 15% durante a anestesia inalatória.

q0032 [V/F]

Sobre anestesia em obstetrícia:

Assertiva: O sangue fetal, por ser mais ácido que o sangue materno, cria um ambiente no qual medicamentos fracamente básicos, como anestésicos locais e opioides, tornem-se ionizados e acumulem-se atingindo níveis mais elevados do que no sangue materno.

q0033 [V/F]

Sobre equilíbrio ácido básico e manejo de fluidos e de eletrólitos:

Assertiva: a hipocalcemia tem sido reconhecida como o quarto componente da tríade letal anteriormente conhecida: hipotermia, acidose e coagulopatia.

q0034 [V/F]

Com relação a anestesia para geriatria:

Assertiva: em idosos, a dolantina (petidina) está associada a uma analgesia pouco efetiva e pode causar neurotoxicidade.

q0035 [V/F]

Sobre complicações em anestesia.

Assertiva: A liberação de histamina causa febre, hipotensão e instabilidade hemodinâmica, enquanto a liberação de bradicinina dos mastócitos leva a broncoespasmo e urticária, bem como sintomas de dispneia, rubor e ansiedade grave.

q0036 [V/F]

Na monitorização perioperatória:

Assertiva: a queda da saturação venosa mista abaixo de 70% sinaliza um desequilíbrio entre a oferta e a extração periférica de oxigênio e entre as causas mais comuns estão a anemia, hipoxemia e disfunção miocárdica.

q0037 [V/F]

Em relação ao sistema nervoso central, avalie:

Assertiva: A medula espinhal é irrigada pelas artérias espinhais anterior e posteriores, ramos da artéria vertebral, assim como pelas artérias radiculares.

q0038 [V/F]

Com relação ao transporte tubular renal:

Assertiva: há reabsorção de bicarbonato pela ação da anidrase carbônica no túbulo proximal.

q0039 [V/F]

Em estudos animais há relatos de disfunção renal decorrente da interação do sevoflurano com os absorvedores de dióxido de carbono da cal sodada, os chamados Compostos A. Fatores que favorecem a produção de Composto A:

Assertiva: altas temperaturas. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 01/04 – ME2/2025 CCA

q0040 [V/F]

Sobre o monitor intraoperatório de pressão arterial invasiva (PAI):

Assertiva: As variações cíclicas da pressão arterial sistólica durante o ciclo respiratório são conhecidas como Variação da Pressão Sistólica (VPS).

q0041 [V/F]

Em procedimentos urológicos para desintegração de cálculos presentes no ureter e no rim:

Assertiva: a litotripsia a laser com fibra de hólmio produz fragmentos de cálculos maiores que os produzidos pela litotripsia eletro hidráulica.

q0042 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgias urológicas responda:

Assertiva: entre as desvantagens do uso do manitol como solução de irrigação em procedimentos de ressecção transuretrais estão a diurese osmótica e possibilidade de expansão volêmica aguda.

q0043 [V/F]

Sobre complicações em anestesia.

Assertiva: A vasopressina é frequentemente necessária para gerenciar eficazmente a hipotensão refratária associada a overdose de fenoxibenzamina.

q0044 [V/F]

Sobre disfunção tireoideana perioperatória:

Assertiva: o aumento do hormônio estimulante da tireoide (TSH) é o indicador mais sensível do hipotireoidismo.

q0045 [V/F]

Sobre a dor fantasma:

Assertiva: aproximadamente 50% dos pacientes com dor fantasma apresentam uma diminuição da dor ao longo do tempo.

q0046 [V/F]

Você foi convocado para realizar anestesia para ressecção de tumor cerebral. A depender da localização da lesão, podemos afirmar que:

Assertiva: lesão localizada na base do crânio com difícil acesso cirúrgico, requer que o encefalo tenha seu volume reduzido para facilitar a abordagem cirúrgica transcraniana, assim como evitar lesão secundária com o deslocamento e a retracção da córtex cerebral.

q0047 [V/F]

Paciente de 43 anos, sexo masculino, previamente hígido, teve perda súbita de visão, astenia e episódios recorrentes de hipoglicemia e foi diagnosticado com tumor hipofisário grande, de 3cm de diâmetro. Cortisol sérico de 0,5mcg/dL (valor de referência: 5-25mcg/dL). Será submetido à cirurgia para exérese do tumor. A respeito desse caso, responda os itens.

Assertiva: TSH e T4 livre devem ser dosados antes da cirurgia pelo risco de hipotireoidismo central.

q0048 [V/F]

São efeitos fisiológicos da anestesia epidural e subaracnóidea:

Assertiva: ocorre diminuição da capacidade vital e volume de reserva expiratória devido principalmente a diminuição da função diafragmática.

q0049 [V/F]

No manejo da anestesia para cirurgia torácica:

Assertiva: ao optar por seletivação pulmonar através de um tubo de duplo lumen Robertshaw direito há necessidade de confirmação de posicionamento através de broncoscopia para evitar atelectasia de lobo superior direito.

q0050 [V/F]

Em procedimentos de Ressonância Nuclear Magnética:

Assertiva: O aparelho de anestesia e monitor devem ser construídos em alumínio, aço não magnético, plástico ou latão quando forem alocados adjacentes ao magneto.

q0051 [V/F]

Sobre os monitores avançados de oxigenação e metabolismo cerebral, avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: valores de PbtO₂ (pressão parcial de oxigênio no tecido cerebral) abaixo de 20mmHg são indicativos de hipóxia cerebral em estados patológicos.

q0052 [V/F]

Em relação ao sistema nervoso central, avalie:

Assertiva: Da medula espinhal saem 33 pares de nervos espinhais, sendo eles 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 6 sacrais e 2 coccígeos.

q0053 [V/F]

Com relação aos princípios norteadores do cuidado centrado no paciente relacionados a qualidade e segurança:

Assertiva: a notificação espontânea ou voluntária de incidentes deve tornar-se menos punitiva e mais focada em sistemas do que em indivíduos. PROVA TRIMESTRAL 04/04 – ME3/2023 CCA

q0054 [V/F]

Homem de 62 anos, admitido com infarto agudo do miocárdio, foi submetido à trombólise com tPA, o que resultou em melhora clínica. Entretanto, exames laboratoriais revelaram níveis elevados de PAI-1 (inibidor do ativador do plasminogênio -1), sugerindo um mecanismo compensatório de inibição da fibrinólise. Avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: os resíduos clivados de lisina na fibrina, aumenta a afinidade do tPA e potencializa a fibrinólise.

q0055 [V/F]

Em relação a anestesia pediátrica, avalie:

Assertiva: levando em consideração a relação ventilação alveolar (VA) / capacidade residual funcional (CRF), os recém-nascidos apresentam equilíbrio entre pressão parcial alveolar e fração inspirada de anestésico inalatório mais rápida em comparação aos adultos.

q0056 [V/F]

Sobre equilíbrio ácido básico e manejo de fluidos e de eletrólitos:

Assertiva: em pacientes não críticos, o uso de cristaloídes balanceados, em comparação à solução salina a 0,9%, está associado a menos distúrbios metabólicos.

q0057 [V/F]

Retalhos de tecido livre são usados frequentemente em cirurgias plásticas reparadoras de pacientes oncológicos, como para reconstrução mamária ou após remoção de tumores de cabeça e pescoço. Em relação a esses retalhos, julgue:

Assertiva: O sistema linfático desses retalhos geralmente leva semanas para se adequar, o que explica a tendência ao edema desses retalhos.

q0058 [V/F]

Você é chamado para atender uma parada cardiorrespiratória em uma criança de 4 anos que foi encontrada submersa em uma piscina. A criança está inconsciente, sem respiração e sem pulso detectável. Considerando as diretrizes específicas para ressuscitação pediátrica, julgue:

Assertiva: a relação compressão-ventilação para dois ou mais socorristas em pediatria é de 30:2.

q0059 [V/F]

Sobre os sistemas de Mapleson:

Assertiva: O sistema Mapleson A é indicado na ventilação controlada

q0060 [V/F]

Sobre anestesia para obstetrícia, responda:

Assertiva: Grávida com infra de ST de 1mm nas derivações precordiais esquerdas e parede inferior deve ser encaminhada ao cardiologista para investigação complementar.

q0061 [V/F]

Paciente com Doença Renal Crônica (DRC) estágio 5 em hemodiálise será submetido confecção de fístula arteriovenosa. Analise as considerações perioperatórias:

Assertiva: a hiperventilação em pacientes com DRC resulta de acidose metabólica crônica bem como do aumento da água pulmonar e da complacência pulmonar reduzida

q0062 [V/F]

As cirurgias urológicas robóticas e videolaparoscópicas tem peculiaridades fisiológicas e técnicas importantes que o anestesista deve saber para proporcionar melhores desfechos para o paciente. São elas:

Assertiva: na posição de trendelenburg, pacientes com história de refluxo têm risco aumentado de regurgitação e aspiração do conteúdo gástrico.

q0063 [V/F]

Sobre a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA):

Assertiva: deficiência auditiva é fator de risco para delirium pós-operatório.

q0064 [V/F]

Paciente sexo masculino 50 anos, hipertenso, tabagista pesado (40 cigarros/dia) será submetido a uma gastrectomia. Avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: o trabalho respiratório estará aumentado durante a anestesia.

q0065 [V/F]

Alguns conhecimentos são fundamentais para se iniciar uma pesquisa científica:

Assertiva: os comitês de ética e pesquisa são formados por no mínimo 7 membros, de caráter multiprofissional e devem ser registrados no Conselho Nacional de Saúde (CNS).

q0066 [V/F]

Com relação ao sistema nervoso autônomo assinale verdadeiro ou falso.

Assertiva: O sistema parassimpático tem origem nos pares cranianos III, VII, IX e X.

q0067 [V/F]

Sobre as particularidades da anestesia para oftalmologia:

Assertiva: a pilocarpina é um fármaco simpaticomimético cujo uso crônico está associado à hipertensão e broncodilatação. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 04/04 – ME2/2023 CCA

q0068 [V/F]

Sobre a anestesia para cirurgia ortopédica, julgue:

Assertiva: A fixação precoce de fratura de fêmur (<24h) é associada com maior dor e tempo de internação.

q0069 [V/F]

Na metodologia científica:

Assertiva: o nível de significância representa a probabilidade com que uma hipótese nula pode ser rejeitada com segurança.

q0070 [V/F]

Nos capnógrafos de fluxo principal (mainstream) e fluxo lateral (sidestream):

Assertiva: o de fluxo lateral requer uma bomba para extrair a amostra e um coletor de água.

q0071 [V/F]

Sobre metodologia científica:

Assertiva: para decidir se há erro amostral, é habitual estabelecer o nível de confiança ou de significância.

q0072 [V/F]

Na monitorização perioperatória da coagulação podemos utilizar a tromboelastometria rotacional para direcionar a terapêutica:

Assertiva: a lise máxima do coágulo entre 5 e 14% indica hiperfibrinólise PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 01/04 – ME2/2023 CCA

q0073 [V/F]

Julgue as afirmativas a seguir:

Assertiva: os valores de pH e PCO₂ permanecem invariáveis durante a hipotermia, independentemente do grau de resfriamento

q0074 [V/F]

No manuseio anestésico-cirúrgico nas microcirurgias da laringe com laser:

Assertiva: todas as estruturas anatômicas adjacentes à lesão devem ser recobertas com gases umidificadas com soro fisiológico para evitar incêndio nas vias aéreas.

q0075 [V/F]

No manuseio anestésico-cirúrgico nas microcirurgias da laringe com laser:

Assertiva: há maior risco de incêndio nas vias aéreas com uma fração inspirada de oxigênio superior a 60%.

q0076 [V/F]

Sobre o choque séptico:

Assertiva: correção de distúrbios hidroeletrólíticos, restauração da perfusão são medidas importantes no manejo choque séptico.

q0077 [V/F]

Sobre anestesia para litotripsia extracorpórea:

Assertiva: em pacientes pediátricos existe maior risco de lesão pulmonar.

q0078 [V/F]

Sobre o monitor intraoperatório de pressão arterial invasiva (PAI):

Assertiva: A calibração do PAI para a pressão ZERO tem como finalidade conectar o transdutor com a pressão atmosférica.

q0079 [V/F]

Sobre anestesia em intervenções coronarianas percutâneas (PCI), avalie as alternativas:

Assertiva: em situações de via aérea difícil com sangramento ativo, o manejo anestésico é facilitado pelo uso de anticoagulantes. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 03/04 – ME3/2025 CCA

q0080 [V/F]

Julgue os aspectos anatômicos e fisiológicos da inervação urogenital.

Assertiva: Sensação de distensão vesical é transmitida via fibras parassimpáticas S2- S4 enquanto dor vesical via simpáticas T11-L2

q0081 [V/F]

Com relação ao risco de aspiração pulmonar perioperatória, julgue os itens:

Assertiva: Deve-se evitar o uso de pressão contínua nas vias aéreas no caso de lesão pulmonar grave.

q0082 [V/F]

Sobre anestesia para transplantes:

Assertiva: Isoflurano, sevoflurano e desflurano afetam a função renal pós-transplante de fígado.

q0083 [V/F]

Um paciente de 70 anos com histórico de insuficiência cardíaca e fibrilação atrial persistente foi encaminhado para uma ablação por cateter no laboratório de eletrofisiologia. Durante o procedimento, que estava programado para durar aproximadamente 5 horas, o paciente foi submetido a anestesia geral para garantir condições ideais de procedimento e conforto do paciente. A equipe médica monitorou de perto a ventilação e a temperatura esofágica do paciente, e houve necessidade de administração de agentes inotrópicos para manter a estabilidade hemodinâmica. Sobre o papel do anestesiológico no laboratório de eletrofisiologia:

Assertiva: o uso de ventilação por jato de alta frequência (HFJV) durante ablações de fibrilação atrial visa eliminar o movimento cardíaco na cavidade torácica e reduzir a instabilidade do cateter.

q0084 [V/F]

Em relação aos analgésicos e adjuvantes não opioides no controle da dor pós-operatória:

Assertiva: Na analgesia com a dipirona importantes concentrações dos metabólitos atravessam a barreira hematoencefálica e induzem analgesia por ação central.

q0085 [V/F]

Sobre anestesia em obstetrícia.

Assertiva: Em cesarianas, quando a morfina neuroaxial é usada, o bloqueio TAP não apresenta diferença no controle da dor pós-operatória.

q0086 [V/F]

Sobre a pré-oxigenação do paciente durante a indução anestésica:

Assertiva: este procedimento envolve a substituição do volume de nitrogênio do pulmão (até 95% da capacidade residual funcional) por oxigênio.

q0087 [V/F]

Nas cirurgias videolaparoscópicas:

Assertiva: gás hélio e argônio são altamente solúveis, fisicamente inertes e não explosivos

q0088 [V/F]

Julgue conceitos básicos sobre a farmacologia abaixo.

Assertiva: Considerando $C(t)$ como a função da concentração pelo tempo e $t_{1/2}$ a meia vida de eliminação será $t_{1/2} = \frac{0,693}{k}$.

q0089 [V/F]

Quanto aos benzodiazepínicos:

Assertiva: os benzodiazepínicos reduzem a taxa metabólica cerebral ou o consumo basal de oxigênio cerebral e aumentam o fluxo sanguíneo cerebral de maneira dose-dependente.

q0090 [V/F]

No manuseio anestésico-cirúrgico nas microcirurgias da laringe com laser:

Assertiva: há maior efeito hemostático na lesão quando é usado o laser ND:YAG.

q0091 [V/F]

Considerando o mecanismo de reparação vascular e as características físicas e químicas das plaquetas, avalie as seguintes afirmações:

Assertiva: as plaquetas têm uma vida útil de 8 a 12 meses no sangue, após o qual seus processos funcionais se esgotam e são eliminadas da circulação principalmente pelo sistema macrofágico tecidual.

q0092 [V/F]

Sobre a analgesia pós-operatória de amigdalectomia:

Assertiva: a dexametasona intravenosa além do efeito antiemético, reduz intensidade da dor.

q0093 [V/F]

Com relação à fisiopatologia do choque, julgue os itens:

Assertiva: A administração de teofilina está associada a elevação dos níveis de lactato.

q0094 [V/F]

No que se refere à morbidade em anestesia:

Assertiva: a comunicação dos eventos adversos ao paciente se fundamenta nos princípios éticos como, autonomia e justiça.

q0095 [V/F]

Na comparação entre os testes viscoelásticos e os convencionais para monitorização perioperatória da coagulação, temos que os testes viscoelásticos:

Assertiva: necessitam ser realizados na temperatura de 37° C.

q0096 [V/F]

Julgue:

Assertiva: A alocação de tempo de sala operatória por ordem de chegada é comumente utilizada em hospitais como o principal método de agendamento de cirurgias, mas muitos hospitais utilizam uma combinação de alocação em blocos e ordem de chegada.

q0097 [V/F]

Com relação às alterações na fisiologia respiratória da gestante a termo, avalie:

Assertiva: o volume de reserva expiratório está diminuído em 25%. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 03/04 – ME2/2024 CCA

q0098 [V/F]

Em relação aos anestésicos inalatórios:

Assertiva: os anestésicos voláteis aumentam o volume corrente.

q0099 [V/F]

A imagem representa a forma de onda da pressão venosa central mostrando a evolução temporal dos componentes da forma de onda da pressão venosa central em relação ao eletrocardiograma. Correlacione o evento mecânico cardíaco causador das seguintes ondas:

Assertiva: X - colapso diastólico da pressão atrial.

q0100 [V/F]

Com relação às alterações na fisiologia respiratória da gestante a termo, avalie:

Assertiva: a capacidade vital está aumentada em 30%.

q0101 [V/F]

Sobre metodologia científica:

Assertiva: as metanálises aumentam o poder estatístico para detectar possíveis diferenças entre os grupos estudados e a precisão da estimativa dos dados, diminuindo o intervalo de confiança.

q0102 [V/F]

Na monitorização perioperatória da coagulação podemos utilizar a tromboelastometria rotacional para direcionar a terapêutica:

Assertiva: 2 - refere-se ao índice da lise do coágulo.

q0103 [V/F]

Sobre as características morfofisiológicas do recém-nascido e da criança, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: o sistema nervoso central tem dois picos de multiplicação celular: a proliferação neuronal, que ocorre entre 15 e 20 semanas de gestação, e a glial, que se inicia na 25 semana gestacional e se encerra no segundo ano de vida.

q0104 [V/F]

Sobre a analgesia pós-operatória de amigdalectomia:

Assertiva: a morfina é o analgésico de escolha na analgesia pós-operatória de crianças.

q0105 [V/F]

Sobre gerenciamento do centro cirúrgico:

Assertiva: a utilização ajustada de uma sala de operação que planeja pessoal das 7h às 15h, mas cujo último caso termina às 13h, é de 75%.

q0106 [V/F]

Durante a infusão de fármacos para realização de anestesia venosa alvo- controlada aplicam-se conceitos farmacodinâmicos e farmacocinéticos:

Assertiva: o $t_{1/2 Ke0}$ do fentanil é menor que o do alfentanil.

q0107 [V/F]

Sobre o edema pulmonar por pressão negativa (EPPN):

Assertiva: os pacientes geralmente apresentam hipóxia, ruídos respiratórios irregulares e expectoração rósea e espumosa.

q0108 [V/F]

Em relação aos agonistas opioides utilizados em analgesia pós-operatória, sabe-se:

Assertiva: A codeína é segura em analgesia em crianças. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 03/04 – ME3/2023 CCA

q0109 [V/F]

Numa cirurgia de videolaparoscopia você opta por ajustar o ventilador no modo de ventilação com pressão controlada. Neste caso:

Assertiva: o fluxo fornecido tem um padrão desacelerado em que a taxa de desaceleração depende da demanda respiratória e da mecânica pulmonar do paciente.

q0110 [V/F]

No que se refere à morbidade em anestesia:

Assertiva: a morbidade relacionada ao procedimento anestésico é considerada baixa, em consonância com os avanços na segurança do paciente.

q0111 [V/F]

Um anestesiológico está avaliando critérios de alta para diferentes pacientes em unidade ambulatorial. Considerando a Resolução CFM nº 1.886/2008 e a responsabilidade específica do anestesiológico na liberação dos pacientes:

Assertiva: a estabilidade hemodinâmica por 30 minutos é critério obrigatório.

q0112 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia plástica:

Assertiva: a analgesia controlada pelo paciente (PCA) com opioides intravenosos é segura e eficaz para dor aguda e dor procedural em adultos e crianças queimadas. A tolerância opioide pode surgir após uma semana de uso contínuo, sendo comum que pacientes queimados necessitem de doses muito superiores às recomendadas em livros-texto.

q0113 [V/F]

Sobre os anestésicos venosos:

Assertiva: o etomidato é um potente inibidor da síntese de esteroides do córtex adrenal, suprimindo o aumento normal do cortisol e da aldosterona após cirurgia e a resposta adrenal à corticotropina.

q0114 [V/F]

Com relação ao bloqueio demonstrado nas imagens abaixo, assinale V ou F.

Assertiva: a estrutura B corresponde a pleura.

q0115 [V/F]

Julgue as afirmativas a seguir:

Assertiva: a arquitetura em espiral do ventrículo esquerdo permite contração em movimento de saca-rolhas, otimizando a ejeção e o enchimento ventricular

q0116 [V/F]

Em relação ao edema cerebral, avalie as afirmativas abaixo:

Assertiva: O edema cerebral osmótico ocorre quando a osmolaridade do plasma é menor do que a osmolaridade do tecido cerebral. Com isso, a água se move acompanhando o gradiente osmótico, reduzindo o conteúdo de água do fluido extracelular cerebral.

q0117 [V/F]

Uma paciente de 55 anos, com IMC de 30 kg/m² e sem histórico de doenças respiratórias, foi submetida a uma videocolecistectomia laparoscópica. Durante o procedimento, foi utilizada ventilação controlada por volume (VCV) com um volume corrente de 6-8 mL/kg de peso corporal previsto, PEEP e manobras periódicas de recrutamento alveolar. Após a cirurgia, a paciente apresentou atelectasia leve e uma redução na capacidade vital forçada (CVF) no segundo dia pós-operatório. Sobre os efeitos respiratórios intraoperatórios e pós-operatórios da insuflação abdominal e cirurgia laparoscópica:

Assertiva: a ventilação protetora dos pulmões, com volumes correntes limitados a 6-8 mL/kg de peso corporal previsto, é recomendada durante procedimentos laparoscópicos para minimizar danos pulmonares.

q0118 [V/F]

No manuseio do sistema respiratório circular, valvular com absorvedor de CO₂, observa-se:

Assertiva: os gases expirados pelo paciente são direcionados ao filtro circular que passa a funcionar apenas como um condutor de gases, reservatório e absorvedor.

q0119 [V/F]

Em anestesia para amigdalectomia, observa-se que:

Assertiva: a colapsabilidade da via aérea em crianças é frequente na presença de hipertrofia amigdaliana.

q0120 [V/F]

Em relação a anestesia pediátrica, avalie:

Assertiva: a cafeína, por se tratar de uma metilxantina, quando administrada de forma endovenosa, é utilizada no tratamento da apnéia entre prematuros suscetíveis.

q0121 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia plástica:

Assertiva: a dexmedetomidina, com uma meia-vida de eliminação (T_{1/2} beta) de aproximadamente 2 horas, é bem indicada para administração por bomba de infusão contínua em técnicas de sedação e anestesia regional em cirurgia plástica. PROVA TRIMESTRAL 01/04 – ME3/2024 CCA

q0122 [V/F]

Você foi escalado para anestesiá-la uma paciente de 80 anos, que será submetida a uma colecistectomia videolaparoscópica, seu staff apresenta um gráfico e orienta a levar em consideração as alterações ali apresentadas quando for realizar a ventilação mecânica. Diante disso, com o envelhecimento, podemos afirmar que:

Assertiva: ocorre aumento da complacência pulmonar e redução da complacência da parede torácica.

q0123 [V/F]

Sobre a farmacologia e os efeitos dos bloqueadores neuromusculares (BNMs):

Assertiva: os BNMs não despolarizantes esteroidais resultam em liberação significativa de histamina.

q0124 [V/F]

Sobre o manuseio do paciente em cirurgia cardíaca:

Assertiva: os cumarínicos devem ser suspenso cinco dias antes do procedimento cirúrgico e substituídos por anticoagulantes de menor meia vida.

q0125 [V/F]

Sobre os hormônios adrenocorticais:

Assertiva: a aldosterona é o principal mineralocorticoide e age nos túbulos renais proximais com reabsorção de sódio e secreção de potássio e hidrogênio.

q0126 [V/F]

Sobre bloqueios periféricos nos membros inferiores:

Assertiva: a movimentação do pé pode auxiliar na identificação ultrassonográfica dos nervos da fossa poplíteia.

q0127 [V/F]

Em relação ao sistema nervoso central, avalie:

Assertiva: O cerebelo apresenta papel na regulação dos movimentos finos e complexos, integrando estímulos proprioceptivos, visuais e táteis. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 02/04 – ME1/2024 CCA

q0128 [V/F]

No que se refere a anestesia para cirurgias bucomaxilofaciais, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: a face é dotada de uma rede vascular ampla, a maioria dos vasos cruzam a linha média para formar anastomoses contralaterais, fazendo com que a hemostasia unilateral possa não coibir sangramentos.

q0129 [V/F]

Com relação à anestesia e o sistema endócrino:

Assertiva: a zona glomerulosa do córtex adrenal é responsável pela produção de glicocorticoides.

q0130 [V/F]

Homem, 58 anos, portador de obesidade mórbida e histórico de doença arterial coronariana, está programado para uma cirurgia eletiva na qual será posicionado em decúbito dorsal (supino) durante o procedimento. Dada a sua condição pré-existente, a equipe perioperatória está atenta aos efeitos fisiopatológicos que essa posição pode ter sobre o paciente.

Assertiva: Em pacientes saudáveis, o posicionamento supino leva a um aumento da pressão arterial média (PAM) e da resistência vascular periférica.

q0131 [V/F]

Sobre o manejo das vias aéreas:

Assertiva: o objetivo da indução em sequência rápida é minimizar o tempo entre a perda de consciência e a insuflação do balonete do tubo traqueal.

q0132 [V/F]

Sobre anestesia e sistema cardiovascular.

Assertiva: Uma das preocupações sobre a PVC guiada por ultrassom de rotina é a potencial perda de habilidades guiadas por pontos de referência e anatomia de superfície ao longo do tempo, quando punção venosa central (PVC) de emergência é necessária,

q0133 [V/F]

Em relação ao Monitoramento da Pressão Arterial e Análise de Onda para Previsão da Responsividade ao Volume:

Assertiva: uma VPS normal em um paciente ventilado mecanicamente é de 7 a 10 mm Hg, com o componente Δ Up da pressão arterial sistólica sendo de 2 a 4 mm Hg e o Δ Down de 5 a 6 mm Hg.

q0134 [V/F]

Sobre a avaliação pré-operatória:

Assertiva: o escore ARISCAT (Assess Respiratory Risk in Surgical Patients in Catalonia) é um método validado para estratificação do risco pulmonar perioperatório: Baixo risco: ARISCAT < 26 (1,6% de complicações) Risco intermediário: ARISCAT 26–44 (13,3% de complicações) Alto risco: ARISCAT $\geq$ 45 (42,1% de complicações).

q0135 [V/F]

Paciente chega ao centro cirúrgico para realização, em caráter de emergência, de laparotomia exploradora por ferimento de arma branca durante briga em bar há 30 minutos. Informa ingestão de álcool. Cirurgião não está no hospital. Sobre este caso, julgue:

Assertiva: uma vez que o termo de consentimento esteja assinado, o anesthesiologista estará isento de quaisquer implicações legais na ocorrência de erro médico.

q0136 [V/F]

Sobre os bloqueios de parede abdominal e membros inferiores:

Assertiva: A abordagem subcostal do TAP block pode oferecer melhor cobertura das regiões superiores e anteriores da parede abdominal.

q0137 [V/F]

Pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos estão expostos a risco variável de apresentar alterações cognitivas no período pós-operatório. Com base nisso, avalie:

Assertiva: maior profundidade anestésica é fator protetor para DCPO.

q0138 [V/F]

Sobre suporte ventilatório.

Assertiva: Paciente com IMC menor que 18kg/m é preditor de ventilação difícil.

q0139 [V/F]

Desde o momento da concepção, inúmeras alterações fisiológicas ocorrem na gestante a fim de adequar o organismo da mulher às necessidades do complexo materno-fetal. Com relação às alterações no sistema respiratório na gestante a termo:

Assertiva: A capacidade vital está aumentada em 40%.

q0140 [V/F]

Sobre bloqueios periféricos nos membros inferiores:

Assertiva: o bloqueio do nervo ciático no nível da fossa poplíteia é comumente realizado com o paciente em posição supina e perna elevada.

q0141 [V/F]

Mulher de 85 anos portadora de estenose aórtica grave é encaminhada para procedimento de implante de valva aórtica transcater (TAVI):

Assertiva: Durante todo o procedimento, manter hipotensão é fundamental para evitar disfunção cardíaca.

q0142 [V/F]

Com relação a anestesia para geriatria:

Assertiva: uma das estratégias para se evitar delirium em idosos é a prevenção de constipação.

q0143 [V/F]

Sobre anestesia e sistema cardiovascular.

Assertiva: Fatores como a hipotermia e o estresse cirúrgico prolongam o TCA.

q0144 [V/F]

Sobre as complicações em anestesia reações anafiláticas/anafilatóides (RAA), hipertermia maligna (HM) e soluções pós-operatórios (SPO), responda:

Assertiva: A ocitocina é considerada causa comum de RAA durante o parto.

q0145 [V/F]

Um paciente adulto é possível candidato a doação de órgãos quando além de um coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinal e apneia persistente, apresenta:

Assertiva: lesão encefálica irreversível capaz de causar morte encefálica.

q0146 [V/F]

Julgue as afirmativas a seguir:

Assertiva: a monitorização da temperatura em pacientes hipotérmicos deve ser feita por via esofágica, retal ou vesical, preferindo-se locais com bom fluxo perfusional

q0147 [V/F]

Com relação aos conceitos de ventilação mecânica:

Assertiva: dos modos clássicos de ventilação, o suporte de pressão permite que o paciente tenha o maior controle sobre o processo de ventilação.

q0148 [V/F]

Os compostos absorventes de CO₂ usados no circuito anestésico para administração dos agentes inalatórios têm as seguintes características:

Assertiva: o grau de umidade dos grânulos se relaciona com a formação de compostos tóxicos.

q0149 [V/F]

Sobre o mecanismo da dor no pós-operatório:

Assertiva: a percepção da dor envolve tanto o córtex somatossensorial quanto áreas do sistema límbico, como o córtex cingulado e a ínsula.

q0150 [V/F]

Na metodologia científica de estudo populacionais:

Assertiva: os testes estatísticos são aplicados de acordo com os dados verificados no estudo, os dados intervalares como a pressão arterial, a frequência cardíaca e a frequência respiratória são chamados de dados não paramétricos.

q0151 [V/F]

Um anestesiológista está avaliando critérios de alta para diferentes pacientes em unidade ambulatorial. Considerando a Resolução CFM nº 1.886/2008 e a responsabilidade específica do anestesiológista na liberação dos pacientes:

Assertiva: o paciente deve demonstrar capacidade para realizar movimentos condizentes com sua idade e capacidade mental.

q0152 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia ortopédica:

Assertiva: na escoliose doença pulmonar restritiva e diminuição da diferença alvéolo-arterial de oxigênio podem estar presentes, bem como hipertensão pulmonar como resultado da compressão da vasculatura pulmonar e hipóxia arterial.

q0153 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia ortopédica:

Assertiva: a reimplantação de extremidades é uma emergência cirúrgica que visa a recuperação funcional. O tempo ideal para reimplantação é de 12 horas para isquemia quente e 24 horas para isquemia fria.

q0154 [V/F]

Paciente masculino, 50 anos, 175 cm de altura e 70 kg será submetido a hepatectomia por metástase hepática de carcinoma colorretal. No intraoperatório, após perda sanguínea de aproximadamente 1,5 L, observa-se PAM 72 mmHg, IC de 3,5 L.min⁻¹.m⁻², SatO₂ 98%, SvO₂ de 55%, lactato 39 mg.dL⁻¹, BE -5,6 mmol.L⁻¹ e Hb 7,0 g.dL⁻¹. Sobre este caso:

Assertiva: Para o cálculo da TEO₂ precisa-se somente dos valores de saturação arterial de oxigênio e da saturação venosa central de oxigênio. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 02/04 – ME3/2023 CCA

q0155 [V/F]

Sobre a anestesia para ortopedia em pacientes com osteogênese imperfeita, julgue:

Assertiva: A osteogênese imperfeita é associada a cardiopatias valvares.

q0156 [V/F]

Paciente chega ao centro cirúrgico para realização, em caráter de emergência, de laparotomia exploradora por ferimento de arma branca durante briga em bar há 30 minutos. Informa ingestão de álcool. Cirurgião não está no hospital. Sobre este caso, julgue:

Assertiva: a técnica anestésica ser empregada deverá ser aquela em que o anestesista tem mais expertise.

q0157 [V/F]

No manuseio anestésico-cirúrgico nas microcirurgias da laringe com laser:

Assertiva: para amenizar o turbilhonamento de ar na ventilação, um aumento no tempo inspiratório torna a insuflação do volume corrente mais lento.

q0158 [V/F]

Avaliando os cenários abaixo em paciente com déficit de plaquetas, indica-se transfusão quando:

Assertiva: profilaxia nas cateterizações venosas centrais, com plaquetas abaixo de 60.000/μL.

q0159 [V/F]

Com relação à anestesia para cirurgia bucomaxilofacial:

Assertiva: fratura complexa do arco zigomático-maxila é classificada como Le Fort III.

q0160 [V/F]

Com relação aos bloqueios de neuroeixo:

Assertiva: os volumes e as capacidades pulmonares são praticamente inalterados nos bloqueios com nível abaixo de T10.

q0161 [V/F]

Sobre anestesia pediátrica.

Assertiva: A função renal é aumentada em recém-nascidos como resultado de seu maior percentual de água, em comparação ao adulto.

q0162 [V/F]

Em relação a anestesia pediátrica, avalie:

Assertiva: a incidência de cefaleia pós-puncção subaracnóideia é maior em crianças que em adultos.

q0163 [V/F]

Com relação à neuroanestesia:

Assertiva: a embolia gasosa paradoxal ocorre em pacientes com forame oval permeável.

q0164 [V/F]

Em relação a anestesia em otorrinolaringologia, observa-se:

Assertiva: a dexametasona administrada durante a amigdalectomia reduz náuseas, vômitos e dor no pós-operatório.

q0165 [V/F]

Com relação às particularidades do recém-nascido prematuro:

Assertiva: a hemoglobina fetal apresenta alta concentração de 2,3-DPG.

q0166 [V/F]

Com base nas recomendações para reposição volêmica em cirurgias abdominais de urgência, avalie as alternativas:

Assertiva: a diurese intraoperatória fisiológica situa-se entre 0,5 e 1 mL/kg/h, sendo volumes fora desse intervalo sinais de disfunção.

q0167 [V/F]

Um paciente de 45 anos, com índice de massa corporal (IMC) de 32 kg/m² e histórico de hipertensão controlada, foi submetido a uma cirurgia de videocolecistectomia laparoscópica. Durante o procedimento, foi insuflado dióxido de carbono (CO₂) para criar um pneumoperitônio com pressão intra-abdominal de 12 mmHg. Após a cirurgia, a equipe médica monitorou cuidadosamente a função renal e hemodinâmica do paciente devido ao risco de complicações associadas ao pneumoperitônio. Sobre os efeitos fisiológicos do pneumoperitônio:

Assertiva: a insuflação de CO₂ durante a laparoscopia está associada a uma absorção mais rápida de bolhas intravasculares em comparação com gases como nitrogênio, argônio ou hélio.

q0168 [V/F]

Sobre a avaliação pré-anestésica:

Assertiva: a folcodina, um antitussígeno, quando utilizada no pré-operatório, está associada ao aumento do risco de reações alérgicas a bloqueadores neuromusculares devido ao desenvolvimento de anticorpos IgE contra esses fármacos.

q0169 [V/F]

Sobre a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA):

Assertiva: tremores (shivering) é fator predisponente para hipertensão.

q0170 [V/F]

Segundo a RESOLUÇÃO CFM N° 2.174/2017, que dispõe sobre a prática do ato anestésico:

Assertiva: é obrigatória a existência de equipamentos com sistemas automáticos de infusão para administração contínua de fármacos vasoativos e anestesia intravenosa contínua.

q0171 [V/F]

Sobre anestesia em obstetrícia:

Assertiva: O nervo pudendo é derivado das raízes nervosas sacrais (S2-S4) e seu bloqueio é útil para tratar a dor durante o segundo estágio do trabalho de parto e para o reparo da episiotomia.

q0172 [V/F]

Com relação aos bloqueios de nervos periféricos:

Assertiva: Os elementos neurais alvos dentro do espaço paravertebral incluem o nervo intercostal (ramo ventral), o ramo dorsal, as comunicações cinza e branca e a cadeia simpática

q0173 [V/F]

Sobre anestesia e sistema cardiovascular.

Assertiva: Hipertensão pulmonar é uma das possíveis indicações para inserção de cateter de artéria pulmonar.

q0174 [V/F]

Sobre anestesia ambulatorial:

Assertiva: venosa ou dor à injeção, é de ação rápida e meia-vida de eliminação relativamente curta cerca de 2 a 4 horas.

q0175 [V/F]

Desde o momento da concepção, inúmeras alterações fisiológicas ocorrem na gestante a fim de adequar o organismo da mulher às necessidades do complexo materno-fetal. Com relação às alterações no sistema hematológico na gestante a termo:

Assertiva: A trombocitopenia da gestação ocorre pela combinação da hemodiluição com a menor meia-vida das plaquetas circulantes. PROVA TRIMESTRAL 03/04 – ME2/2023 CCA

q0176 [V/F]

Sobre a fisiologia cardiovascular:

Assertiva: O reflexo de Bainbridge diminui a frequência cardíaca em resposta ao aumento do volume intravascular.

q0177 [V/F]

As cirurgias urológicas robóticas e videolaparoscópicas tem peculiaridades fisiológicas e técnicas importantes que o anestesista deve saber para proporcionar melhores desfechos para o paciente. São elas:

Assertiva: há risco de enfisema subcutâneo se estendendo para o pescoço e cabeça.

q0178 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia ortopédica:

Assertiva: nas cirurgias de coluna a metadona é cada vez mais utilizada, com doses de 0,2 mg/kg antes da incisão cirúrgica, melhorando o controle da dor.

q0179 [V/F]

Os compostos absorventes de CO₂ usados no circuito anestésico para administração dos agentes inalatórios têm as seguintes características:

Assertiva: o uso de CO₂ para pneumoperitônio e a hipertermia do paciente aumentam a produção de calor e o aquecimento do sistema absorvedor.

q0180 [V/F]

Sobre metodologia científica:

Assertiva: os testes não paramétricos são aqueles que exigem normalidade de distribuição. Os mais conhecidos são os Qui-quadrado, teste da mediana e prova de Kruskal-Wallis.

q0181 [V/F]

Na monitorização perioperatória da coagulação podemos utilizar a tromboelastometria rotacional para direcionar a terapêutica:

Assertiva: 1 - analisa a amplitude de firmeza do coágulo.

q0182 [V/F]

Considerando a classificação dos estabelecimentos (I, II, III, IV) na anestesia ambulatorial que tipo de procedimento poderá ser realizado:

Assertiva: na Unidade tipo II: procedimento com pernoite.

q0183 [V/F]

Desde o momento da concepção, inúmeras alterações fisiológicas ocorrem na gestante a fim de adequar o organismo da mulher às necessidades do complexo materno-fetal. Com relação às alterações no sistema hematológico na gestante a termo:

Assertiva: Os valores de antitrombina III, proteína S e proteína C estão diminuídos.

q0184 [V/F]

Julgue conceitos básicos sobre a farmacologia abaixo.

Assertiva: ordem. , sendo A a função da dose eliminada a cada unidade de tempo e C a função da concentração a cada unidade de tempo.

q0185 [V/F]

Mulher 68 anos, com obesidade moderada, é submetida a uma cirurgia abdominal prolongada em decúbito dorsal. Durante o procedimento, os braços foram posicionados com abdução superior a 90° e não foi empregado suporte lombar adicional. No pós- operatório, o paciente apresenta dor lombar e queixa de parestesias no braço direito. Avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: em pacientes obesos, o uso de suportes adicionais e acolchoamento extra não é necessário, pois o decúbito dorsal garante a estabilidade e a segurança do posicionamento independentemente do peso corporal.

q0186 [V/F]

Com relação aos princípios norteadores do cuidado centrado no paciente em relação a qualidade e segurança.

Assertiva: No gráfico de execução ou controle de qualidade (run chart): Uma “corrida” (run) é uma série de pontos seguidos em um lado da mediana. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 04/04 – ME3/2023 CCA

q0187 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia ortopédica:

Assertiva: nas fraturas de tibia a síndrome compartimental é uma complicação frequente, ocorrendo em 10% a 20% dos casos.

q0188 [V/F]

Sobre os conceitos associados à dor crônica, avalie os itens:

Assertiva: a causa mais comum da Síndrome Complexa de Dor Regional (SCDR) é o trauma, podendo ser gerada após traumas mínimos.

q0189 [V/F]

Sobre o mecanismo da dor no pós-operatório:

Assertiva: a estimulação repetitiva de fibras C, pode levar ao fenômeno de wind-up, um tipo de plasticidade sináptica que causa sensibilização central.

q0190 [V/F]

O médico anestesiológista está exposto a riscos inerentes ao local onde seu trabalho é desenvolvido. Em relação ao risco profissional relacionado à prática anestésica, julgue:

Assertiva: a dose máxima de radiação permitida pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica, expressa em unidades rem (Roentgen equivalente man), corresponde a 120 mrem/semana e 6 rem/ano.

q0191 [V/F]

Neste corte transversal:

Assertiva: a estrutura 7 corresponde à aracnoide.

q0192 [V/F]

Sobre anestesia e obstetrícia.

Assertiva: Estudo de ressonância magnética em voluntárias saudáveis grávidas, o volume da veia cava inferior (VVCI) não difere significativamente entre a posição supina e a de 30° de inclinação para a esquerda, mas com inclinações a 45° o VVCI aumentou.

q0193 [V/F]

Em relação à farmacologia dos anestésicos inalatórios:

Assertiva: a autorregulação cerebral é preservada em 1CAM (concentração alveolar mínima) de sevoflurano.

q0194 [V/F]

Sobre equilíbrio ácido básico e manejo de fluidos e de eletrólitos:

Assertiva: aumento da resistência vascular pulmonar, inibição do metabolismo celular e da regulação do volume celular são consequências da acidemia grave (pH menor que 7,2).

q0195 [V/F]

Sobre os equipamentos para infusão alvo controlada (Target-Controlled-Infusion)- TCI observa-se que:

Assertiva: o Diprifusor é um sistema de infusão de segunda geração.

q0196 [V/F]

Durante a infusão de fármacos para realização de anestesia venosa alvo- controlada aplicam-se conceitos farmacodinâmicos e farmacocinéticos:

Assertiva: quanto menor o $t_{1/2} Ke0$, mais lento será o início de efeito de um fármaco.

q0197 [V/F]

Sobre os procedimentos broncoscópicos comuns e suas considerações anestésicas:

Assertiva: o uso de anestésicos intravenosos é preferido durante alguns procedimentos broncoscópicos porque a instrumentação das vias aéreas pode comprometer a administração de anestésicos inalatórios.

q0198 [V/F]

Sobre os dispositivos supra-glóticos (DSG):

Assertiva: diferente da intubação traqueal, o uso dos DSG não induz o surgimento de disfagia pós-operatória.

q0199 [V/F]

Sobre anestesia ambulatorial:

Assertiva: a responsabilidade do acompanhamento do paciente, após a realização da cirurgia/procedimento até a alta definitiva, é do médico e/ou da equipe médica que realizou a cirurgia/procedimento

q0200 [V/F]

No que se refere a anestesia para cirurgias bucomaxilofaciais, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: pacientes em tratamento de doenças do metabolismo ósseo e oncológicas deverão informar o uso de medicamentos contendo bisfosfonatos, devido à osteonecrose dos maxilares, associada ao uso destes fármacos.

q0201 [V/F]

Sobre o propofol, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: o propofol pode ser utilizado por seus efeitos terapêuticos na hipnose: ansiolítico, antipruriginoso ou antiemético. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 03/04 – ME1/2024 CCA

q0202 [V/F]

Desde o momento da concepção, inúmeras alterações fisiológicas ocorrem na gestante a fim de adequar o organismo da mulher às necessidades do complexo materno-fetal. Com relação às alterações no sistema respiratório na gestante a termo:

Assertiva: O volume de reserva inspiratória está diminuído em 25%. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 03/04 – ME2/2023 CCA

q0203 [V/F]

Sobre equilíbrio ácido básico e manejo de fluidos e de eletrólitos:

Assertiva: o uso de albumina tem demonstrado diferenças clínicas importantes nos desfechos primários do choque séptico.

q0204 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia e procedimentos torácicos:

Assertiva: durante mediastinoscopia é recomendado que o oxímetro de pulso seja posicionado no membro superior esquerdo.

q0205 [V/F]

Uma paciente de 55 anos, com IMC de 30 kg/m² e sem histórico de doenças respiratórias, foi submetida a uma videocolecistectomia laparoscópica. Durante o procedimento, foi utilizada ventilação controlada por volume (VCV) com um volume corrente de 6-8 mL/kg de peso corporal previsto, PEEP e manobras periódicas de recrutamento alveolar. Após a cirurgia, a paciente apresentou atelectasia leve e uma redução na capacidade vital forçada (CVF) no segundo dia pós-operatório. Sobre os efeitos respiratórios intraoperatórios e pós-operatórios da insuflação abdominal e cirurgia laparoscópica:

Assertiva: a insuflação abdominal durante a cirurgia causa um aumento na complacência torácica, facilitando a ventilação.

q0206 [V/F]

Durante uma parada cardiorrespiratória (PCR) e reanimação:

Assertiva: a segunda dose de amiodarona deve ser de 300 miligramas.

q0207 [V/F]

Homem de 52 anos, com IMC 38 kg/m², antecedente de apneia obstrutiva do sono e refluxo gastroesofágico, será submetido a esofagogastroduodenoscopia (EGD) com previsão de mucosectomia gástrica. O exame será realizado fora do centro cirúrgico, com uso de bisturi elétrico. Com base no quadro clínico, avalie as alternativas:

Assertiva: em pacientes com apneia do sono e risco de aspiração, a anestesia geral pode ser preferível à sedação com benzodiazepínicos e opioides.

q0208 [V/F]

Com relação ao risco profissional do anestesiolologista:

Assertiva: centers for disease control and prevention (CDC) recomenda que salas cirúrgicas devam ter pelo menos 15 trocas de ar por hora. Nesse ritmo, levaria 18 minutos até que 99% dos potenciais contaminantes transportados pelo ar sejam removidos.

q0209 [V/F]

Sobre as complicações anestésicas:

Assertiva: história de alergia a frutos do mar contraindica o uso de contrastes iodados.

q0210 [V/F]

Com relação à anestesia e o sistema endócrino:

Assertiva: a fentolamina é um alfabloqueador usado no preparo pré-operatório de pacientes com feocromocitoma que apresenta ação prolongada e não competitiva.

q0211 [V/F]

Sobre as características morfofisiológicas do Sistema Hematopoiético do recém-nascido e da criança, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: são fatores de risco conhecidos para sangramento provocado pela deficiência dos fatores dependentes de vitamina K: prematuridade, uso de cumarínicos, rifampicina, anticonvulsivantes na gestação, aleitamento materno exclusivo prolongado.

q0212 [V/F]

Paciente masculino, 37 anos, previamente hígido, é trazido ao centro cirúrgico após acidente automobilístico apresentando fratura exposta de fêmur. A avaliação da dor foi 10/10, segundo a escala numérica e 15 segundo a Escala de Coma de Glasgow. Seu acompanhante ainda não chegou ao hospital. Julgue as afirmativas seguintes:

Assertiva: Caso este paciente exija uma determinada técnica anestésica que o anestesiolologista julgue inadequada, este não tem obrigação ética de realizá-la.

q0213 [V/F]

Com relação ao risco profissional do anestesiolologista:

Assertiva: radiação não-ionizante do tipo lasers pode causar lesão ocular por exposição direta, mas na sua forma refletida não pode causar lesão.

q0214 [V/F]

Desde o momento da concepção, inúmeras alterações fisiológicas ocorrem na gestante a fim de adequar o organismo da mulher às necessidades do complexo materno-fetal. Com relação às alterações no sistema respiratório na gestante a termo:

Assertiva: A capacidade pulmonar total está aumentada em 30%.

q0215 [V/F]

Com relação a anestesia em urgências no trauma:

Assertiva: uma das vantagens dos testes coagulação tradicionais é que eles são melhores em detectar estado de hipercoagulação que os viscoelásticos.

q0216 [V/F]

Quanto ao equilíbrio ácido-base, avalie:

Assertiva: a produção diária de H⁺ no organismo é feita sob a forma de ácido carbônico, não volátil que vem do metabolismo oxidativo de carboidratos e lipídios, e de ácidos fixos (voláteis).

q0217 [V/F]

Nos estudos transversais:

Assertiva: a análise dos dados é feita em vários momentos.

q0218 [V/F]

Sobre gerenciamento do centro cirúrgico:

Assertiva: as informações qualitativas (como por exemplo a ginecologista que opera toda sexta pediu licença maternidade de 3 meses) devem ser usadas para atualizar as previsões de carga de trabalho, não em um processo ad hoc de conversão da carga de trabalho em alocações de salas de operação.

q0219 [V/F]

São critérios amarelos de moderado risco de gravidade em lesões traumáticas em adultos, segundo o National guideline for the field triage of trauma patients americano?

Assertiva: Colisão de automóvel com ejeção completa da vítima.

q0220 [V/F]

Sobre a técnica de infiltração tumescente:

Assertiva: é comum associar epinefrina à solução.

q0221 [V/F]

Com relação ao risco profissional do anestesiológico:

Assertiva: bisturis ultrassônicos podem produzir células viáveis na pluma de fumaça cirúrgica, incluindo células malignas.

q0222 [V/F]

Com relação aos conceitos de ventilação mecânica:

Assertiva: na ventilação com pressão de suporte, a inspiração é geralmente encerrada pela diminuição de fluxo de gás.

q0223 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia ortopédica:

Assertiva: na artroplastia de quadril o uso de próteses cimentadas deve ser considerado em pacientes de alto risco para embolia, visando reduzir complicações hemodinâmicas.

q0224 [V/F]

Considerando o mecanismo de reparação vascular e as características físicas e químicas das plaquetas, avalie as seguintes afirmações:

Assertiva: As plaquetas, ao entrarem em contato com uma superfície vascular danificada, não alteram suas características nem aderem ao colágeno exposto na parede do vaso.

q0225 [V/F]

Sobre os bloqueios periféricos da face:

Assertiva: o nervo trigêmeo é predominantemente um nervo sensorial, mas também carrega fibras motoras que são responsáveis pelos músculos da mastigação.

q0226 [V/F]

Sobre complicações na anestesia:

Assertiva: a maioria dos pacientes com história de alergia à penicilina tem IgE detectável para penicilina.

q0227 [V/F]

Segundo a RESOLUÇÃO CFM N° 2.174/2017, que dispõe sobre a prática do ato anestésico:

Assertiva: a alta da SRPA é de responsabilidade exclusiva de um médico anestesista ou do plantonista da SRPA.

q0228 [V/F]

Os estudos de coorte:

Assertiva: retrospectivos têm o mesmo ponto forte que os prospectivos

q0229 [V/F]

Para a realização do bloqueio do nervo safeno no canal dos adutores, é importante conhecer a anatomia da região. A respeito da anatomia mostrada na imagem:

Assertiva: Na imagem, o nervo encontra-se à direita da artéria.

q0230 [V/F]

Quanto aos critérios de alta da Sala de Recuperação Pós-Anestésica:

Assertiva: recebe nota 2 no IAK modificado, pressão arterial correspondendo 20% do valor pré-anestésico.

q0231 [V/F]

Sobre a ressuscitação cardiopulmonar:

Assertiva: o ETCO₂ durante a RCP se correlaciona com a pressão de perfusão coronária, débito cardíaco, ressuscitação inicial e sobrevida.

q0232 [V/F]

Sobre os sistemas e aparelhos para administração de agentes inalatórios:

Assertiva: os vaporizadores de desvio variável fornecem uma concentração constante do anestésico dependendo da temperatura ou do fluxo que passe pelo vaporizador.

q0233 [V/F]

Sobre os anestésicos inalatórios:

Assertiva: pode comprometer a patência das vias aéreas superiores.

q0234 [V/F]

Homem, 48 anos, 70 kg, 170cm, deu entrada no centro cirúrgico com extensas queimaduras face, pescoço e tórax há 72 h, será submetido a desbridamento e curativo das queimaduras, apresentou aproximadamente 50% de superfície corporal queimada. Segue a figura, após a indução anestésica. Sobre anestesia para cirurgia plástica no paciente queimado, responda:

Assertiva: durante a fase hiperdinâmica, a eliminação de todos os fármacos é reduzida devido ao aumento da perfusão hepática e renal.

q0235 [V/F]

Sobre o Estatuto da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA):

Assertiva: é vetada a associação de estudantes de medicina à SBA.

q0236 [V/F]

Sobre as síndromes dolorosas crônicas:

Assertiva: A incidência do herpes zoster é maior em crianças e adultos jovens. Frequentemente há recorrência e não há diferença entre os sexos ou racial na incidência. A Síndrome Complexa de Dor Regional (SCDR) geralmente ocorre após uma lesão, tem localização

q0237 [V/F]

Sobre anestesia pediátrica.

Assertiva: A dose necessária para administração intravenosa de succinilcolina em lactentes (2,0 mg/kg) é aproximadamente o dobro das crianças mais velhas (1,0 mg/kg).

q0238 [V/F]

Com relação a procedimentos ambulatoriais, analise as alternativas:

Assertiva: criança com 3 meses de idade, nasceu com 30 semanas, encaminhada para realização de sondagem de vias lacrimais em regime ambulatorial. Sua conduta deve ser encaminhar para procedimento com internação devido ao risco de apnéia.

q0239 [V/F]

Quanto ao emprego do CPDA-1 (citrato fosfato dextrose adenina – 1) que é um anticoagulante do sangue estocado, podemos afirmar:

Assertiva: o citrato previne a formação de coágulos por se ligar ao cálcio.

q0240 [V/F]

O eletrocardiograma faz parte do risco cardiovascular que compõe uma avaliação pré- anestésica. A respeito desse exame:

Assertiva: bloqueio de ramo direito deve ser avaliado na suspeita de doença cardíaca estrutural ou síndrome de Brugada. PROVA TRIMESTRAL 01/04 – ME1/2023 CCA

q0241 [V/F]

Sobre os sistemas e aparelhos para administração de agentes inalatórios:

Assertiva: o fluxo da válvula de oxigênio direto deve ser fornecido à saída comum dos gases, sem passar pelo vaporizador, e pode variar entre 35 e 75 L.min⁻¹ medidos à pressão atmosférica.

q0242 [V/F]

Sobre a fisiologia da transmissão neuromuscular e o uso de bloqueadores neuromusculares:

Assertiva: nos idosos o número de receptores juncionais diminuem e aumentam a proliferação dos extrajuncionais.

q0243 [V/F]

Com base nas recomendações para reposição volêmica em cirurgias abdominais de urgência, avalie as alternativas:

Assertiva: a principal causa de diurese aumentada no intraoperatório é o bloqueio simpático promovido pela anestesia.

q0244 [V/F]

Sobre anestesia em obstetrícia:

Assertiva: O consumo de O₂ está aumentado no primeiro estágio do trabalho de parto, no entanto se reduz no segundo.

q0245 [V/F]

A gravidez resulta em alterações significativas em vias aéreas superiores, volumes pulmonares, ventilação, consumo de O₂ e taxa metabólica. Sobre as alterações fisiológicas respiratórias da gestação:

Assertiva: Durante a gestação, a curva de dissociação da oxiemoglobina materna se desloca para a direita, enquanto a curva de dissociação da oxiemoglobina fetal se encontra à esquerda.

q0246 [V/F]

Sobre a fisiologia da transmissão neuromuscular e o uso dos bloqueadores neuromusculares:

Assertiva: o bloqueio neuromuscular fase II é decorrente da ação de succinilcolina sobre os receptores da acetilcolina extra-juncionais.

q0247 [V/F]

Sobre os anestésicos venosos:

Assertiva: o propofol causa depressão da reatividade das vias aéreas, favorecendo a sua instrumentação e a colocação de prótese respiratória ou máscara laríngea.

q0248 [V/F]

Julgue conceitos básicos sobre a farmacologia abaixo.

Assertiva: Em , $A(t)$ representa uma função de dose eliminada de cinética de segunda

q0249 [V/F]

Em relação a fisiologia e farmacologia do sistema urinário, avalie:

Assertiva: no rim, um exemplo de transporte ativo secundário é a endocitose. Tal processo, é responsável pela reabsorção tubular de proteínas.

q0250 [V/F]

De acordo com as zonas de West, na posição ereta, considerando que PA = pressão alveolar; Ppa = pressão da artéria pulmonar; e Ppv=pressão na veia pulmonar:

Assertiva: zona 1 = $PA > Ppa = Ppv$

q0251 [V/F]

Alguns conhecimentos são fundamentais para se iniciar uma pesquisa científica:

Assertiva: a instituição que possui uma comissão de ética médica encontra-se autorizada a aprovar os projetos de pesquisa.

q0252 [V/F]

Sobre a ressuscitação cardiopulmonar:

Assertiva: o fluxo sanguíneo miocárdico crítico está associado à pressão diastólica aórtica superior a 70 mmHg.

q0253 [V/F]

Sobre a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA):

Assertiva: paciente deve apresentar escore de Aldrete 10 para alta da SRPA.

q0254 [V/F]

Sobre a ressuscitação cardiopulmonar:

Assertiva: são recomendadas 30 compressões torácicas seguidas de 2 respirações com pausas não superiores a 1 minuto entre ambas quando não há via aérea avançada.

q0255 [V/F]

Sobre os bloqueios de parede abdominal e membros inferiores:

Assertiva: O TAP block é realizado com a injeção de anestésico local entre os músculos oblíquo interno e transverso do abdome.

q0256 [V/F]

Com relação a anestesia em urgências no trauma:

Assertiva: durante a ressuscitação de pacientes politraumatizados hipotensos deve-se evitar hipotensão arterial, tendo como meta manter uma pressão arterial normal até que o controle cirúrgico do sangramento seja realizado.

q0257 [V/F]

Julgue os seguintes conceitos relacionados ao gerenciamento do centro cirúrgico:

Assertiva: a carga de utilização de uma sala operatória é a soma das durações dos casos realizados na mesma, incluindo giros de sala.

q0258 [V/F]

Avaliando os cenários abaixo em paciente com déficit de plaquetas, indica-se transfusão quando:

Assertiva: paciente com hemorragia cerebral aguda e contagem de plaquetas em 90.000/ μ L.

q0259 [V/F]

Sobre avaliação e preparo pré-anestésico:

Assertiva: pacientes com insuficiência renal significativa (taxa de filtração glomerular estimada < 30 mL/min) devem preferencialmente receber heparina não fracionada intravenosa como terapia de ponte.

q0260 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia plástica:

Assertiva: o metabolismo oxidativo hepático (reações de fase I) pode estar prejudicado em pacientes queimados, enquanto reações de conjugação (fase II), como a glicuronidação, permanecem inalteradas.

q0261 [V/F]

Sobre a mecânica respiratória e controle da respiração, julgue os itens:

Assertiva: o gradiente transtorácico é a diferença entre o espaço pleural e a superfície corpórea, correspondendo à pressão de abertura das vias aéreas.

q0262 [V/F]

Sobre a fisiologia do sistema cardiocirculatório e os reflexos cardíacos:

Assertiva: em condições de PaO₂ baixa e acidose, o reflexo quimiorreceptor ativa o seio de Hering ativando a sistema simpático levando ao aumento da frequência cardíaca e da contratilidade miocárdica.

q0263 [V/F]

Paciente de 43 anos, sexo masculino, previamente hígido, teve perda súbita de visão, astenia e episódios recorrentes de hipoglicemia e foi diagnosticado com tumor hipofisário grande, de 3cm de diâmetro. Cortisol sérico de 0,5mcg/dL (valor de referência: 5-25mcg/dL). Será submetido à cirurgia para exérese do tumor. A respeito desse caso, responda os itens.

Assertiva: deve ser feita monitorização da glicemia no período intra-operatório, uma vez que o paciente tem maior risco de hipoglicemia.

q0264 [V/F]

Sobre anestesia para obstetrícia, responda:

Assertiva: o tônus muscular uterino não é afetado pelos relaxantes musculares esquelético e, em doses padrão, todas as classes de relaxantes musculares são pobremente transferidos para o feto.

q0265 [V/F]

Sobre os dispositivos supra-glóticos (DSG):

Assertiva: são contraindicados em cenários clínicos com risco aumentado de regurgitação, alta resistência das vias aéreas, obstrução glótica ou subglótica e abertura bucal limitada (<1,5 cm).

q0266 [V/F]

O eletrocardiograma faz parte do risco cardiovascular que compõe uma avaliação pré- anestésica. A respeito desse exame:

Assertiva: bloqueios de ramos isoladamente indicam aumento do risco cardiovascular.

q0267 [V/F]

Quanto às complicações na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA):

Assertiva: os sinais da broncoaspiração grave incluem broncoespasmo, hipoxemia, atelectasia, taquipneia, taquicardia e hipotensão.

q0268 [V/F]

No manuseio dos pacientes em cirurgias cardíacas:

Assertiva: a prevenção de taquicardia na estenose aórtica é meta hemodinâmica para evitar isquemia miocárdica

q0269 [V/F]

Sobre a organização da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA):

Assertiva: a Diretoria da SBA reunir-se-á, no mínimo, a cada três meses, podendo reunir-se extraordinariamente cada vez que o Diretor Presidente considerar necessário, ou a pedido de, pelo menos, 04 (quatro) de seus membros.

q0270 [V/F]

Os estudos de coorte:

Assertiva: não é indicado para o estudo de doenças raras.

q0271 [V/F]

Sobre a farmacologia geral:

Assertiva: Histerese refere-se ao atraso temporal entre as mudanças na concentração plasmática e no efeito do medicamento

q0272 [V/F]

Um paciente de 45 anos, com índice de massa corporal (IMC) de 32 kg/m² e histórico de hipertensão controlada, foi submetido a uma cirurgia de videocolecistectomia laparoscópica. Durante o procedimento, foi insuflado dióxido de carbono (CO₂) para criar um pneumoperitônio com pressão intra-abdominal de 12 mmHg. Após a cirurgia, a equipe médica monitorou cuidadosamente a função renal e hemodinâmica do paciente devido ao risco de complicações associadas ao pneumoperitônio. Sobre os efeitos fisiológicos do pneumoperitônio:

Assertiva: em pacientes obesos mórbidos, o pneumoperitônio pode ter um efeito hemodinâmico menos pronunciado em comparação com pacientes não obesos.

q0273 [V/F]

Durante uma parada cardiorrespiratória (PCR) e reanimação:

Assertiva: a amiodarona deve ser administrada imediatamente após o primeiro choque.

q0274 [V/F]

Quanto ao posicionamento dos pacientes durante a cirurgia:

Assertiva: compressão nervosa durante a posição de litotomia que cursa com pé caído corresponde à lesão de nervo tibial e geralmente se resolvem dentro de 6 meses.

q0275 [V/F]

Homem de 58 anos, submetido a uma artroplastia total de joelho, recebeu ácido tranexâmico como medida profilática para reduzir o sangramento intraoperatório. Avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: agentes farmacológicos, como ácido tranexâmico, atuam bloqueando os sítios de ligação de lisina do plasminogênio, estabilizando os coágulos ao inibir a ação da plasmina.

q0276 [V/F]

Na anestesia para amigdalectomias observa-se:

Assertiva: em crianças com apneia obstrutiva do sono moderada a grave, há maior risco de hipoventilação no pós-operatório.

q0277 [V/F]

Sobre avaliação e preparo pré-anestésico:

Assertiva: o escore MELD (Modelo para doença hepática em estágio final) é usado para prever o risco perioperatório em pacientes com hepatite crônica ou cirrose, e um escore MELD de 15 ou mais indica um risco aumentado.

q0278 [V/F]

No que se refere a anestesia para cirurgias bucomaxilofaciais, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: a angina de Ludwig é considerada o exemplo clássico de uma celulite infecciosa aeróbica de excelente prognóstico.

q0279 [V/F]

Paciente sexo masculino 50 anos, hipertenso, tabagista pesado (40 cigarros/dia) será submetido a uma gastrectomia. Avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: a ventilação do espaço morto pode estar bastante aumentada neste paciente.

q0280 [V/F]

Complicações pulmonares pós-operatórias são uma importante causa de morbimortalidade hospitalar após grandes cirurgias. Com relação às estratégias protetoras de ventilação mecânica intraoperatória:

Assertiva: a presença de sonda nasogástrica é fator de risco para complicações pulmonares pós-operatórias.

q0281 [V/F]

No que se refere a hipoxemia na Sala de Recuperação Pós-anestésica:

Assertiva: em adultos que apresentam falência respiratória aguda hipoxêmica (tipo 1), altos fluxos de oxigênio através de cateter nasal não oferecem nenhum benefício quando comparados à ventilação mecânica.

q0282 [V/F]

Avaliando os cenários abaixo em paciente com déficit de plaquetas, indica-se transfusão quando:

Assertiva: profilaxia para inserção ou remoção de cateter peridural quando a contagem de plaquetas estiver em 95.000/ μ L.

q0283 [V/F]

Sobre o mecanismo da dor no pós-operatório:

Assertiva: as fibras A delta mielinizadas conduzem dor aguda e bem localizada.

q0284 [V/F]

Analise as afirmativas a seguir sobre as alterações cardiovasculares na gestação:

Assertiva: a resistência vascular sistêmica e pulmonar aumentam em torno de 20% devido à redução dos níveis de prostaciclina. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 03/04 – ME2/2025 CCA

q0285 [V/F]

Desde o momento da concepção, inúmeras alterações fisiológicas ocorrem na gestante a fim de adequar o organismo da mulher às necessidades do complexo materno-fetal. Com relação às alterações no sistema hematológico na gestante a termo:

Assertiva: A concentração dos fatores de coagulação II e V está inalterada.

q0286 [V/F]

Sobre a avaliação pré-operatória:

Assertiva: asma, gasometria arterial e espirometria pulmonar não são preditores confiáveis de complicações pulmonares perioperatórias.

q0287 [V/F]

O manuseio de doadores de órgão antes da captação deve seguir:

Assertiva: manutenção do volume intravascular adequado, pois é a medida mais apropriada para a vasoplegia.

q0288 [V/F]

Sobre a farmacologia geral das drogas anestésicas:

Assertiva: o enantiômero R(-) da cetamina é mais potente do que a forma S(+) e também tem menor probabilidade de produzir delírio ao despertar.

q0289 [V/F]

Com relação ao bloqueio demonstrado nas imagens abaixo, assinale V ou F.

Assertiva: a estrutura A corresponde a artéria subclávia.

q0290 [V/F]

Paciente chega ao centro cirúrgico para realização, em caráter de emergência, de laparotomia exploradora por ferimento de arma branca durante briga em bar há 30 minutos. Informa ingestão de álcool. Cirurgião não está no hospital. Sobre este caso, julgue:

Assertiva: a não realização de indução em sequência rápida configura ato de imperícia.

q0291 [V/F]

Sobre a farmacologia dos anestésicos inalatórios:

Assertiva: O metabolismo do sevoflurano resulta na formação de proteínas hepáticas trifluoroacetiladas com potencial para produzir hepatotoxicidade, bem como sensibilidade cruzada entre as drogas.

q0292 [V/F]

Quanto à classificação de Child-Pugh para a avaliação da função hepática:

Assertiva: creatinina acima de 3 mg.dL⁻¹ é um dos critérios para classificação tipo C.

q0293 [V/F]

Sobre a anestesia para cirurgia ortopédica, julgue:

Assertiva: A monitorização neurofisiológica é indicada em cirurgias de coluna, mas é contraindicada em correção de deformidades da coluna, ressecção de tumores intramurais ou traumas assustadores da coluna.

q0294 [V/F]

Sobre a ressuscitação cardiopulmonar:

Assertiva: a intubação não deve ser realizada até que a ventilação adequada por outros meios, a circulação por compressões torácicas tenham sido estabelecidas e a desfibrilação realizada, se apropriado.

q0295 [V/F]

Em relação ao Monitoramento da Pressão Arterial e Análise de Onda para Previsão da Responsividade ao Volume:

Assertiva: durante a inspiração em ventilação mecânica positiva, o aumento da pressão intratorácica reduz tanto a pré-carga do ventrículo esquerdo quanto o pós-carga.

q0296 [V/F]

Um paciente de 65 anos com doença arterial periférica foi submetido a uma cirurgia de revascularização do membro inferior. Durante a cirurgia, houve perda sanguínea significativa, resultando na necessidade de transfusão maciça de sangue e reposição volêmica. Para auxiliar na reposição volêmica, o anestesiológista optou por usar dextran de baixo peso molecular, além de soluções cristaloides.

Assertiva: As moléculas de dextran de maior peso molecular são excretadas no trato gastrointestinal ou absorvidas pelo sistema fagocítico mononuclear, onde são degradadas por dextranases endógenas.

PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 02/04 – ME2/2023 CCA

q0297 [V/F]

Sobre disfunção tireoideana perioperatória:

Assertiva: anemia, trombocitopenia, aumento da fosfatase alcalina, hipercalcemia, perda de massa muscular e perda óssea ocorrem no hipotireoidismo.

q0298 [V/F]

Sobre as características estruturais do canal de Na⁺ que determinam as interações com anestésicos locais (AL):

Assertiva: a abertura do canal resulta do movimento primário dos segmentos S4 carregados positivamente em resposta à despolarização da membrana.

q0299 [V/F]

Na anestesia para amigdalectomias observa-se:

Assertiva: a analgesia multimodal é a estratégia preferida para controle da dor após amigdalectomia em crianças.

q0300 [V/F]

Quanto ao tema anestesia e infecção:

Assertiva: infecção incisional profunda envolve o tecido mais profundo (fáscia, músculos), está relacionada à cirurgia realizada e seu início precisa ser dentro de 30 dias a 90 dias após a cirurgia.

q0301 [V/F]

Sobre os conceitos fisiológicos do manejo de vias aéreas:

Assertiva: a pré-oxigenação pode ser realizada utilizando-se ventilação de volume corrente através da máscara facial por 3 minutos, o que permite a troca de 95% do gás nos pulmões.

q0302 [V/F]

No que se refere ao suporte ventilatório:

Assertiva: o fluxo inspiratório equivale ao volume corrente desejado dividido pelo tempo expiratório.

q0303 [V/F]

Sobre gerenciamento do centro cirúrgico:

Assertiva: o uso secundário de dados do prontuário eletrônico de saúde pode ser compreendido pelo modelo DIKW (Dados–Informação–Conhecimento– Sabedoria), orientando mudanças de prática.
PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 04/04 – ME3/2025 CCA

q0304 [V/F]

Neste corte transversal:

Assertiva: a estrutura 6 corresponde à dura-máter.

q0305 [V/F]

Paciente foi submetido a raquianestesia para realização de desbridamento cirúrgico de membros inferiores a nível ambulatorial. Fazem parte dos critérios de alta hospitalar:

Assertiva: deve estar bem orientado e com andar firme para receber pontuação máxima.

q0306 [V/F]

Julgue os seguintes conceitos relacionados ao gerenciamento do centro cirúrgico:

Assertiva: a diferença entre o horário planejado de início e de fim de atividades eletivas para a sala operatória nos dias úteis da semana é definido como "tempo alocado de uma sala operatória".

q0307 [V/F]

Com relação às particularidades anestésicas na cirurgia para correção de hérnia diafragmática congênita, deve-se:

Assertiva: aferir saturação arterial de oxigênio no braço direito, refletindo saturação pré-ductal.

q0308 [V/F]

Julgue:

Assertiva: A redução dos tempos de troca entre cirurgias ou atrasos no início do primeiro caso do dia geralmente resultam em aumentos significativos na produtividade do grupo de anestesia.

q0309 [V/F]

Em relação ao Eletroencefalograma Processado (EEG):

Assertiva: a transformação de Fourier do EEG não é utilizada para resumir o sinal em termos de probabilidade.

q0310 [V/F]

Com relação a anestesia para geriatria, assinale V ou F.

Assertiva: À medida que o sistema respiratório envelhece, os pulmões tornam-se mais complacentes.

q0311 [V/F]

Em anestesia para amigdalectomia, observa-se que:

Assertiva: salbutamol no pré-operatório é indicado nos pacientes com história de asma.

q0312 [V/F]

Na vigência de isquemia cerebral, a hipotermia induzida:

Assertiva: diminui a permeabilidade de barreira hematoencefálica.

q0313 [V/F]

Paciente de 43 anos, sexo masculino, previamente hígido, teve perda súbita de visão, astenia e episódios recorrentes de hipoglicemia e foi diagnosticado com tumor hipofisário grande, de 3cm de diâmetro. Cortisol sérico de 0,5mcg/dL (valor de referência: 5-25mcg/dL). Será submetido à cirurgia para exérese do tumor. A respeito desse caso, responda os itens.

Assertiva: o hipnótico de escolha é o etomidato, por ter melhor estabilidade cardiovascular.

q0314 [V/F]

Você irá fazer um bloqueio periconal para realização de uma retinopexia e deseja acinesia completa do olho e da pálpebra, com relação a este bloqueio podemos afirmar:

Assertiva: o bloqueio do IV nervo craniano promove acinesia do músculo reto lateral.

q0315 [V/F]

Sobre suporte ventilatório.

Assertiva: A pressão motriz (driving pressure) representa a mudança no volume na capacidade vital pulmonar.

q0316 [V/F]

Sobre anestesia em procedimentos torácicos:

Assertiva: a necessidade de ventilação monopulmonar é maior na cirurgia torácica videoassistida do que na toracotomia aberta.

q0317 [V/F]

Em relação a fisiologia e farmacologia do sistema urinário, avalie:

Assertiva: a reabsorção de sódio nas porções finas ascendente e espessa da AH aumenta a osmolaridade do interstício em relação ao lúmen tubular.

q0318 [V/F]

Sobre farmacologia geral:

Assertiva: as enzimas microsossomais hepáticas, que participam do metabolismo de muitos medicamentos, estão localizadas principalmente nas mitocôndrias. Essas enzimas microsossomais também estão presentes nos rins, trato gastrointestinal e córtex adrenal.

q0319 [V/F]

Sobre anestesia ambulatorial:

Assertiva: Miringotomia bilateral e timpanoplastia são cirurgias compatíveis com cuidados pós-operatórios complexos, por isso devem ser evitados no regime ambulatorial.

q0320 [V/F]

Desde o momento da concepção, inúmeras alterações fisiológicas ocorrem na gestante a fim de adequar o organismo da mulher às necessidades do complexo materno-fetal. Com relação às alterações no sistema respiratório na gestante a termo:

Assertiva: A ventilação minuto está aumentada em 10%.

q0321 [V/F]

Sobre o choque séptico:

Assertiva: pode ocorrer uma diminuição global da contratilidade cardíaca com redução do transporte de O₂ aos tecidos.

q0322 [V/F]

Com relação ao bloqueio demonstrado nas imagens abaixo, assinale V ou F.

Assertiva: a estrutura C corresponde a pleura.

q0323 [V/F]

Quanto aos anestésicos locais (AL):

Assertiva: AL do grupo dos aminoésteres são hidrolizados no plasma através da enzima colinesterase com exceção da cocaína.

q0324 [V/F]

Sobre os anestésicos venosos:

Assertiva: na indução anestésica com propofol, podem aparecer algumas alterações do tipo contrações tônico-clônicas, que parecem estar relacionadas ao antagonismo à glicina. PROVA TRIMESTRAL 03/04 – ME1/2025 CCA

q0325 [V/F]

Sobre as complicações anestésicas:

Assertiva: estudos clínicos em cirurgia cardíaca sugerem que a cetamina reduz a incidência de IRA pós-operatória.

q0326 [V/F]

Quanto aos benzodiazepínicos:

Assertiva: o anel imidazólico confere ao midazolam uma estrutura química única dentre os benzodiazepínicos, contribuindo com a alcalinidade da sua solução e sua estabilidade em solução aquosa.

q0327 [V/F]

Sobre anestesia ambulatorial:

Assertiva: a alta hospitalar em regime ambulatorial deve ser dada pelo médico anestesiológista ou pelo cirurgião ou por médicos por eles designados.

q0328 [V/F]

Com relação ao risco de aspiração pulmonar perioperatória, julgue os itens:

Assertiva: A presença de sonda nasogástrica é fator de risco.

q0329 [V/F]

Com relação ao atendimento anestésico do paciente vítima de trauma:

Assertiva: uma das metas do tratamento inicial do paciente vítima de traumatismo cranioencefálico (TCE) é manter a pressão de perfusão cerebral acima de 70mmHg.

q0330 [V/F]

Sobre anestesia para litotripsia extracorpórea:

Assertiva: os bloqueios subaracnóideo e peridural podem ser utilizados, sendo que o nível do bloqueio necessário deve ser T10.

q0331 [V/F]

Neste corte transversal:

Assertiva: a estrutura 9 corresponde ao ligamento longitudinal posterior. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 04/04 – ME1/2024 CCA

q0332 [V/F]

Com relação ao risco profissional do anestesiológista:

Assertiva: o abuso de anestésicos inalatórios representa aproximadamente 20% a 50% de substâncias abusadas entre anestesistas. PROVA TRIMESTRAL 01/04 – ME1/2024 CCA

q0333 [V/F]

De acordo com o gráfico abaixo responda:

Assertiva: em 1 encontram-se os anestésicos inalatórios de baixa solubilidade.

q0334 [V/F]

Em relação ao fluxo sanguíneo renal é correto afirmar:

Assertiva: a autorregulação mantém o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular constantes.

q0335 [V/F]

De acordo com as zonas de West, na posição ereta, considerando que PA = pressão alveolar; Ppa = pressão da artéria pulmonar; e Ppv=pressão na veia pulmonar:

Assertiva: zona 1 = $PA < Ppa = Ppv$

q0336 [V/F]

Sobre o íon potássio, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: alterações do bicarbonato sérico, mesmo sem alterações do pH, levam a modificações da distribuição transcelular do potássio.

q0337 [V/F]

Em relação aos anestésicos inalatórios, avalie as afirmações abaixo:

Assertiva: em relação ao mecanismo de vasoconstrição pulmonar hipóxica, seu efeito máximo é atingido quando a tensão alveolar de oxigênio atinge 30mmHg.

q0338 [V/F]

Com relação à anestesia na paciente gestante:

Assertiva: durante o segundo trimestre da gestação ocorre aumento da resistência vascular sistêmica, devido à ação das prostaciclina.

q0339 [V/F]

Em estudos animais há relatos de disfunção renal decorrente da interação do sevoflurano com os absorvedores de dióxido de carbono da cal sodada, os chamados Compostos A. Fatores que favorecem a produção de Composto A:

Assertiva: absorvedores livres de NaOH e KOH.

q0340 [V/F]

Sobre a ressuscitação cardiopulmonar:

Assertiva: os radicais livres de oxigênio contribuem significativamente para a lesão de reperfusão cerebral, portanto, a oxigenoterapia pós ressuscitação deve ser titulada para manter saturação acima de 98%.

q0341 [V/F]

Sobre anestesia ambulatorial:

Assertiva: unidade ambulatorial do tipo I é o local destinado à realização de procedimentos clínicos ou diagnósticos, sob anestesia local, em dose inferior a 5,5 mg/kg de lidocaína (ou dose equipotente de outros anestésicos locais) sem necessidade de internação.

q0342 [V/F]

Com base nas propriedades farmacológicas dos anestésicos locais, avalie as alternativas:

Assertiva: a hidrofobicidade do anestésico local é um dos principais determinantes da sua potência intrínseca, por facilitar sua penetração na membrana neural.

q0343 [V/F]

Sobre as estratégias para prevenir o laringoespasma no momento da extubação, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: extubação em plano profundo (não recomendado em crianças).

q0344 [V/F]

Na vigência de isquemia cerebral, a hipotermia induzida:

Assertiva: produz um balanço positivo entre oferta e consumo de oxigênio cerebral.

q0345 [V/F]

Sobre disfunção tireoideana perioperatória:

Assertiva: propiltiouracil e metimazol diminuem a síntese de T4 e reduzem os níveis de anticorpo do receptor de TSH.

q0346 [V/F]

Sobre anestesia venosa:

Assertiva: fatores étnicos tem mínima relevância na farmacocinética e farmacodinâmica das drogas anestésicas e, por conta disso, não são contemplados nos modelos amplamente utilizados.

q0347 [V/F]

Julgue os seguintes conceitos relacionados ao gerenciamento do centro cirúrgico:

Assertiva: o tempo subutilizado de uma sala operatória é a diferença entre o tempo alocado de uma sala operatória e a carga de utilização da mesma sala.

q0348 [V/F]

Sobre os anestésicos inalatórios:

Assertiva: não deprimem os quimiorreceptores periféricos e os reflexos excitatórios hipóxicos.

q0349 [V/F]

Em relação ao Eletroencefalograma Processado (EEG):

Assertiva: o algoritmo BIS identifica exclusivamente um EEG anestesiado.

q0350 [V/F]

Paciente do sexo feminino, 85 anos, 160cm e 50kg foi submetida a toracotomia para segmentectomia pulmonar sob anestesia geral e epidural contínua. Evolui 48h após a cirurgia com paraplegia. Sobre este caso responda:

Assertiva: a tomografia computadorizada é o método de diagnóstico por imagem de escolha para situações de emergência pois permite uma avaliação rápida e não invasiva da coluna vertebral e da medula em todos os planos.

q0351 [V/F]

No manuseio dos pacientes em cirurgias cardíacas:

Assertiva: o uso de antifibrinolíticos análogos da lisina está indicado nas cirurgias com circulação extracorpórea.

q0352 [V/F]

Sobre a ética aplicada à prática do anestesiológico, responda:

Assertiva: situações que exijam procedimentos cirúrgicos em caráter de urgência desobrigam a necessidade da aplicação do TCLE.

q0353 [V/F]

Com relação à anestesia inalatória:

Assertiva: potencializa a formação do composto A se administração de isoflurano em baixo fluxo.

q0354 [V/F]

Um paciente adulto é possível candidato a doação de órgãos quando além de um coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinal e apneia persistente, apresenta:

Assertiva: observação hospitalar de pelo menos 2h.

q0355 [V/F]

Você foi escalado para anestésias uma paciente de 80 anos, que será submetida a uma colecistectomia videolaparoscópica, seu staff apresenta um gráfico e orienta a levar em consideração as alterações ali apresentadas quando for realizar a ventilação mecânica. Diante disso, com o envelhecimento, podemos afirmar que:

Assertiva: a capacidade de fechamento pode exceder a capacidade residual funcional, levando a atelectasias.

q0356 [V/F]

Com relação aos princípios norteadores do cuidado centrado no paciente relacionados a qualidade e segurança:

Assertiva: está com baixo desempenho é porque ele foi involuntariamente projetado para ter um desempenho inferior. Se este é o caso, é nossa responsabilidade gerenciar o sistema para obter os resultados que queremos.

q0357 [V/F]

Sobre complicações na anestesia:

Assertiva: mulheres são mais sensíveis a bloqueadores neuromusculares despolarizantes que homens nos testes de puntura.

q0358 [V/F]

Sobre anestesia em ortopedia:

Assertiva: cirurgias de coluna, são classificadas como de risco cirúrgico intermediário, com uma incidência de morte cardíaca ou infarto do miocárdio em 30 dias ocorrendo entre 1% a 5% e medições perioperatórias de troponina devem ser consideradas para avaliar eventos cardíacos perioperatórios.

q0359 [V/F]

Sobre a cirurgia do ouvido médio, mastoide e ouvido interno:

Assertiva: estiramento do plexo braquial ou da coluna cervical são complicações do posicionamento do paciente nas cirurgias do ouvido.

q0360 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia plástica:

Assertiva: lipoaspirações maiores que 150 ml a recomendação atual é a utilização da técnica seca por diminuir as perdas sanguíneas e a dor no pós-operatório.

q0361 [V/F]

Sobre a farmacologia e os efeitos dos bloqueadores neuromusculares (BNMs) na anestesia:

Assertiva: a succinilcolina é caracterizada por um rápido início de efeito e duração de ação ultracurta devido à sua rápida hidrólise pela acetilcolinesterase na junção neuromuscular.

q0362 [V/F]

Com relação aos bloqueios oculares:

Assertiva: a hialuronidase reduz a latência e duração do anestésico local.

q0363 [V/F]

Sobre anestesia em ortopedia:

Assertiva: pacientes com artrite reumatoide requerem considerações anestésicas especiais devido à limitação do movimento da articulação temporomandibular, instabilidade atlantoaxial e abertura estreita da glote.

q0364 [V/F]

Em relação ao Monitoramento da Pressão Arterial e Análise de Onda para Previsão da Responsividade ao Volume:

Assertiva: indicadores estáticos de pré-carga, como a pressão venosa central (PVC), têm limitações e potenciais confusões bem documentadas.

q0365 [V/F]

Sobre anestesia em ortopedia:

Assertiva: durante uma artroplastia total de quadril a fixação cimentada da prótese pode ser complicada pela síndrome da implantação de cimento ósseo, que se manifesta por hipertensão intraoperatória acentuada, broncoconstricção e aumento da resistência vascular pulmonar.

q0366 [V/F]

Sobre anestesia para obstetrícia, responda:

Assertiva: grávida com ecocardiograma evidenciando aumento das câmaras cardíacas direitas em 20% e hipertrofia ventricular esquerda excêntrica associada a aumento no ânulo mitral e regurgitação tricúspide deve ser encaminhada ao cardiologista para investigação complementar.

q0367 [V/F]

Julgue as afirmativas a seguir:

Assertiva: a relação de Frank–Starling é determinada pelo estiramento do sarcômero e está relacionada a um aumento na sensibilidade ao cálcio intracelular

q0368 [V/F]

Sobre a anestesia para ortopedia em pacientes com osteogênese imperfeita, julgue:

Assertiva: Existe forte associação entre essa síndrome e a hipertermia maligna.

q0369 [V/F]

Homem de 62 anos, admitido com infarto agudo do miocárdio, foi submetido à trombólise com tPA, o que resultou em melhora clínica. Entretanto, exames laboratoriais revelaram níveis elevados de PAI-1 (inibidor do ativador do plasminogênio -1), sugerindo um mecanismo compensatório de inibição da fibrinólise. Avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: o PAI-1 inibe a ação tanto do tPA quanto da uroquinase, limitando a formação de plasmina e a degradação dos coágulos.

q0370 [V/F]

Em relação aos anestésicos inalatórios, analise as afirmações abaixo:

Assertiva: a hipóxia difusional é um fenômeno que ocorre durante a rápida liberação de óxido nítrico dos tecidos de pacientes anestesiados, a partir do momento que o gás é interrompido.

q0371 [V/F]

Considerando a classificação dos estabelecimentos (I, II, III, IV) na anestesia ambulatorial que tipo de procedimento poderá ser realizado:

Assertiva: na Unidade tipo III: procedimento cuja internação seja, no máximo, de 48 horas.

q0372 [V/F]

A gravidez resulta em alterações significativas em vias aéreas superiores, volumes pulmonares, ventilação, consumo de O₂ e taxa metabólica. Sobre as alterações fisiológicas respiratórias da gestação:

Assertiva: A saturação de O₂ fetal não excede 60%, mesmo com a administração de O₂ a 100% à gestante. PROVA TRIMESTRAL 03/04 – ME2/2025 CCA

q0373 [V/F]

Dos estabelecimentos de saúde que realizam procedimentos de curta permanência:

Assertiva: a unidade tipo III é anexada a um hospital geral ou especializado e que pode utilizar a estrutura do hospital.

q0374 [V/F]

Em relação à transfusão sanguínea e derivados:

Assertiva: o crioprecipitado é a fração do plasma fresco congelado. Cada unidade contém fator de Von Willebrand, fator XIII e fibrinogênio estando indicado no tratamento das deficiências desses fatores.

q0375 [V/F]

Analise as afirmativas a seguir sobre as alterações cardiovasculares na gestação:

Assertiva: A elevação do diafragma pelo crescimento do útero desloca o coração para a direita.

q0376 [V/F]

Sobre metodologia científica:

Assertiva: utilizam-se revisões sistemáticas para detectar condutas ou tratamentos inadequados.

q0377 [V/F]

Na monitorização perioperatória da coagulação podemos utilizar a tromboelastometria rotacional para direcionar a terapêutica:

Assertiva: 3 - corresponde ao tempo de coagulação.

q0378 [V/F]

No manuseio do sistema respiratório circular, valvular com absorvedor de CO₂, observa-se:

Assertiva: os gases expirados são aquecidos e umidificados, mesmo na presença da alta complacência no sistema respiratório.

q0379 [V/F]

Na metodologia científica:

Assertiva: o teste t-Student é aplicável para comparação entre duas médias.

q0380 [V/F]

Sobre anestesia venosa:

Assertiva: não há vantagem na infusão alvo-controlada do remifentanil tendo em vista seu pequeno volume de distribuição e rápida constante de equilíbrio.

q0381 [V/F]

Na vigência de isquemia cerebral, a hipotermia induzida:

Assertiva: aumenta a liberação de neurotransmissores excitatórios.

q0382 [V/F]

Com relação à estrutura e relações institucionais da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), avalie:

Assertiva: compete à Diretoria convocar uma Assembleia Geral Extraordinária quando solicitada por maioria simples dos seus membros.

q0383 [V/F]

No que se refere à VNIPP (ventilação não invasiva por pressão positiva):

Assertiva: o BIPAP (pressão positiva binível nas vias aéreas), alterna uma pressão maior na inspiração e uma menor na expiração.

q0384 [V/F]

Sobre a analgesia pós-operatória de amigdalectomia:

Assertiva: a codeína está indicada na analgesia pós-operatória das crianças.

q0385 [V/F]

Com relação à estrutura e relações institucionais da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), avalie:

Assertiva: o Conselho de Defesa Profissional é constituído pelo Diretor do Departamento de Defesa Profissional, pelos Presidentes das Regionais ou seus substitutos credenciados, pelo último Diretor Presidente da SBA e pelo Diretor Presidente da SBA em exercício.

q0386 [V/F]

Sobre a ressuscitação cardiopulmonar:

Assertiva: a impedância transtorácica apresenta média entre 500-600 Ω .

q0387 [V/F]

Sobre a fisiologia da transmissão neuromuscular e o uso dos bloqueadores neuromusculares:

Assertiva: o aumento da resistência aos relaxantes musculares adespolarizantes em pacientes queimados se deve a um fenômeno de up regulation dos receptores nicotínicos da acetilcolina.

q0388 [V/F]

No que se refere à VNIPP (ventilação não invasiva por pressão positiva):

Assertiva: melhora a troca gasosa pulmonar e diminui a capacidade residual funcional.

q0389 [V/F]

Julgue as afirmativas a seguir sobre os mecanismos celulares relacionados à contração e relaxamento miocárdico:

Assertiva: a fosforilação da fosfolamban reduz sua ação inibitória sobre o retículo sarcoplásmico/endoplasmático Ca^{2+} -ATPase (SERCA), favorecendo o relaxamento miocárdico

q0390 [V/F]

Quanto às orientações básicas, desenvolvidas para prevenir a infecção pós-operatória, pelo Surgical CareImprovement Project (SCIP), criado pelo Center for Medicare e pelo Medicaid Service:

Assertiva: cirurgia colorretal com normotermia pós-operatória imediata.

q0391 [V/F]

Na metodologia científica de estudo populacionais:

Assertiva: os estudos transversais determinam a prevalência e não a incidência, por isso há limitação desse tipo de estudo no estabelecimento do prognóstico e causas de determinadas doenças.

q0392 [V/F]

Sobre os conceitos associados à dor crônica, avalie os itens:

Assertiva: a síndrome dolorosa miofascial é a dor crônica mais frequente.

q0393 [V/F]

Com relação às particularidades do recém-nascido prematuro:

Assertiva: os fatores de coagulação V, VIII, XIII e o fibrinogênio estão reduzidos ao nascimento.

q0394 [V/F]

A imagem representa a forma de onda da pressão venosa central mostrando a evolução temporal dos componentes da forma de onda da pressão venosa central em relação ao eletrocardiograma. Correlacione o evento mecânico cardíaco causador das seguintes ondas:

Assertiva: Y - colapso sistólico na pressão atrial.

q0395 [V/F]

Sobre equilíbrio ácido básico e manejo de fluidos e de eletrólitos:

Assertiva: o controle rigoroso da glicemia (81 a 108 mg/dL) está associado a uma mortalidade mais alta quando comparado a metas de glicemia entre 109 a 180mg/dL.

q0396 [V/F]

Sobre equilíbrio hidroeletrolítico e acidobásico.

Assertiva: O obeso apresenta percentual de água corporal total maior que o indivíduo magro.

q0397 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgias urológicas responda:

Assertiva: durante ressecção transuretral de próstata, deve-se suspeitar de perfuração de cápsula prostática quando há distensão abdominal e dor referida em ombro.

q0398 [V/F]

Paciente chega ao centro cirúrgico para realização, em caráter de emergência, de laparotomia exploradora por ferimento de arma branca durante briga em bar há 30 minutos. Informa ingestão de álcool. Cirurgião não está no hospital. Sobre este caso, julgue:

Assertiva: em pacientes Testemunha de Jeová, caso haja necessidade de transfusão sanguínea com risco iminente de morte, esta deve ser realizada após autorização dos familiares.

q0399 [V/F]

Com relação ao risco profissional do anestesista:

Assertiva: diminuição do interesse sexual e do peso são comportamentos que podem indicar abuso ilícito de substâncias pelo anestesista.

q0400 [V/F]

Você irá fazer um bloqueio periconal para realização de uma retinopexia e deseja acinesia completa do olho e da pálpebra, com relação a este bloqueio podemos afirmar:

Assertiva: o bloqueio do III nervo craniano promove acinesia do músculo reto medial.

q0401 [V/F]

Quanto às complicações na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA):

Assertiva: a hipotermia e o calafrio podem prolongar o tempo de internação na SRPA, desencadear efeitos deletérios a longo prazo como isquemia e infarto do miocárdio, porém não interferem no tempo de cicatrização.

q0402 [V/F]

Quanto ao equilíbrio ácido-base, avalie:

Assertiva: a teoria ácido-base (AB) de Stewart utiliza as leis de conservação das massas e das cargas para descrever o equilíbrio AB, utilizando três variáveis independentes: diferença de íons fortes, concentração total de ácidos fracos voláteis, PaO₂. PROVA TRIMESTRAL 02/04 – ME2/2024 CCA

q0403 [V/F]

São efeitos fisiológicos da anestesia epidural e subaracnóidea:

Assertiva: o reflexo de Bezold-Jarisch pode ser uma causa de bradicardia e colapso circulatório após uma anestesia espinal na presença de hipovolemia.

q0404 [V/F]

Sobre os anestésicos inalatórios, responda:

Assertiva: estão entre os fatores que diminuem a Concentração Alveolar Mínima dos anestésicos inalatórios: a anemia, a intoxicação aguda pelo álcool e pacientes idosos. PROVA TRIMESTRAL 03/04 – ME1/2024 CCA

q0405 [V/F]

Na monitorização perioperatória:

Assertiva: a medida da pressão arterial com manguito de largura inferior a 20 % do diâmetro do braço ocasiona valores falsamente diminuídos.

q0406 [V/F]

Sobre o Estatuto da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA):

Assertiva: são três os Departamentos da SBA: Administrativo, Científico e de Defesa Profissional com Regimentos próprios.

q0407 [V/F]

Sobre anestesia venosa:

Assertiva: considerando um modelo farmacocinético monocompartimental, a concentração plasmática após um bolus é descrita pela função $C(t) = Ae^{-kt}$, onde A é a concentração no tempo 0 e k é uma constante que descreve a taxa de diminuição da concentração.

q0408 [V/F]

Sobre os absorvedores de CO₂ usados nos sistemas circular durante anestesia inalatória:

Assertiva: a capacidade de absorção do lime de hidróxido de cálcio é significativamente menor e foi relatada como 10.2 L por 100 g de absorvente.

q0409 [V/F]

Mulher de 85 anos portadora de estenose aórtica grave é encaminhada para procedimento de implante de valva aórtica transcater (TAVI):

Assertiva: Pacientes indicados para realização de TAVI são geralmente graves e inelegíveis à cirurgia convencional.

q0410 [V/F]

Sobre os conceitos fisiológicos do manejo de vias aéreas:

Assertiva: durante a pré-oxigenação, uma concentração expiratória final de oxigênio maior que 90% é considerada para maximizar o tempo de apneia seguro.

q0411 [V/F]

Sobre a fisiopatologia e o controle da dor pós-operatória:

Assertiva: o pré-tratamento com um antagonista do receptor NMDA (n-metil-D-aspartato) antes da inflamação atenua a sensibilização central.

q0412 [V/F]

Sobre os monitores avançados de oxigenação e metabolismo cerebral, avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: os valores de PbtO₂ (oximetria cerebral) são influenciados pela PaO₂ (Pressão parcial arterial de oxigênio) e pelo fluxo sanguíneo cerebral (FSC).

q0413 [V/F]

São critérios vermelhos de alto risco de gravidade em lesões traumáticas em adultos, segundo o National guideline for the field triage of trauma patients americano?

Assertiva: Frequência cardíaca > Pressão arterial sistólica.

q0414 [V/F]

Paciente feminina, 35 anos, com histórico de distúrbios de coagulação, é admitida para avaliação de um episódio trombótico recente. Sua condição é complexa devido a uma pré-disposição genética para trombose, apesar de estar atualmente sob tratamento com heparina.

Assertiva: No caso da paciente, o sistema de fibrinólise está provavelmente inativo, o que significa que a degradação de fibrina e fibrinogênio não ocorre, aumentando o risco de trombose.

q0415 [V/F]

Sobre anestesia para ortopedia:

Assertiva: Tirofiban, Eptifibatide e Abciximab são medicações antiplaquetárias que devem ser suspensas por no mínimo 8 horas antes dos procedimentos cirúrgicos ortopédicos.

q0416 [V/F]

Sobre a farmacologia dos anestésicos inalatórios:

Assertiva: O xenônio não é explosivo, é inodoro, mas é prejudicial ao meio ambiente porque é preparado por destilação fracionada do ar atmosférico.

q0417 [V/F]

Sobre a anestesia para ortopedia em pacientes com osteogênese imperfeita, julgue:

Assertiva: Complicações pulmonares são a principal causa de morte nesses pacientes.

q0418 [V/F]

Sobre as alterações respiratórias ocorridas durante a gravidez, responda:

Assertiva: Na gestante há risco de dificuldade de ventilação sob máscara, intubação de traqueia e sangramento durante a manipulação das vias aéreas devido ao ingurgitamento capilar, aumento da friabilidade tecidual e edema da mucosa que se inicia no início do terceiro trimestre.

q0419 [V/F]

Paciente do sexo feminino, 32 anos, 150cm e 98kg, será submetida cirurgia de coluna. Sobre as particularidades da anestesia venosa total utilizando propofol e remifentanil:

Assertiva: o tempo para o equilíbrio entre a concentração plasmática e o sítio efetor é descrito matematicamente por um único parâmetro: o k_e , a constante de taxa de equilíbrio do sítio efetor.

q0420 [V/F]

Sobre suporte ventilatório.

Assertiva: A ventilação de alta frequência (high-frequency ventilation) utiliza um volume menor que o espaço morto funcional, frequências respiratórias de 10 a 50 vezes maiores e altas taxas de fluxo instantâneo.

q0421 [V/F]

Quanto ao tema anestesia e infecção:

Assertiva: o hematoma, quando presente, é uma fonte rica em ferro, que promove a rápida replicação bacteriana e resulta em aumento da virulência.

q0422 [V/F]

No que se refere a anestesia para cirurgias bucomaxilofaciais, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: na presença de hiper mobilidade mandibular, pode ocorrer luxação da articulação temporomandibular durante as manobras de intubação, cujo manejo deve ser imediato, por meio da redução manual.

q0423 [V/F]

Sobre as particularidades da anestesia para oftalmologia:

Assertiva: o reflexo oculocardíaco tem como via aferente os nervos ciliares curtos e como via eferente o nervo vago.

q0424 [V/F]

Sobre anestesia para transplante:

Assertiva: A hipertensão pulmonar grave e irreversível é uma indicação para transplante cardíaco devido à insuficiência do ventrículo direito.

q0425 [V/F]

Sobre as complicações anestésicas:

Assertiva: na embolia aérea o método de maior sensibilidade para detecção é a diminuição súbita do CO expirado na capnografia.

q0426 [V/F]

Sobre anestesia pediátrica.

Assertiva: Os bebês são especialmente vulneráveis à hipotermia devido a baixa proporção da área de superfície corporal em relação ao peso.

q0427 [V/F]

As cirurgias urológicas robóticas e videolaparoscópicas tem peculiaridades fisiológicas e técnicas importantes que o anestesista deve saber para proporcionar melhores desfechos para o paciente. São elas:

Assertiva: cirurgias prolongadas estão relacionadas à acidose importante.

q0428 [V/F]

Em anestesia para amigdalectomia, observa-se que:

Assertiva: o cetololaco é analgésico seguro no pós-operatório de amigdalectomia em adulto.

q0429 [V/F]

Em relação ao edema cerebral, avalie as afirmativas abaixo:

Assertiva: quando ocorre insulto isquêmico cerebral, o edema forma-se primariamente na substância branca subcortical e não no córtex cerebral.

q0430 [V/F]

Você foi convocado para realizar anestesia para ressecção de tumor cerebral. A depender da localização da lesão, podemos afirmar que:

Assertiva: lesão localizada no sistema de drenagem venosa (seios venosos), torna-se real o risco de embolia aérea venosa, porém sem repercussões cardiopulmonares e risco de embolia arterial.

q0431 [V/F]

Com relação à anestesia e o sistema endócrino:

Assertiva: a maioria dos casos de Síndrome de Cushing é decorrente de produção excessiva de ACTH.

q0432 [V/F]

Em relação aos anestésicos inalatórios, avalie as afirmações abaixo:

Assertiva: o uso de óxido nitroso durante anestesia inalatória pode causar interferência na vitamina B12. Tal efeito se dá pela inibição reversível do ligante cobalto.

q0433 [V/F]

Com relação à estrutura e relações institucionais da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), avalie:

Assertiva: o Diretor do Departamento Administrativo da SBA é membro da Comissão Executiva dos Congressos Brasileiros de Anestesiologia.

q0434 [V/F]

Sobre gerenciamento do centro cirúrgico:

Assertiva: a produtividade do bloco operatório é igual à carga de trabalho das salas de cirurgia dividida pelos custos de mão-de-obra.

q0435 [V/F]

Sobre anestesia para litotripsia extracorpórea:

Assertiva: pacientes com lesões espinhais estão sujeitos a desenvolver disreflexia autonômica durante a litotripsia extracorpórea, apresentando espasmos musculares em resposta às ondas de choque.

q0436 [V/F]

Sobre anestesia ambulatorial:

Assertiva: segundo a resolução do conselho federal de medicina 1886/2008 é responsabilidade do médico anestesiológico que a unidade de saúde com internação de curta permanência cumpra as normas estabelecidas visando o bem-estar e a segurança do paciente.

q0437 [V/F]

Com relação ao risco profissional do anestesiológico:

Assertiva: existem evidências emergentes do papel de vários compostos de carvão ativado para absorver moléculas de vapor anestésico, mas estes foram testados apenas em experimentos e ainda não estão disponíveis comercialmente.

q0438 [V/F]

Com relação a anestesia pediátrica.

Assertiva: É necessário tecido muscular arterial para o verdadeiro fechamento do ducto arterial. Este tecido é menos prevalente em prematuros.

q0439 [V/F]

Sobre diagnóstico e manejo da neuralgia pós herpética:

Assertiva: A pregabalina pode ser usada no tratamento e pode apresentar como efeito adverso sonolência, tonteira e edema periférico.

q0440 [V/F]

Em relação a anestesia em otorrinolaringologia, observa-se:

Assertiva: o uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINS) está contraindicado em amigdalectomias infantis devido o risco de sangramento pós-operatório.

q0441 [V/F]

Sobre a ética aplicada à prática do anestesiológico, responda:

Assertiva: as mulheres em trabalho de parto são capazes de dar consentimento informado.

q0442 [V/F]

Um paciente de 70 anos com histórico de insuficiência cardíaca e fibrilação atrial persistente foi encaminhado para uma ablação por cateter no laboratório de eletrofisiologia. Durante o procedimento, que estava programado para durar aproximadamente 5 horas, o paciente foi submetido a anestesia geral para garantir condições ideais de procedimento e conforto do paciente. A equipe médica monitorou de perto a ventilação e a temperatura esofágica do paciente, e houve necessidade de administração de agentes inotrópicos para manter a estabilidade hemodinâmica. Sobre o papel do anestesiológico no laboratório de eletrofisiologia:

Assertiva: arritmias induzidas por estimulação programada durante estudos eletrofisiológicos geralmente podem ser tratadas com agentes sedativos de ação prolongada.

q0443 [V/F]

Sobre anestesia em procedimentos torácicos:

Assertiva: pacientes que vão ser submetidos a ressecção pulmonar e apresentam consumo máximo de oxigênio (VO_2 máx) maior que 15 a 20 mL/kg/min estão em risco reduzido de complicação pós-operatória.

q0444 [V/F]

Em anestesia para amigdalectomia, observa-se que:

Assertiva: a codeína é o analgésico indicado em crianças submetidas à amigdalectomia por hipertrofia amigdaliana.

q0445 [V/F]

Julgue os aspectos anatômicos e fisiológicos da inervação urogenital.

Assertiva: Inervação simpática renal origina-se de fibras pré-ganglionares T2-L1 com modulação da liberação de renina justaglomerular

q0446 [V/F]

Em relação ao reflexo oculocardíaco, analise as afirmativas abaixo:

Assertiva: injeção intraconal, é um bloqueio anestésico capaz de ativar o reflexo oculocardíaco.

q0447 [V/F]

Sobre a fisiologia da transmissão neuromuscular e o uso de bloqueadores neuromusculares:

Assertiva: o bloqueio fase II é frequente quando se usa altas doses de succinilcolina.

q0448 [V/F]

Na metodologia científica de estudo populacionais:

Assertiva: o escore Z permite que comparemos um valor específico com a população levando-se em conta o valor típico e a dispersão. A cada valor de z está associado um percentil.

q0449 [V/F]

Com relação à estrutura e relações institucionais da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), avalie:

Assertiva: constitui função do Conselho Superior destituir a diretoria e/ou o Conselho Fiscal.

q0450 [V/F]

Mulher de 74 anos, com histórico de HAS e DM2, dá entrada no pronto-socorro com dor abdominal difusa, distensão, hipotensão (PA 82×48 mmHg) e taquicardia. Exames laboratoriais mostram acidose metabólica (BE -6,5) e lactato 4,9 mmol/L. A tomografia sugere perfuração de alça intestinal com peritonite difusa. A equipe decide por laparotomia de urgência. Com base nas recomendações atuais do modelo de cuidado orientado por desfecho (ELPQulC), avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: a monitorização hemodinâmica com BE e lactato, e o uso de métodos invasivos ou minimamente invasivos, é fortemente recomendada.

q0451 [V/F]

Sobre complicações em anestesia.

Assertiva: Os antagonistas dos receptores alfa 1 adrenérgicos reduzem a pressão arterial, bradicardia e hipotensão ortostática, especialmente em pacientes com hipovolemia.

q0452 [V/F]

No que se refere à morbidade em anestesia:

Assertiva: os eventos adversos que ocorrem em decorrência do procedimento anestésico podem ser classificados como de morbidade intermediária, quando não causam danos permanentes e nem alteram o período de permanência hospitalar do paciente.

q0453 [V/F]

Sobre o uso dos equipamentos para agentes anestésicos intravenosos em infusão contínua:

Assertiva: o modelo Marsh baseia-se apenas no peso corporal total para calcular volumes e depuração, muito indicado na manutenção da anestesia venosa total dos pacientes obesos.

q0454 [V/F]

No que se refere ao suporte ventilatório:

Assertiva: CPAP (pressão positiva contínua nas vias aéreas) mantém pressão positiva constante durante a inspiração, mantendo os alvéolos abertos.

q0455 [V/F]

Sobre o manejo das vias aéreas:

Assertiva: a manobra de Sellick consiste no deslocamento da laringe por pressão na cartilagem tireóide: posterior, cefálico e lateralmente para a direita.

q0456 [V/F]

Sobre os bloqueios periféricos da face:

Assertiva: para um bloqueio completo do couro cabeludo, é necessário o bloqueio de cinco nervos provenientes do nervo trigêmeo e dos ramos cervicais.

q0457 [V/F]

Sobre a farmacologia e os efeitos dos bloqueadores neuromusculares (BNMs):

Assertiva: os efeitos adversos da succinilcolina são exarcebados quando há um maior número de receptores nicotínicos extrajuncionais (up regulation).

q0458 [V/F]

Na prática clínica, para se realizar a medida da complacência estática, deve-se:

Assertiva: realizar pausa respiratória de 0,5 a 1 segundo.

q0459 [V/F]

Sobre a farmacologia dos anestésicos inalatórios:

Assertiva: A concentração alveolar mínima do xenônio depende do gênero, sendo menor nas mulheres.

q0460 [V/F]

São alvos terapêuticos no manejo do Trauma Crânio Encefálico grave:

Assertiva: Pressão de Perfusão Encefálica > 50mmHg.

q0461 [V/F]

Em relação à transfusão sanguínea e derivados:

Assertiva: nas bolsas cuja solução preservativa é o CPDA-1 os concentrados de hemácias devem ter hematócritos entre 65% e 75%. Porém nas bolsas com solução aditiva, o hematócrito pode apresentar uma variação maior.

q0462 [V/F]

Homem, 58 anos, portador de obesidade mórbida e histórico de doença arterial coronariana, está programado para uma cirurgia eletiva na qual será posicionado em decúbito dorsal (supino) durante o procedimento. Dada a sua condição pré-existente, a equipe perioperatória está atenta aos efeitos fisiopatológicos que essa posição pode ter sobre o paciente.

Assertiva: A capacidade de ventilação pulmonar é maximizada na posição supina devido ao aumento da capacidade residual funcional (CRF).

q0463 [V/F]

Em relação à farmacologia dos anestésicos inalatórios:

Assertiva: anestésicos voláteis fornecem cardioproteção após reduzir a carga de potássio das células miocárdicas durante isquemia.

q0464 [V/F]

Em relação a anestesia em otorrinolaringologia, observa-se:

Assertiva: a presença de apneia obstrutiva do sono aumenta o risco de complicações respiratórias no pós-operatório de amigdalectomias.

q0465 [V/F]

Sobre as complicações durante a anestesia para cirurgias bucomaxilofaciais:

Assertiva: em avulsões (exarticulações) dentárias, o prognóstico piora em reimplantes a partir de 02 horas do dente fora do alvéolo.

q0466 [V/F]

Sobre os dispositivos supra-glóticos (DSG):

Assertiva: o risco de laringoespasma aumentado e saturação de oxigênio mais baixa, após a remoção do dispositivo de vias aéreas, são desvantagem da utilização da máscara laríngea na cirurgia supraglótica.

q0467 [V/F]

Sobre as características morfofisiológicas do recém-nascido e da criança, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: ainda no útero, o fígado inicia a produção de glicogênio, e o acúmulo hepático ocorre nas fases tardias da gestação. Esse estoque de glicogênio será utilizado quase na sua totalidade nas primeiras 48h de vida.

q0468 [V/F]

Paciente de 25 anos, feminino, IMC 28kg/m², entrou para o centro cirúrgico para realização de apendicectomia videolaparoscópica de urgência. Relata que estava em investigação para quadro de fadiga e sonolência intensa e ganho ponderal. Apresentou exame laboratorial recente dentro da normalidade, com exceção de TSH de 15mUI/L. A respeito desse caso, responda os itens abaixo com verdadeiro ou falso.

Assertiva: O tratamento com reposição de hormônios tireoidianos deve ser iniciado assim que possível. Deve ser realizada trombopprofilaxia medicamentosa pelo maior risco de

q0469 [V/F]

No manejo da anestesia para cirurgia torácica:

Assertiva: pacientes que serão submetidos a ressecção pulmonar e que apresentam um VEF1 predito pós-operatório de 30% são considerados de baixo risco para complicações pulmonares.

q0470 [V/F]

Sobre anestesia em procedimentos torácicos:

Assertiva: são indicações da utilização de bloqueadores endobrônquicos os pacientes com traqueostomia e aqueles em que a intubação deve ser realizada pela via nasal.

q0471 [V/F]

Sobre os anestésicos venosos:

Assertiva: quando se utiliza o propofol para sedação prolongada ou em doses mais elevadas, especialmente em idosos, as concentrações de triglicerídeos séricos devem ser monitoradas rotineiramente.

q0472 [V/F]

Sobre o edema pulmonar por pressão negativa (EPPN):

Assertiva: a maioria dos pacientes evoluem mal e com sequelas a longo prazo.

q0473 [V/F]

Em relação a fisiologia e farmacologia do sistema urinário, avalie:

Assertiva: pacientes que apresentam doença relacionada a altitude (hipobaropatia), irá se beneficiar pelo tratamento com acetazolamida.

q0474 [V/F]

Sobre a organização da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA):

Assertiva: são membros Aspirantes os(as) médicos(as) cursando Residência em Anestesiologia em centro credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, não integrante do quadro oficial de Centros de Ensino e Treinamento credenciados pela SBA.

q0475 [V/F]

Com relação à farmacologia dos anestésicos venosos.

Assertiva: Fospropofol causa menor dor à injeção e está associado a disestesia ou sensação de queimação perineal.

q0476 [V/F]

Em relação ao sistema nervoso central, avalie:

Assertiva: O folheto embrionário endoderma, dá origem a todo sistema nervoso humano.

q0477 [V/F]

Na monitorização perioperatória:

Assertiva: a derivação DII é a mais sensível para diagnosticar arritmias cardíacas.

q0478 [V/F]

Na prática clínica, para se realizar a medida da complacência estática, deve-se:

Assertiva: medir a pressão no início da pausa respiratória, chamada de pressão de platô.

q0479 [V/F]

Paciente de 25 anos, feminino, IMC 28kg/m², entrou para o centro cirúrgico para realização de apendicectomia videolaparoscópica de urgência. Relata que estava em investigação para quadro de fadiga e sonolência intensa e ganho ponderal. Apresentou exame laboratorial recente dentro da normalidade, com exceção de TSH de 15mUI/L. A respeito desse caso, responda os itens abaixo com verdadeiro ou falso.

Assertiva: A cirurgia deve ser suspensa até o controle do quadro.

q0480 [V/F]

Sobre os anestésicos venosos:

Assertiva: durante o uso da cetamina, a depressão de núcleos centrais, relacionados com audição e visão, favorece uma interpretação distorcida de estímulos auditivos e visuais.

q0481 [V/F]

Em relação ao Monitoramento da Pressão Arterial e Análise de Onda para Previsão da Responsividade ao Volume:

Assertiva: uma VPS (>15 mm Hg) é altamente preditivo de uma alta pressão de oclusão da artéria pulmonar (PAWP), sugerindo uma reserva de pré-carga ventricular esquerda reduzida.

q0482 [V/F]

Sobre as complicações da anestesia:

Assertiva: o limiar de toxicidade do íon fluoreto sérico para que se atinja a nefrotoxicidade situa-se entre 40 e 57 picomolares Pm.

q0483 [V/F]

Em relação à farmacologia dos anestésicos inalatórios:

Assertiva: todos os anestésicos inalatórios deprimem dose dependente, a respostas ventilatória à hipoxemia.

q0484 [V/F]

Sobre a fisiologia da transmissão neuromuscular e o uso dos bloqueadores neuromusculares:

Assertiva: a potenciação dos efeitos dos agentes voláteis inalatórios sobre os relaxantes musculares é tanto maior quanto mais baixa a solubilidade gás/sangue e gás/tecidual.

q0485 [V/F]

Sobre equilíbrio ácido básico e manejo de fluidos e de eletrólitos:

Assertiva: ressuscitação volêmica com solução salina 0,9% e diarreia são causas de acidose metabólica com anião gap elevado.

q0486 [V/F]

Sobre suporte ventilatório.

Assertiva: A técnica de ventilação com máscara com uma mão é ocasionalmente ineficaz, especialmente em pacientes obesos ou desdentados.

q0487 [V/F]

Em relação ao edema cerebral, avalie as afirmativas abaixo:

Assertiva: tanto o edema hidrocefálico como o edema linfático, acontecem quando canais de drenagem são bloqueados, resultando na expansão do tecido adjacente a obstrução com acumulacão retrograda de fluido no espaço ocupado pelo fluido extracelular.

q0488 [V/F]

As cirurgias urológicas robóticas e videolaparoscópicas tem peculiaridades fisiológicas e técnicas importantes que o anestesta deve saber para proporcionar melhores desfechos para o paciente. São elas:

Assertiva: deve-se suspeitar de edema de laringe se houver edema conjuntival e/ou facial ao final da cirurgia.

q0489 [V/F]

Durante a infusão de fármacos para realização de anestesia venosa alvo- controlada aplicam-se conceitos farmacodinâmicos e farmacocinéticos:

Assertiva: quando se necessita de um início rápido de efeito deve ser escolhido um fármaco com Ke_0 longo.

q0490 [V/F]

Em relação a fisiologia e farmacologia do sistema urinário, avalie:

Assertiva: quando há elevada infusão de SF 0,9% em paciente saudável, ocorrerá redução da taxa de filtração glomerular, às custas da contração da arteríola aferente reflexa à resposta da mácula densa.

q0491 [V/F]

Sobre as complicações da raquianestesia:

Assertiva: punção traumática e coagulopatias são fatores de risco para desenvolvimento de hematoma epidural.

q0492 [V/F]

Homem, 58 anos, portador de obesidade mórbida e histórico de doença arterial coronariana, está programado para uma cirurgia eletiva na qual será posicionado em decúbito dorsal (supino) durante o procedimento. Dada a sua condição pré-existente, a equipe perioperatória está atenta aos efeitos fisiopatológicos que essa posição pode ter sobre o paciente.

Assertiva: O posicionamento supino melhora a ventilação nas porções basais dos pulmões em pacientes acordados, contribuindo para uma melhor correspondência ventilação-perfusão. (Verdadeiro).

q0493 [V/F]

Com relação ao risco de aspiração pulmonar perioperatória, julgue os itens:

Assertiva: A motilina está reduzida no primeiro trimestre da gestação.

q0494 [V/F]

Em relação ao sistema nervoso, avalie.

Assertiva: A dura-máter é uma membrana rica em colágeno, espessa, densa, resistente e inelástica, ricamente vascularizada e innervada, o que a torna responsável pela sensibilidade dolorosa intracraniana.

q0495 [V/F]

Em relação ao fluxo sanguíneo renal é correto afirmar:

Assertiva: a autorregulação é mantida no intervalo de pressão arterial média de 60 a 160 mmHg.

q0496 [V/F]

Sobre o consumo pré-operatório de fitoterápicos:

Assertiva: o produto "Ma huang" aumenta o risco de acidente vascular encefálico.

q0497 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia plástica:

Assertiva: na fase hipermetabólica, o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular aumentam. Como resultado, a depuração renal de alguns fármacos como gentamicina, cefalosporinas e antagonistas dos receptores H₂ será acelerada.

q0498 [V/F]

Com relação à anestesia e o sistema endócrino:

Assertiva: a adrenalectomia videolaparoscópica, para ressecção de feocromocitoma, é reservada para tumores pequenos de até 6 cm.

q0499 [V/F]

Sobre complicações na anestesia:

Assertiva: o risco de reação a uma cefalosporina em pacientes com teste cutâneo negativo para penicilina é aproximadamente 4,4%.

q0500 [V/F]

Considerando o mecanismo de reparação vascular e as características físicas e químicas das plaquetas, avalie as seguintes afirmações:

Assertiva: uma das funções importantes das plaquetas é a capacidade de se aderir a áreas lesionadas da parede vascular, particularmente a células endoteliais lesionadas e colágeno exposto, contribuindo para a formação de um tampão plaquetário.

q0501 [V/F]

Considerando a classificação dos estabelecimentos (I, II, III, IV) na anestesia ambulatorial que tipo de procedimento poderá ser realizado:

Assertiva: na Unidade tipo I: procedimento com anestesia local com lidocaína na dose de < 3,5 mg/kg.

q0502 [V/F]

Uma paciente de 55 anos, com IMC de 30 kg/m² e sem histórico de doenças respiratórias, foi submetida a uma videocolecistectomia laparoscópica. Durante o procedimento, foi utilizada ventilação controlada por volume (VCV) com um volume corrente de 6-8 mL/kg de peso corporal previsto, PEEP e manobras periódicas de recrutamento alveolar. Após a cirurgia, a paciente apresentou atelectasia leve e uma redução na capacidade vital forçada (CVF) no segundo dia pós-operatório. Sobre os efeitos respiratórios intraoperatórios e pós-operatórios da insuflação abdominal e cirurgia laparoscópica:

Assertiva: a redução na função pulmonar pós-operatória após cirurgias abdominais é completamente normalizada com o tratamento da dor com anestesia local epidural ou opioides. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 04/04 – ME2/2024 CCA

q0503 [V/F]

Sobre a mecânica respiratória e controle da respiração, julgue os itens:

Assertiva: o tempo que os alvéolos levam para serem insuflados ou esvaziados corresponde à constante de tempo, sendo igual ao produto da complacência pela resistência.

q0504 [V/F]

Sobre as características morfofisiológicas do recém-nascido e da criança, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: o débito cardíaco é maior no recém-nascido do que no adulto e permanece elevado até o final do segundo ano de vida.

q0505 [V/F]

A Hipotermia induzida:

Assertiva: a 20 graus celsius induz a supressão do eletroencefalograma. PROVA TRIMESTRAL 02/04 – ME3/2023 CCA

q0506 [V/F]

Sobre as complicações durante a anestesia para cirurgias bucomaxilofaciais:

Assertiva: durante a osteotomia/fratura da maxila, edema e hematoma de maior volume ocorre em quase todos os pacientes e não são considerados complicações, mas decorrência da técnica cirúrgica.

q0507 [V/F]

Um anestesiológista está avaliando critérios de alta para diferentes pacientes em unidade ambulatorial. Considerando a Resolução CFM nº 1.886/2008 e a responsabilidade específica do anestesiológista na liberação dos pacientes:

Assertiva: avaliação de sangramento do sítio cirúrgico não faz parte dos critérios de alta

q0508 [V/F]

Sobre os anestésicos venosos:

Assertiva: quando a anestesia é induzida pelo etomidato em pacientes sem pré- anestésico, 50% a 80% dos pacientes apresentam mioclonias que são geradas por focos epiléticos.

q0509 [V/F]

Sobre anestesia ambulatorial:

Assertiva: pacientes diabéticos, mesmo com disautonomia, podem ser submetidos a procedimentos em regime ambulatorial.

q0510 [V/F]

Analise as afirmativas a seguir sobre as alterações cardiovasculares na gestação:

Assertiva: uma terceira bulha (B3) pode ser frequentemente auscultada no terceiro trimestre de gestação e também uma quarta bulha (B4) em algumas pacientes.

q0511 [V/F]

Sobre as complicações durante a anestesia para cirurgias bucomaxilofaciais:

Assertiva: em pacientes já tratados de cirurgias ortognáticas, com emprego de meios de osteossíntese metálicas, as manobras durante a intubação, com apoio e impacção da maxila ou abertura bucal forçada (excessiva) poderão comprometer a estabilidade das estruturas ósseas nos seus processos de neoformação e remodelamento, mesmo em período tardio.

q0512 [V/F]

Sobre as alterações respiratórias ocorridas durante a gravidez, responda:

Assertiva: Existe redução da capacidade residual funcional composta por redução tanto no volume de reserva expiratório quanto no volume residual. No entanto, a capacidade de fechamento permanece inalterada.

q0513 [V/F]

Com relação ao sistema nervoso autônomo:

Assertiva: a dopa sofre ação da enzima dopamina β-hidroxilase e se converte em dopamina.

q0514 [V/F]

De acordo com as características farmacológicas dos anestésicos locais, encontram-se em ordem crescente de:

Assertiva: potência comparada à procaína: tetracaína- lidocaína- mepivacaína

q0515 [V/F]

Um paciente do gênero masculino, com histórico de doença arterial coronariana e diabetes, está programado para uma cirurgia urológica que requer posição de litotomia combinada com inclinação cefálica negativa. Considerando as condições pré-existentes do paciente, a equipe cirúrgica está particularmente preocupada com as complicações cardiovasculares e pulmonares que podem surgir devido à posição durante o procedimento prolongado.

Assertiva: A síndrome compartimental é uma complicação associada à posição de litotomia, especialmente em procedimentos com duração superior a 5 horas.

q0516 [V/F]

Sobre a ressuscitação cardiopulmonar:

Assertiva: a recomendação atual em pacientes adultos usando um desfibrilador monofásico é dar um único choque de 360 J e retomada imediata da RCP por 2 minutos antes de verificar novamente o ritmo e o pulso.

q0517 [V/F]

Em relação aos anestésicos inalatórios:

Assertiva: promovem redução no Ca^{2+} do retículo sarcoplasmático. a manutenção da ventilação espontânea com inalatórios depende dos

q0518 [V/F]

Mulher de 85 anos portadora de estenose aórtica grave é encaminhada para procedimento de implante de valva aórtica transcater (TAVI):

Assertiva: No momento do implante da válvula se faz necessário induzir taquicardia ventricular através do marcapasso previamente instalado.

q0519 [V/F]

Sobre o propofol, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: no período de indução anestésica com propofol podem aparecer algumas alterações do tipo contraturas tônico-clônicas, que parecem estar relacionadas ao antagonismo à glicina e com a consequente ativação do sistema extra-piramidal em nível subcortical.

q0520 [V/F]

Com relação ao atendimento anestésico do paciente vítima de trauma:

Assertiva: o eletrocardiograma é o melhor teste de triagem no diagnóstico de contusão miocárdica.

q0521 [V/F]

No que se refere a anestesia para cirurgias bucomaxilofaciais, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: as manobras durante a intubação são capazes de provocar flexões, deslocamentos e/ou fraturas de placas/parafusos, e comprometer o próprio resultado cirúrgico bucomaxilofacial, mesmo em período tardio. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 01/04 – ME3/2025 CCA

q0522 [V/F]

Durante um plantão na UTI, você é chamado para atender uma parada cardiorrespiratória. O paciente de 58 anos, diabético e hipertenso, estava internado por pneumonia. Ao chegar, a equipe de enfermagem já iniciou as compressões torácicas. O monitor mostra fibrilação ventricular.

Assertiva: Deve-se realizar um período de compressões torácicas por 2 minutos antes de aplicar o primeiro choque.

q0523 [V/F]

Sobre as síndromes dolorosas crônicas:

Assertiva: A incidência de dor fantasma é maior nas amputações distais de membro não dominante.

q0524 [V/F]

Em relação ao sistema nervoso, avalie.

Assertiva: A pia-máter proporciona sustentação estrutural ao tecido nervoso e acompanha todos os relevos do SNC, bem como os vasos que nele penetram, formando a parede externa dos espaços perivasculares, que constituem amortecedores hidráulicos às pulsações arteriais. PROVA TRIMESTRAL 02/04 – ME1/2024 CCA

q0525 [V/F]

Paciente masculino, 50 anos, 175 cm de altura e 70 kg será submetido a hepatectomia por metástase hepática de carcinoma colorretal. No intraoperatório, após perda sanguínea de aproximadamente 1,5 L, observa-se PAM 72 mmHg, IC de 3,5 L.min-1.m-2, SatO2 98%, SvO2 de 55%, lactato 39 mg.dL-1, BE -5,6 mmol.L-1 e Hb 7,0 g.dL-1. Sobre este caso:

Assertiva: Neste caso espera-se pressões de enchimento cardíacas diminuídas e resistência vascular sistêmica aumentada.

q0526 [V/F]

Com relação à fisiopatologia do choque, julgue os itens:

Assertiva: A intoxicação por monóxido de carbono é uma das principais etiologias de choque vasoplégico.

q0527 [V/F]

Quanto aos critérios de alta da Sala de Recuperação Pós-Anestésica:

Assertiva: com o advento do BIS (índice bispectral), o IAK foi modificado, alterando a forma de avaliar o item “consciência”.

q0528 [V/F]

Sobre suporte ventilatório:

Assertiva: a posição prona é recomendada na síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) grave, ventilação-perfusão e aeração pulmonar são melhoradas e a heterogeneidade do parênquima é reduzida, gerando um efeito protetor contra lesão pulmonar.

q0529 [V/F]

Com relação às vias aéreas e seu manejo:

Assertiva: a traqueia inicia-se a nível da cartilagem cricoide e se estende até a carina a nível da quinta vértebra torácica.

q0530 [V/F]

Com relação aos bloqueios de nervos periféricos:

Assertiva: O nervo safeno é um ramo sensorial terminal do nervo femoral acima do joelho e fornece inervação aos ramos infrapatelares para a articulação do joelho.

q0531 [V/F]

Sobre suporte ventilatório:

Assertiva: muito preciso, devido à baixa complacência da câmara do pistão

q0532 [V/F]

Sobre anestesia ambulatorial:

Assertiva: na SRPA-2 processa-se a recuperação do estágio II da recuperação anestésica.

q0533 [V/F]

Um paciente do gênero masculino, com histórico de doença arterial coronariana e diabetes, está programado para uma cirurgia urológica que requer posição de litotomia combinada com inclinação cefálica negativa. Considerando as condições pré-existentes do paciente, a equipe cirúrgica está particularmente preocupada com as complicações cardiovasculares e pulmonares que podem surgir devido à posição durante o procedimento prolongado.

Assertiva: Elevar as pernas na posição de litotomia diminui a pressão de perfusão nos membros inferiores, reduzindo o risco de complicações isquêmicas.

q0534 [V/F]

Sobre a anestesia para cirurgia ortopédica, julgue:

Assertiva: Comparado à posição lateral, a posição da cadeira de praia oferece uma exposição com menos variação na anatomia muscular e menos tensão no plexo braquial.

q0535 [V/F]

Com relação à fisiopatologia do choque, julgue os itens:

Assertiva: No choque cardiogênico ocorre elevação das pressões de enchimento cardíacas de forma desproporcional aos valores do índice cardíaco, decorrente da diminuição da complacência ventricular.

q0536 [V/F]

Com relação aos bloqueios oculares:

Assertiva: a associação com adrenalina aumenta a pressão intraocular.

q0537 [V/F]

Sobre o uso dos equipamentos para agentes anestésicos intravenosos em infusão contínua:

Assertiva: no modelo Elefeld as depurações são dimensionadas e tem bom desempenho em todos os pacientes nos estudos internos, embora ainda requeira mais validação prospectiva.

q0538 [V/F]

Sobre bloqueios do neuroeixo:

Assertiva: O fluxo sanguíneo hepático se mantém constante após anestesia do neuroeixo em virtude de sua autorregulação.

q0539 [V/F]

Paciente de 25 anos, feminino, IMC 28kg/m², entrou para o centro cirúrgico para realização de apendicectomia videolaparoscópica de urgência. Relata que estava em investigação para quadro de fadiga e sonolência intensa e ganho ponderal. Apresentou exame laboratorial recente dentro da normalidade, com exceção de TSH de 15mUI/L. A respeito desse caso, responda os itens abaixo com verdadeiro ou falso.

Assertiva: cirúrgico, uma vez que a paciente pode ter aumento da sensibilidade a esses fármacos.

q0540 [V/F]

Sobre as características morfofisiológicas do Sistema Hematopoiético do recém-nascido e da criança, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: os fatores de coagulação no neonato estão muito semelhantes daquilo que se encontra no adulto, tornando a interpretação dos resultados de exames de níveis séricos de fatores de coagulação e a previsão de qual será o funcionamento do sistema mais previsíveis, especialmente em situações patológicas.

q0541 [V/F]

Com relação à qualidade na prática da anestesia:

Assertiva: a Análise de Causa Raiz trata-se de uma boa ferramenta para análise de eventos adversos.

q0542 [V/F]

Em relação a fisiologia e farmacologia do sistema urinário, avalie:

Assertiva: a Alça de Henle, compreende três segmentos com funções bastante distintas.

q0543 [V/F]

Em relação à transfusão sanguínea e derivados:

Assertiva: o plasma fresco congelado é o plasma separado de uma unidade de sangue total por centrifugação e deve ser totalmente congelado na primeira hora após a coleta.

q0544 [V/F]

Com base nas interações dos anestésicos locais com o canal de sódio, avalie as alternativas:

Assertiva: a ligação de anestésicos locais ocorre em resíduos dos segmentos S6, que participam da entrada interna do canal.

q0545 [V/F]

Sobre a ressuscitação cardiopulmonar:

Assertiva: quando a circulação espontânea é restabelecida o primeiro sinal é um aumento súbito na ETCO.

q0546 [V/F]

No manejo da anestesia para cirurgia torácica:

Assertiva: a aplicação de CPAP no pulmão dependente é uma das manobras para melhorar a P aO₂ durante a ventilação monopulmonar.

q0547 [V/F]

Os compostos absorventes de CO₂ usados no circuito anestésico para administração dos agentes inalatórios têm as seguintes características:

Assertiva: na presença de bases fortes (NaOH e KOH) da cal sodada, os agentes voláteis se degradam e formam o composto A e CO (monóxido de carbono).

q0548 [V/F]

Na prática clínica, para se realizar a medida da complacência estática, deve-se:

Assertiva: considerar a pressão de platô equivalente à pressão alveolar.

q0549 [V/F]

Sobre a farmacologia e os efeitos dos bloqueadores neuromusculares (BNMs) na anestesia:

Assertiva: BNMs não despolarizantes causam bloqueio ao induzir despolarização prolongada da membrana pós-sináptica.

q0550 [V/F]

Sobre as complicações durante a anestesia para cirurgias bucomaxilofaciais:

Assertiva: a laceração do balonete, durante a osteotomia/fratura da maxila, é uma intercorrência possível e tecnicamente complicada, obrigando o tamponamento ou a troca do tubo no intraoperatório.

q0551 [V/F]

Sobre gerenciamento do centro cirúrgico:

Assertiva: o custo da mão-de-obra de um centro cirúrgico é a soma das horas trabalhadas multiplicadas pelo custo por hora das horas trabalhadas e as horas trabalhadas fora do expediente multiplicadas pelo custo por hora das horas trabalhadas fora do expediente. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 04/04 – ME3/2024 CCA

q0552 [V/F]

Sobre suporte ventilatório:

Assertiva: na fase expiratória do ventilador de pistão, o fluxo de gás fresco mais o gás exalado do balão respiratório reabastecem a câmara do pistão.

q0553 [V/F]

Uma paciente de 55 anos, submetida a uma cirurgia abdominal de longa duração em decúbito dorsal, apresentou no pós-operatório queixas de formigamento e fraqueza no braço esquerdo, além de queixas de dor lombar intensa. Durante a cirurgia, observou-se que os braços foram posicionados com abdução superior a 90° e que não houve suporte lombar adequado. Com base no caso clínico avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: o emprego de dispositivos de contenção, como braceletes ou faixas apertadas ao redor do pescoço, é recomendado para evitar o deslocamento da cabeça e proteger o plexo braquial.

q0554 [V/F]

Você irá fazer um bloqueio periconal para realização de uma retinopexia e deseja acinesia completa do olho e da pálpebra, com relação a este bloqueio podemos afirmar:

Assertiva: o bloqueio do nervo abducente promove acinesia do músculo oblíquo superior.

q0555 [V/F]

Você foi convocado para realizar anestesia para ressecção de tumor cerebral. A depender da localização da lesão, podemos afirmar que:

Assertiva: lesão localizada em região de fossa posterior baixa, traz a necessidade ao anestesiolologista de avaliar o critério criterioso quanto a sensibilidade, reflexos e motricidade da língua, cordas vocais, traqueia e capacidade de deglutição antes da extubação.

q0556 [V/F]

Sobre o choque séptico:

Assertiva: o débito urinário é um parâmetro importante e está diretamente relacionado com a perfusão dos órgãos.

q0557 [V/F]

A respeito das complicações da anestesia, julgue:

Assertiva: a dor aguda pós-operatória é mais comum em pacientes com dor pré-operatória.

q0558 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgias urológicas responda:

Assertiva: para cirurgia de prostatectomia realizada apenas com bloqueio neuroaxial, este deve atingir, pelo menos, nível T6.

q0559 [V/F]

Sobre a fisiologia cardiovascular e considerando a figura abaixo, responda:

Assertiva: no momento X ocorre abertura da valva aórtica, dando início à ejeção ventricular.

q0560 [V/F]

Em relação a anestesia pediátrica, avalie:

Assertiva: em relação a anestesia de neuroeixo em crianças até 8 anos, as alterações hemodinâmicas são raras devido à imaturidade do sistema nervoso simpático (SNS) e a menor capacidade do sistema venoso.

q0561 [V/F]

Sobre anestesia venosa:

Assertiva: o sufentanil apresenta maior lipossolubilidade quando comparado ao fentanil, no entanto apresenta menor volume de distribuição em virtude de sua maior ligação às proteínas plasmáticas e maior depuração hepática.

q0562 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia ortopédica:

Assertiva: a redução da exposição a anestésicos gerais pode ajudar a prevenir delirium, mas não há evidências conclusivas de que a anestesia raquidiana seja superior à anestesia geral na redução do delirium.

q0563 [V/F]

Sobre a fisiopatologia e o controle da dor pós-operatória:

Assertiva: a sensibilização central da dor é desencadeada por impulsos sensoriais transmitidos pelas fibras A delta que terminam nas camadas mais superficiais do corno posterior da medula.

q0564 [V/F]

Sobre anestesia para transplantes:

Assertiva: A doença cardíaca isquêmica é a principal causa de morte em transplantados renais, em parte devido à doença subjacente que precedeu o transplante.

q0565 [V/F]

Sobre o edema pulmonar por pressão negativa (EPPN):

Assertiva: a incidência é relatada como 0,05% a 0,1% para todos os anestésicos.

q0566 [V/F]

Sobre complicações em anestesia.

Assertiva: A hipotensão ortostática (supina ou postural) sugere um déficit de volume sanguíneo maior que 50%.

q0567 [V/F]

Sobre a fisiologia cardiovascular e considerando a figura abaixo, responda:

Assertiva: após o fechamento da valva aórtica há o enchimento ventricular rápido (W) e relaxamento isovolumétrico (Z), respectivamente.

q0568 [V/F]

Um paciente de 70 anos com histórico de insuficiência cardíaca e fibrilação atrial persistente foi encaminhado para uma ablação por cateter no laboratório de eletrofisiologia. Durante o procedimento, que estava programado para durar aproximadamente 5 horas, o paciente foi submetido a anestesia geral para garantir condições ideais de procedimento e conforto do paciente. A equipe médica monitorou de perto a ventilação e a temperatura esofágica do paciente, e houve necessidade de administração de agentes inotrópicos para manter a estabilidade hemodinâmica. Sobre o papel do anestesiológico no laboratório de eletrofisiologia:

Assertiva: o bloqueio neuromuscular deve ser sempre utilizado durante ablações para garantir um campo de procedimento estático e seguro.

q0569 [V/F]

Em relação à farmacologia dos anestésicos inalatórios:

Assertiva: os anestésicos inalatórios não têm efeito direto nas células do marcapasso cardíaco. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 03/04 – ME1/2025 CCA

q0570 [V/F]

Sobre anestesia e sistema cardiovascular.

Assertiva: Ventrículo esquerdo não complacente (isquemia, hipertrofia) é uma condição que resulta em discrepância entre a pressão capilar pulmonar (PCP) e a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo (PDFVE), gerando $PCP < PDFVE$

q0571 [V/F]

Considerando as zonas pulmonares de West:

Assertiva: Esta distribuição do fluxo sanguíneo no pulmão é consequência dos efeitos da gravidade, e uma vez esta sendo anulada não haverá heterogeneidade no fluxo sanguíneo pulmonar.

q0572 [V/F]

Em relação a anestesia pediátrica, avalie:

Assertiva: o etomidato apresenta baixa fração livre do fármaco após sua injeção, uma vez que neonatos e crianças até 3 anos, apresentam elevada reserva de albumina.

q0573 [V/F]

Quais os critérios de alta para pacientes adultos submetidos à anestesia ambulatorial?

Assertiva: estabilidade dos sinais vitais há pelo menos 30 min.

q0574 [V/F]

Anestesia inalatória administrada em concentração acima de uma CAM:

Assertiva: potencializa a ação dos bloqueadores neuromusculares.

q0575 [V/F]

Paciente de 25 anos, feminino, IMC 28kg/m², entrou para o centro cirúrgico para realização de apendicectomia videolaparoscópica de urgência. Relata que estava em investigação para quadro de fadiga e sonolência intensa e ganho ponderal. Apresentou exame laboratorial recente dentro da normalidade, com exceção de TSH de 15mUI/L. A respeito desse caso, responda os itens abaixo com verdadeiro ou falso.

Assertiva: O tratamento com reposição de hormônios tireoidianos deve ser iniciado assim que possível.

q0576 [V/F]

Em relação ao sistema nervoso, avalie.

Assertiva: As fibras pre-ganglionares do sistema nervoso parassimpático geralmente fazem sinapses com apenas alguns neuroônios pós-ganglionares, mantendo uma estreita relação neuroônio pre e pós de apenas 1:2 a 1:3. Exceção é o plexo de Auerbach no cólon descendente com uma relação neuroônio pre e pós de 1:80.

q0577 [V/F]

Os procedimentos realizados em regime ambulatorial:

Assertiva: têm maior risco de infecção hospitalar.

q0578 [V/F]

Sobre o consumo pré-operatório de fitoterápicos:

Assertiva: pacientes que usam valeriana há pouco tempo são mais resistentes à sedação.

q0579 [V/F]

Sobre suporte ventilatório.

Assertiva: O pneumoperitônio durante procedimentos laparoscópicos aumenta a resistência pulmonar e a complacência pulmonar dinâmica.

q0580 [V/F]

Neste corte transversal:

Assertiva: a estrutura 8 corresponde ao forâmen paravertebral.

q0581 [V/F]

Sobre as complicações da raquianestesia:

Assertiva: ao se deparar com um nível elevado de bloqueio após a injeção intratecal de anestésico local hiperbárico, uma das condutas para limitar a ascensão do bloqueio é posicionar o paciente em posição de Trendelenburg reversa.

q0582 [V/F]

O bloqueio do canal dos adutores é considerado essencial por muitos, dado sua facilidade de execução, área de analgesia e seletividade do bloqueio. A respeito deste bloqueio, julgue:

Assertiva: a localização do bloqueio do canal dos adutores é simples e consensual.

q0583 [V/F]

Sobre a hipotermia intraoperatória:

Assertiva: a hipotermia moderada reduz a necessidade de transfusão sanguínea intraoperatória.

q0584 [V/F]

Sobre as características estruturais do canal de Na⁺ que determinam as interações com anestésicos locais (AL):

Assertiva: íons Na⁺ competem com os AL por um sítio no canal, regulando a taxa de dissociação dos AL.

q0585 [V/F]

Sobre gerenciamento do centro cirúrgico:

Assertiva: a previsão do tempo restante em casos em andamento é um dos determinantes mais importantes para a tomada de decisão no dia da cirurgia, pois afeta decisões como chamar o próximo paciente, mover casos e o alívio da equipe.

q0586 [V/F]

A imagem representa a forma de onda da pressão venosa central mostrando a evolução temporal dos componentes da forma de onda da pressão venosa central em relação ao eletrocardiograma. Correlacione o evento mecânico cardíaco causador das seguintes ondas:

Assertiva: C - contração isovolumetrica do ventrículo direito.

q0587 [V/F]

Em relação a anestesia em otorrinolaringologia, observa-se:

Assertiva: a extubação em plano profundo deve ser evitada em todas as crianças submetidas à amigdalectomia devido ao risco de aspiração. PROVA TRIMESTRAL 04/04 – ME2/2025 CCA

q0588 [V/F]

Sobre o estatuto da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), responda:

Assertiva: a Diretoria da SBA e os membros do Conselho Fiscal são eleitos durante a Assembleia Geral.

q0589 [V/F]

Sobre anestesia venosa:

Assertiva: a constante de taxa de eliminação (k₁₀) abrange processos que atuam através da biotransformação ou eliminação que remove irreversivelmente o medicamento do compartimento central.

q0590 [V/F]

Sobre o edema pulmonar por pressão negativa (EPPN):

Assertiva: os fatores de risco incluem sexo masculino, idade mais jovem, tempo de procedimento prolongado e intubação endotraqueal.

q0591 [V/F]

Com relação ao bloqueio demonstrado nas imagens abaixo, assinale V ou F.

Assertiva: a injeção de anestésico local deve ser realizada com a agulha na posição 2 e não deve ser realizada com agulha na posição 1.

q0592 [V/F]

Sobre os conceitos associados à dor crônica, avalie os itens:

Assertiva: a neuralgia pós-herpética é mais frequente após herpes do ramo oftálmico.

q0593 [V/F]

Dos estabelecimentos de saúde que realizam procedimentos de curta permanência:

Assertiva: a unidade tipo I deverá contar com salas de recuperação ou de observação do paciente.

q0594 [V/F]

Paciente do sexo feminino, 32 anos, 150cm e 98kg, será submetida cirurgia de coluna. Sobre as particularidades da anestesia venosa total utilizando propofol e remifentanil:

Assertiva: um sistema de infusão alvo-controlada juntamente com seu modelo farmacocinético apresentaria um desempenho perfeito caso sua Mediana da Performance Absoluta de Erro (MDAPE) fosse 100%.

q0595 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgias urológicas responda:

Assertiva: entre as alterações neurológicas esperadas após insuflação do pneumoperitônio em posição de Trendelenburg estão aumento de pressão intracraniana, fluxo sanguíneo cerebral e pressão intraocular.

q0596 [V/F]

Sobre anestesia para ortopedia:

Assertiva: a incidência de hematoma epidural após anestesia neuraxial é maior em pacientes com espondilite anquilosante do que na população geral.

q0597 [V/F]

Sobre a anestesia para ortopedia em pacientes com osteogênese imperfeita, julgue:

Assertiva: É justificada uma canulação arterial para proteger o paciente do risco de fratura umeral associado ao manguito de pressão por oscilometria.

q0598 [V/F]

Com relação aos bloqueios de nervos periféricos:

Assertiva: Uma das desvantagens do bloqueio infraclavicular é que ele resulta em anestesia incompleta do plexo braquial.

q0599 [V/F]

Julgue:

Assertiva: A alocação de tempo de sala operatória em blocos oferece flexibilidade para ajustar o agendamento diário com base na disponibilidade dos cirurgiões.

q0600 [V/F]

Quanto aos conceitos de bioética e modelos deliberativos na área de saúde:

Assertiva: o método de Nijmegen, o modelo “CARE” e o processo deliberativo de Diego Garcia, são modelos deliberativos utilizados na área de saúde.

q0601 [V/F]

Em relação a pressão intraocular (PIO), analise as afirmativas abaixo:

Assertiva: durante o período de tosse, o aumento na pressão venosa central tem como consequência a elevação da PIO de 34 a 40 mmHg.

q0602 [V/F]

Você é chamado para atender uma parada cardiorrespiratória em uma criança de 4 anos que foi encontrada submersa em uma piscina. A criança está inconsciente, sem respiração e sem pulso detectável. Considerando as diretrizes específicas para ressuscitação pediátrica, julgue:

Assertiva: em casos de parada cardíaca pediátrica por asfixia, a RCP convencional (compressões torácicas e ventilações de resgate) é preferível à RCP apenas com compressões.

q0603 [V/F]

Na comparação entre os testes viscoelásticos e os convencionais para monitorização perioperatória da coagulação, temos que os testes viscoelásticos:

Assertiva: são realizados com amostras de sangue total.

q0604 [V/F]

Complicações pulmonares pós-operatórias são uma importante causa de morbimortalidade hospitalar após grandes cirurgias. Com relação às estratégias protetoras de ventilação mecânica intraoperatória:

Assertiva: são mecanismos associados ao dano às células endoteliais e barreira alveolocapilar pulmonar: barotrauma, volutrauma e atelectrauma.

q0605 [V/F]

Sobre equilíbrio hidroeletrolítico e acidobásico.

Assertiva: Os principais íons intracelulares são o potássio, magnésio e fosfato; e os extracelulares são o sódio, cloro e bicarbonato.

q0606 [V/F]

Em procedimentos de Ressonância Nuclear Magnética:

Assertiva: Metais considerados seguros na sala de ressonância magnética incluem: aço inoxidável, titânio, alumínio, cobre.

q0607 [V/F]

Quanto ao equilíbrio ácido-base, avalie:

Assertiva: o fenômeno conhecido como efeito Bohr se refere ao tamponamento do íon H^+ pelo HCO_3^- produzindo H_2CO_3 , que se dissocia em CO_2 e H_2O , sendo o CO_2 produzido exalado pelos pulmões através da ventilação alveolar.

q0608 [V/F]

Após uma parada cardiorrespiratória e reanimação:

Assertiva: uma angiografia de urgência deve ser a primeira medida a ser adotada.

q0609 [V/F]

Sobre a hipotermia intraoperatória:

Assertiva: a anestesia peridural causa menor redistribuição de calor do que a anestesia geral.

q0610 [V/F]

Homem de 52 anos, com IMC 38 kg/m², antecedente de apneia obstrutiva do sono e refluxo gastroesofágico, será submetido a esofagogastroduodenoscopia (EGD) com previsão de mucosectomia gástrica. O exame será realizado fora do centro cirúrgico, com uso de bisturi elétrico. Com base no quadro clínico, avalie as alternativas:

Assertiva: perfuração gastrointestinal é uma complicação potencial e pode requerer intervenção cirúrgica imediata.

q0611 [V/F]

Sobre as complicações em anestesia reações anafiláticas/anafilatóides (RAA), hipertermia maligna (HM) e soluços pós-operatórios (SPO), responda:

Assertiva: RAA com sinais de risco de morte com envolvimento de um ou vários órgãos (hipotensão ou broncoespasmo graves, sinais cutaneomucosas ou gastrointestinais) caracteriza o grau III na escala de Ring e Messmer modificada.

q0612 [V/F]

Sobre a fisiologia da transmissão neuromuscular e o uso de bloqueadores neuromusculares:

Assertiva: a cetamina se dissolve na camada lipídica ao redor do receptor da junção neuromuscular podendo levar a dessensibilização do receptor e bloqueio dos canais iônicos.

q0613 [V/F]

Sobre anestesia para obstetrícia, responda:

Assertiva: Durante a gravidez a resistência vascular pulmonar diminui 20%.

q0614 [V/F]

Com relação à farmacologia dos anestésicos venosos.

Assertiva: Cetamina está associada à catalepsia, condição caracterizada por falta de resposta a estímulos externos e rigidez muscular.

q0615 [V/F]

Com relação à anestesia inalatória:

Assertiva: aumenta a atividade autonômica simpática com desflurano acima de 1 CAM.

q0616 [V/F]

Sobre a pré-oxigenação do paciente durante a indução anestésica:

Assertiva: a oxigenação apnéica pode retardar o início da dessaturação da oxiemoglobina, durante a apneia.

q0617 [V/F]

Sobre a cirurgia do ouvido médio, mastoide e ouvido interno:

Assertiva: a monitorização do nervo facial com potencial evocado auditivo reduz a incidência de lesão iatrogênico.

q0618 [V/F]

Paciente feminina, 35 anos, com histórico de distúrbios de coagulação, é admitida para avaliação de um episódio trombótico recente. Sua condição é complexa devido a uma pré-disposição genética para trombose, apesar de estar atualmente sob tratamento com heparina.

Assertiva: A heparina, que está sendo utilizada pela paciente, acelera a inibição mediada pela antitrombina (AT) das enzimas alvo, contribuindo para a regulação da hemostase e limitando a formação de trombos.

q0619 [V/F]

Com relação à hemodinâmica glomerular:

Assertiva: antagonistas dos canais de cálcio aumentam a resistência das arteríolas aferente e eferente, diminuindo a taxa de filtração glomerular.

q0620 [V/F]

Sobre o gerenciamento do centro cirúrgico:

Assertiva: os sistemas de informação perioperatórios (prontuário eletrônico de saúde) devem ser altamente confiáveis e possuir processos de contingência (downtime) para períodos de indisponibilidade planejada ou não.

q0621 [V/F]

Os estudos de coorte:

Assertiva: não há necessidade de contatos periódicos com os pacientes.

q0622 [V/F]

Sobre anestesia ambulatorial:

Assertiva: a recuperação do estágio III dá-se quando o paciente está apto a se levantar e andar sem ajuda. Os efeitos colaterais devem estar ausentes e a realimentação deve ser instituída com sucesso.

q0623 [V/F]

Sobre a dor pós-operatória:

Assertiva: o corno dorsal da medula espinhal desempenha um papel crucial na modulação da transmissão da dor, sendo o local mais comum onde os sinais de dor podem ser alterados (inibidos ou aumentados).

q0624 [V/F]

Com relação a anestesia em urgências no trauma:

Assertiva: administração de ácido tranexâmico diminui a mortalidade por todas as causas em paciente vítimas de trauma com sangramento, sem aumento de eventos oclusivos vasculares.

q0625 [V/F]

Em procedimentos urológicos para desintegração de cálculos presentes no ureter e no rim:

Assertiva: a nefrolitotomia percutânea é a modalidade preferida para o tratamento de cálculos menores (< 20 mm).

q0626 [V/F]

Quanto à classificação de Child-Pugh para a avaliação da função hepática:

Assertiva: quanto maior o aumento do índice internacional normalizado (INR), mais grave o paciente.

q0627 [V/F]

Quanto às orientações básicas, desenvolvidas para prevenir a infecção pós-operatória, pelo Surgical Care Improvement Project (SCIP), criado pelo Center for Medicare e pelo Medicaid Service:

Assertiva: descontinuação da antibioticoprofilaxia somente 48 horas após cirurgia.

q0628 [V/F]

Com relação à estrutura e relações institucionais da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), avalie:

Assertiva: compete à Diretoria deliberar sobre o credenciamento e descredenciamento dos Centros de Ensino e Treinamento.

q0629 [V/F]

Um paciente adulto é possível candidato a doação de órgãos quando além de um coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinal e apneia persistente, apresenta:

Assertiva: pressão arterial média maior ou igual a 65 mmHg.

q0630 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia plástica:

Assertiva: reposição de líquidos adicionais no intraoperatório durante lipoaspirações devem ser feitas à razão de 0,25 mL de solução de ringer com lactato para cada 1 mL de líquido aspirado acima de 5000 mL.

q0631 [V/F]

Com relação à anestesia para cirurgia bucomaxilofacial:

Assertiva: laceração da parede anterior faringe e falso trajeto nasofaríngeo são complicações de intubação nasal durante cirurgia ortognática. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 01/04 – ME3/2023 CCA

q0632 [V/F]

Sobre a dor pós-operatória:

Assertiva: algumas substâncias algogênicas importantes envolvidas na transdução e transmissão da dor e relacionadas à inflamação incluem bradicinina, serotonina e histamina, que podem ativar nociceptores e causar efeitos como vasodilatação e edema.

q0633 [V/F]

Sobre disfunção tireoideana perioperatória:

Assertiva: o hipertireoidismo associado à amiloidose causa alargamento da língua, anormalidades do sistema de condução cardíaca e doença renal.

q0634 [V/F]

Sobre a hipotermia intraoperatória:

Assertiva: a anestesia geral aumenta a perda cutânea de calor de forma significativa.

q0635 [V/F]

Com relação ao sistema nervoso autônomo assinale verdadeiro ou falso.

Assertiva: As fibras simpáticas pré-ganglionares são amielínicas.

q0636 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia plástica:

Assertiva: pacientes hipotérmicos submetidos a cirurgias plásticas com duração superior a 2 horas apresentam tempo de tromboplastina parcial ativada e tempo de sangramento similares aos pacientes normotérmicos.

q0637 [V/F]

Sobre o estatuto da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), responda:

Assertiva: a SBA é composta de três Departamentos com regimento próprio: Administrativo, Científico e Defesa Profissional.

q0638 [V/F]

Sobre farmacologia geral:

Assertiva: o sistema de enzimas do citocromo P450 (CYP) também é conhecido como sistema oxidase de função mista porque envolve etapas tanto de oxidação quanto de redução; a reação mais comum catalisada pelo CYP é a reação monooxigenase, por exemplo, a inserção de um átomo de oxigênio em um substrato orgânico enquanto o outro átomo de oxigênio é reduzido a água.

q0639 [V/F]

Um paciente de 45 anos, com índice de massa corporal (IMC) de 32 kg/m² e histórico de hipertensão controlada, foi submetido a uma cirurgia de videocolecistectomia laparoscópica. Durante o procedimento, foi insuflado dióxido de carbono (CO₂) para criar um pneumoperitônio com pressão intra-abdominal de 12 mmHg. Após a cirurgia, a equipe médica monitorou cuidadosamente a função renal e hemodinâmica do paciente devido ao risco de complicações associadas ao pneumoperitônio. Sobre os efeitos fisiológicos do pneumoperitônio:

Assertiva: o pneumoperitônio com CO₂ aumenta a resistência vascular sistêmica (SVR) e a resistência vascular pulmonar (PVR), e pode causar uma diminuição no débito cardíaco.

q0640 [V/F]

Com relação aos princípios norteadores do cuidado centrado no paciente em relação a qualidade e segurança.

Assertiva: No gráfico de execução ou controle de qualidade (run chart): uma mudança (shift) são cinco ou mais pontos consecutivos acima ou abaixo da mediana.

q0641 [V/F]

De acordo com as características farmacológicas dos anestésicos locais, encontram-se em ordem crescente de:

Assertiva: duração de efeito (horas): lidocaína- procaína- bupivacaína - F PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 03/04 – ME1/2023 CCA

q0642 [V/F]

Sobre a farmacologia e os efeitos dos bloqueadores neuromusculares (BNMs):

Assertiva: BNMs não despolarizantes produzem bloqueio neuromuscular competindo com a acetilcolina pelos receptores nicotínicos da subunidade alfa na membrana pós-sináptica.

q0643 [V/F]

Quanto às complicações na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA):

Assertiva: a náusea e os vômitos pós-operatório (NVPO) se constituem a primeira causa mais comum de complicação no pós-operatório imediato.

q0644 [V/F]

Em relação à transfusão sanguínea e derivados:

Assertiva: o plasma comum além de conter proteínas e os fatores de coagulação, está indicado como expansor plasmático.

q0645 [V/F]

Paciente sexo masculino 50 anos, hipertenso, tabagista pesado (40 cigarros/dia) será submetido a uma gastrectomia. Avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: a anestesia geral pode predispor à hipoxemia devido a um desequilíbrio ventilação-perfusão (V/Q).

q0646 [V/F]

O manuseio de doadores de órgão antes da captação deve seguir:

Assertiva: correção do sódio menor que 130 ou maior que 170 mmol/L, pois há aumento da mortalidade do receptor.

q0647 [V/F]

Você irá fazer um bloqueio periconal para realização de uma retinopexia e deseja acinesia completa do olho e da pálpebra, com relação a este bloqueio podemos afirmar:

Assertiva: acinesia do músculo orbicular é obtida pelo bloqueio do VII nervo craniano.

q0648 [V/F]

Sobre anestesia em intervenções coronarianas percutâneas (PCI), avalie as alternativas:

Assertiva: o risco anestésico é considerado baixo durante PCI, mesmo em pacientes com comorbidades graves como DPOC e apneia do sono.

q0649 [V/F]

Um paciente de 45 anos, com índice de massa corporal (IMC) de 32 kg/m² e histórico de hipertensão controlada, foi submetido a uma cirurgia de videocolecistectomia laparoscópica. Durante o procedimento, foi insuflado dióxido de carbono (CO₂) para criar um pneumoperitônio com pressão intra-abdominal de 12 mmHg. Após a cirurgia, a equipe médica monitorou cuidadosamente a função renal e hemodinâmica do paciente devido ao risco de complicações associadas ao pneumoperitônio. Sobre os efeitos fisiológicos do pneumoperitônio:

Assertiva: a perfusão renal e a função renal podem ser prejudicadas pelo pneumoperitônio, sendo esses efeitos permanentes.

q0650 [V/F]

Sobre gerenciamento do centro cirúrgico:

Assertiva: questões de quando liberar o tempo de sala de operação alocado são de maior importância prática em comparação com a alocação e o planejamento de pessoal.

q0651 [V/F]

Sobre anestesia e obstetrícia.

Assertiva: A incidência de cefaleia após punção dural não intencional com agulha epidural é relatada em 70% a 90% e acredita-se que o vazamento de fluido espinhal resulta em hiperemia vascular, fisiologia de enxaqueca e tração de fibras sensíveis à dor.

q0652 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia ortopédica:

Assertiva: perda visual perioperatória é uma complicação rara, mas devastadora, associada a cirurgias de coluna. Fatores de risco incluem: sexo feminino, pacientes com IMC (índice de massa corpórea) abaixo de 26 e uso de suporte de Wilson.

q0653 [V/F]

Com relação aos princípios norteadores do cuidado centrado no paciente relacionados a qualidade e segurança:

Assertiva: debriefing deve ser realizado antes de cada procedimento; e o briefing, após cada procedimento.

q0654 [V/F]

Quanto ao posicionamento dos pacientes durante a cirurgia:

Assertiva: na posição de decúbito ventral quando relatada a perda de visão, o glaucoma agudo e isquemia de nervo óptico estão entre as principais causas.

q0655 [V/F]

Sobre os hormônios adrenocorticais:

Assertiva: o preparo de pacientes com doença de Addison inclui o tratamento da hipervolemia, hipercalemia e hiponatremia.

q0656 [V/F]

Com relação a anestesia pediátrica.

Assertiva: Presença de meningomielocoele torna a possibilidade de hidrocefalia rara.

q0657 [V/F]

Paciente foi submetido a raquianestesia para realização de desbridamento cirúrgico de membros inferiores a nível ambulatorial. Fazem parte dos critérios de alta hospitalar:

Assertiva: sinais vitais entre 20% e 40% dos valores pré-operatórios recebem pontuação 2.

q0658 [V/F]

Com relação ao bloqueio demonstrado nas imagens abaixo, assinale V ou F.

Assertiva: a estrutura D corresponde ao músculo escaleno posterior.

q0659 [V/F]

Paciente sexo masculino 50 anos, hipertenso, tabagista pesado (40 cigarros/dia) será submetido a uma gastrectomia. Avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: a espirometria espera-se uma diminuição da CVF (capacidade vital forçada) com razão FEV1/CVF (volume expiratório forçado no primeiro segundo/capacidade vital forçada) preservada.

q0660 [V/F]

Sobre as características morfofisiológicas do recém-nascido e da criança, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: após o nascimento, a maior parte dos recém-nascidos terá apresentado diurese nas primeiras 24h, alguns levam até 48h.

q0661 [V/F]

Homem de 62 anos, admitido com infarto agudo do miocárdio, foi submetido à trombólise com tPA, o que resultou em melhora clínica. Entretanto, exames laboratoriais revelaram níveis elevados de PAI-1 (inibidor do ativador do plasminogênio -1), sugerindo um mecanismo compensatório de inibição da fibrinólise. Avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: o tPA (ativador tecidual do plasminogênio) é a principal enzima responsável pela conversão do plasminogênio em plasmina, iniciando a fibrinólise.

q0662 [V/F]

Uma paciente de 55 anos, submetida a uma cirurgia abdominal de longa duração em decúbito dorsal, apresentou no pós-operatório queixas de formigamento e fraqueza no braço esquerdo, além de queixas de dor lombar intensa. Durante a cirurgia, observou-se que os braços foram posicionados com abdução superior a 90° e que não houve suporte lombar adequado. Com base no caso clínico avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: a lateralização excessiva da cabeça durante o posicionamento não interfere na integridade do plexo braquial, desde que a posição supina seja mantida.

q0663 [V/F]

Em relação aos agonistas opioides utilizados em analgesia pós-operatória, sabe-se:

Assertiva: Metadona é um analgésico de longa duração indicado nos adictos a opioides que estão em recuperação.

q0664 [V/F]

Sobre a fisiologia da transmissão neuromuscular e o uso de bloqueadores neuromusculares:

Assertiva: os anestésicos voláteis inalatórios induzem relaxamento muscular por efeito central nos motoneurônios e sinapses interneuronais, inibição do receptor nicotínico pós-sináptico da acetilcolina e aumento da afinidade do bloqueador neuromuscular no sítio do receptor.

q0665 [V/F]

Sobre a ressuscitação cardiopulmonar:

Assertiva: a parada cardíaca causada pela fibrilação ventricular pode ser caracterizada em três fases, sendo a fase metabólica a primeira delas.

q0666 [V/F]

Sobre farmacologia geral:

Assertiva: as enzimas de fase I no metabolismo hepático incluem glucuronosiltransferases, glutationa-S-transferases, N-acetil-transferases e sulfotransferases. A uridina difosfato glucuronosiltransferase catalisa a adição covalente de ácido glicurônico a uma variedade de compostos endógenos e exógenos, tornando-os mais solúveis em água.

q0667 [V/F]

Sobre as características estruturais do canal de Na⁺ que determinam as interações com anestésicos locais (AL):

Assertiva: mutações direcionadas de diferentes aminoácidos no canal indicam resíduos envolvidos na ligação dos AL no vestibulo interno do canal.

q0668 [V/F]

Sobre anestesia ambulatorial:

Assertiva: unidades tipo II destinam-se à realização cirurgias/procedimentos de pequeno e médio porte, sob anestesia locorregional (com exceção dos bloqueios subaracnóideo e peridural), com ou sem sedação.

q0669 [V/F]

Em relação aos analgésicos e adjuvantes não opioides no controle da dor pós-operatória:

Assertiva: A cetamina é um antagonista do receptor NMDA, que previne a sensibilização central ao estímulo algico. PROVA TRIMESTRAL 03/04 – ME3/2023 CCA

q0670 [V/F]

Sobre a ética aplicada à prática do anestesiológico, responda:

Assertiva: a premissa da ética baseada na teoria deontológica quando aplicada à medicina considera que a intenção é mais importante que o resultado.

q0671 [V/F]

Em relação ao reflexo oculocardíaco, analise as afirmativas abaixo:

Assertiva: febre e a hipercarbia, são fatores de risco para aumento da incidência do reflexo oculocardíaco.

q0672 [V/F]

Sobre a farmacologia e os efeitos dos bloqueadores neuromusculares (BNMs) na anestesia:

Assertiva: a liberação de histamina é mais frequentemente notada após a administração da classe benzoisoquinolínicos dos BNMs.

q0673 [V/F]

Sobre anestesia e sistema cardiovascular.

Assertiva: A circulação extracorpórea ativa ambas as vias de coagulação intrínseca e extrínseca e prejudica diretamente função plaquetária.

q0674 [V/F]

Sobre os conceitos fisiológicos do manejo de vias aéreas:

Assertiva: a técnica com quatro respirações de capacidade vital ao longo de 30 segundos é o método mais eficaz de pré-oxigenação, devendo ser preferida em situações clínicas mais complexas.

q0675 [V/F]

Sobre a organização da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), responda às questões abaixo.

Assertiva: O Conselho Fiscal é composto pelo Diretor Financeiro e pelo Diretor Administrativo da SBA.

q0676 [V/F]

Sobre a farmacologia dos anestésicos inalatórios:

Assertiva: O óxido nitroso é um contribuidor proeminente tanto para destruição da camada de ozônio, bem como o efeito estufa. PROVA TRIMESTRAL 03/04 – ME1/2023 CCA

q0677 [V/F]

A Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA) estabelece recomendações pré- anestésicas, para garantir a disponibilidade e funcionalidade dos equipamentos essenciais na prática segura da anestesia. Assim, as recomendações da ASA incluem a presença de:

Assertiva: sistema de ventilação autoinflável disponível na sala de operação.

q0678 [V/F]

Segundo a RESOLUÇÃO CFM N° 2.174/2017, que dispõe sobre a prática do ato anestésico:

Assertiva: o médico anestesista que realizar a consulta pré-anestésica ou a avaliação pré-anestésica deve ser o mesmo que administrará a anestesia.

q0679 [V/F]

Sobre anestesia para litotripsia extracorpórea:

Assertiva: em gestantes está indicada a proteção do tórax com uma cobertura plástica contendo bolhas de ar formando um escudo de proteção às ondas de choque.

q0680 [V/F]

Nos capnógrafos de fluxo principal (mainstream) e fluxo lateral (sidestream):

Assertiva: há um potencial risco de aumento de espaço morto no de fluxo principal.

q0681 [V/F]

Sobre a dor no paciente com câncer:

Assertiva: a ativação da glia perpetua a dor devido à secreção de citocinas inflamatórias, tais como IL-1 e IL-6 promovendo estado de retroalimentação positiva e dor de difícil controle.

q0682 [V/F]

Sobre as complicações da anestesia:

Assertiva: idade mais jovem, estado físico mais elevado da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA), histórico de tolerância ao álcool ou drogas, histórico de intubação difícil, e procedimentos como cesariana, cirurgia cardíaca e cirurgia de trauma estão associados a um risco aumentado de consciência intraoperatória.

q0683 [V/F]

Com relação à anestesia inalatória:

Assertiva: induz nefrotoxicidade associada ao aumento do fluoreto pelo metabolismo do halotano.

q0684 [V/F]

Julgue as afirmativas a seguir sobre os mecanismos celulares relacionados à contração e relaxamento miocárdico:

Assertiva: durante a diástole, a concentração de cálcio citosólico permanece elevada para manter a sensibilidade da troponina C ao cálcio

q0685 [V/F]

Sobre o gerenciamento do centro cirúrgico:

Assertiva: sistemas de relato voluntário de incidentes e quase-acidentes não agregam valor para iniciativas de melhoria da qualidade locais.

q0686 [V/F]

Sobre suporte ventilatório:

Assertiva: a ventilação oscilatória de alta frequência fornece volumes muito baixos, com uma frequência respiratória muito alta e é indicada como método de resgate em hipóxia refratária.

q0687 [V/F]

Com relação à hemodinâmica glomerular:

Assertiva: óxido nítrico diminui a resistência das arteríolas aferente e eferente, aumentando a taxa de filtração glomerular.

q0688 [V/F]

Sobre as síndromes dolorosas crônicas:

Assertiva: Uma vez estabelecida a neuropatia diabética dolorosa, a hiperglicemia diminui a intensidade da dor, pois a glicose modula a percepção através de interação com peptídeos opioides endógenos.

q0689 [V/F]

Com relação ao sistema nervoso autônomo:

Assertiva: o aminoácido tirosina sofre ação da enzima tirosina-hidroxilase e se converte em dopa.

q0690 [V/F]

Quanto ao equilíbrio ácido-base, avalie:

Assertiva: o cálculo do Ânion Gap (AG) é determinado pela diferença entre os cátions e ânions medidos no plasma.

q0691 [V/F]

Considerando as zonas pulmonares de West:

Assertiva: É reconhecida uma diminuição na perfusão na base dos pulmões, ou zona IV, onde há aumento da resistência vascular pulmonar.

q0692 [V/F]

Com relação a anestesia em urgências no trauma:

Assertiva: geralmente a pressão arterial sistólica (PAS) em crianças é de aproximadamente 70 mmHg mais 2 vezes a idade em anos, enquanto o limite inferior (percentil 5) da PAS é aproximadamente 50 mmHg mais 2 vezes a idade em anos.

q0693 [V/F]

Segundo a RESOLUÇÃO CFM N° 2.174/2017, que dispõe sobre a prática do ato anestésico:

Assertiva: cabe ao médico anestesista responsável encaminhar o paciente para ser recuperado na enfermaria na ausência de médico plantonista na sala de recuperação pós anestésica (SRPA).

q0694 [V/F]

O manuseio de doadores de órgão antes da captação deve seguir:

Assertiva: pressão arterial entre 50-120 mmHg, pois pode diminuir os níveis de citocinas

q0695 [V/F]

Sobre anestesia para transplantes:

Assertiva: Pontuação MELD para escolha de pacientes para transplante de fígado utilizados para o cálculo: creatinina, bilirrubina, TGO, TGP e sódio, valores acima de 35 são elegíveis para o transplante.

q0696 [V/F]

Com relação a procedimentos ambulatoriais, analise as alternativas:

Assertiva: paciente de 70 Kg encaminhado para retirada de lesões de pele sendo utilizado 210 mg de lidocaína com vasoconstritor, está autorizada a realização em unidade tipo I.

q0697 [V/F]

Os procedimentos realizados em regime ambulatorial:

Assertiva: permitem maior controle das náuseas e vômitos pós-operatórios.

q0698 [V/F]

Com relação ao sistema nervoso autônomo assinale verdadeiro ou falso.

Assertiva: O neurotransmissor pós-ganglionar das glândulas sudoríparas é colinérgico.

q0699 [V/F]

Sobre anestesia para cirurgia plástica:

Assertiva: nas rinoplastias com fratura óssea a hemorragia é inevitável, o uso de tamponamento do cavum é importante para evitar a ocorrência de sangue no estômago, fator que eleva a incidência de vômito no pós-operatório.

q0700 [V/F]

Sobre farmacologia geral:

Assertiva: a administração sistêmica de uma base fraca, como um opioide, pode resultar no acúmulo do fármaco ionizado (ion trapping) no ambiente ácido do estômago.

q0701 [V/F]

Sobre o manejo das vias aéreas:

Assertiva: a indução em sequência rápida é um método tradicionalmente usado para o gerenciamento de vias aéreas difíceis.

q0702 [V/F]

Em relação ao sistema nervoso central, avalie:

Assertiva: O endotélio capilar tem mais de 95% de sua superfície circundada por processos celulares de astrócitos, o que constitui mais uma interposição entre os capilares e o tecido nervoso.

q0703 [V/F]

Sobre o choque séptico:

Assertiva: a manutenção do débito cardíaco e um DO₂ adequado garante uma extração tecidual de O₂ adequada.

q0704 [V/F]

Sobre ética na prática da anestesiologia, responda:

Assertiva: a decisão final sobre o melhor procedimento em cada situação de saúde-doença deve ser do médico, uma vez que ele detém o conhecimento técnico necessário para determinar o que é mais adequado para o paciente.

q0705 [V/F]

Em relação ao edema cerebral, avalie as afirmativas abaixo:

Assertiva: o edema compressivo, em seu estágio inicial, é caracterizado por aumento do volume de fluido no espaço extracelular, com a quebra da barreira hematoencefálica.

q0706 [V/F]

Sobre anestesia venosa:

Assertiva: quando se realiza uma indução de propofol em TCI efeito, deve-se escolher uma dose-alvo inicial superior à provável concentração no local de ação que ocorrerá a perda da consciência.

q0707 [V/F]

Com relação ao risco profissional do anestesiológico:

Assertiva: o uso de naltrexona pode reduzir a chance de recaída entre anestesiológicos em recuperação de abuso de opioides.

q0708 [V/F]

Quanto ao tema anestesia e infecção:

Assertiva: a infecção que ocorre dentro de 30 dias após a cirurgia é considerada infecção precoce, e a que ocorre até um ano é considerada infecção tardia.

q0709 [V/F]

Sobre avaliação e preparo pré-anestésico:

Assertiva: no tratamento pré-operatório do feocromocitoma, o bloqueio β -adrenérgico é iniciado antes do bloqueio α -adrenérgico, começando 7 a 14 dias antes da cirurgia.

q0710 [V/F]

Segundo a RESOLUÇÃO CFM N° 2.174/2017, que dispõe sobre a prática do ato anestésico:

Assertiva: recomenda-se que os hospitais mantenham um médico anestesista nas salas de recuperação pós-anestésica.

q0711 [V/F]

Na comparação entre os testes viscoelásticos e os convencionais para monitorização perioperatória da coagulação, temos que os testes viscoelásticos:

Assertiva: apresentam um alto valor preditivo negativo.

q0712 [V/F]

Sobre o propofol, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: o propofol é metabolizado primariamente por conjugação com glicuronídeos e sulfatos - reações hepáticas da fase II - resultando em metabolitos inativos, os quais são eliminados rapidamente pela urina.

q0713 [V/F]

Julgue as afirmativas a seguir:

Assertiva: o septo interventricular contribui para o desempenho de ambos os ventrículos, influenciando a função cardíaca por interação mecânica entre câmaras

q0714 [V/F]

Julgue conceitos básicos sobre a farmacologia abaixo.

Assertiva: A solução de Hill (relação Emax sigmoidal) é representada como: $E = \frac{E_{\text{max}} \cdot C^g}{E_0 + C^g}$, onde E representa o efeito, Emax o efeito máximo, E0 o efeito inicial, C representa a concentração do fármaco, g representa a interseção da curva ou coeficiente de Hill.

q0715 [V/F]

Em relação a fisiologia e farmacologia do sistema urinário, avalie:

Assertiva: o reflexo mioelétrico renal ocorre após 20 segundos e é responsável por até 50% da capacidade de autorregulação renal.

q0716 [V/F]

Em relação ao reflexo oculocardíaco, analise as afirmativas abaixo:

Assertiva: analisando as cirurgias oftalmológicas, o reflexo é mais frequente e intenso em cirurgias para correção do estrabismo, inclusive ocorre em pacientes anestesiados.

q0717 [V/F]

Com relação às particularidades anestésicas na cirurgia para correção de hérnia diafragmática congênita, deve-se:

Assertiva: puncionar acesso venoso central, preferencialmente, em veia jugular.

q0718 [V/F]

Com relação ao atendimento anestésico do paciente vítima de trauma:

Assertiva: o uso de cetamina é uma opção na intubação traqueal de paciente hipotenso com trauma ocular aberto.

q0719 [V/F]

Julgue os aspectos anatômicos e fisiológicos da inervação urogenital.

Assertiva: Inervação testicular conduz sensação aos segmentos torácicos inferiores e lombares superiores via plexo testicular

q0720 [V/F]

Sobre a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA):

Assertiva: laringoespasma é mais comum no interregno entre o estado de anestesia geral e o de totalmente acordado.

q0721 [V/F]

Sobre as particularidades da anestesia para oftalmologia:

Assertiva: a absorção sistêmica de fenilefrina tópica produz hipertensão e bradicardia.

q0722 [V/F]

Sobre suporte ventilatório.

Assertiva: A oxigenação durante a ventilação a jato (jet ventilation) não pode ser monitorada adequadamente usando oximetria de pulso

q0723 [V/F]

Quanto a transfusão de plaquetas, devemos considerar para a profilaxia:

Assertiva: em cirurgias em lugares críticos, como olho ou sistema nervoso central, quando a contagem de plaquetas for $< 100.000/\mu\text{L}$.

q0724 [V/F]

Sobre anestesia ambulatorial:

Assertiva: Recuperação fast track é quando no pós-operatório paciente passa da fase 1 de recuperação direto para fase 2 sem passar pela sala de recuperação pós-anestésica. Bebês a termo cuja idade pós-conceitual é inferior a 46 semanas, ou prematuros bebês cuja idade

q0725 [V/F]

Sobre anestesia venosa:

Assertiva: entre os modelos farmacocinéticos para o propofol, o modelo Paedfusor apresenta o volume do compartimento central e a depuração em uma correlação não-linear com o peso.

q0726 [V/F]

Paciente de 43 anos, sexo masculino, previamente hígido, teve perda súbita de visão, astenia e episódios recorrentes de hipoglicemia e foi diagnosticado com tumor hipofisário grande, de 3cm de diâmetro. Cortisol sérico de 0,5mcg/dL (valor de referência: 5-25mcg/dL). Será submetido à cirurgia para exérese do tumor. A respeito desse caso, responda os itens.

Assertiva: a síntese de aldosterona não é afetada pelo hipopituitarismo, uma vez que ela é liberada pelo estímulo da angiotensina II e pelo aumento do potássio extracelular.

q0727 [V/F]

Sobre a cirurgia do ouvido médio, mastoide e ouvido interno:

Assertiva: há consenso favorável para o uso do óxido nitroso, nas cirurgias do ouvido médio.

q0728 [V/F]

Com relação a ventilação mecânica em anestesia:

Assertiva: Durante a ventilação assistida, a sincronia paciente-ventilador tem um efeito negativo para o paciente.

q0729 [V/F]

Sobre a avaliação pré-anestésica:

Assertiva: no pré-operatório o glicopirrolato é o antissialagogo mais potente, porém tem menor penetração na barreira hematoencefálica do que a atropina devido à sua natureza de amina quaternária.

q0730 [V/F]

Sobre complicações na anestesia:

Assertiva: os métodos de detecção de embolia aérea de maior sensibilidade são: diminuição súbita da pressão parcial de dióxido de carbono ao final da expiração e diminuição da saturação de oxigênio no sangue.

q0731 [V/F]

Paciente do sexo feminino, 32 anos, 150cm e 98kg, será submetida cirurgia de coluna. Sobre as particularidades da anestesia venosa total utilizando propofol e remifentanil:

Assertiva: o modelo de Minto para remifentanil, ao utilizar a massa corporal magra, garante precisão da infusão alvo controlada em pacientes obesos.

q0732 [V/F]

Sobre anestesia em obstetrícia:

Assertiva: O remifentanil é uma alternativa para analgesia controlada pelo paciente (PCA) durante o trabalho de parto. Seu metabolismo depende das esterases teciduais e plasmáticas que estão maduras no feto, portanto a proporção feto-materna é pequena.

q0733 [V/F]

Numa cirurgia de videolaparoscopia você opta por ajustar o ventilador no modo de ventilação com pressão controlada. Neste caso:

Assertiva: quanto menor a pressão ajustada no gerador, menor será o volume corrente.

q0734 [V/F]

Sobre complicações na anestesia:

Assertiva: o risco de broncoaspiração na anestesia é dependente da diferença entre as pressões do esfíncter esofágico inferior e a intragástrica. Fármacos como succinilcolina, neostigmina e metoprolol aumentam o tônus do esfíncter esofágico inferior.

q0735 [V/F]

Sobre bloqueios do neuroeixo:

Assertiva: Nos bloqueios altos do neuroeixo, o volume de reserva expiratório, o pico de fluxo expiratório e a ventilação minuto estão preservados. Náuseas após bloqueio do neuroeixo são consequentes ao aumento do peristaltismo, bem como da

q0736 [V/F]

No que se refere à VNIPP (ventilação não invasiva por pressão positiva):

Assertiva: os fatores limitantes para sua aplicação são: grandes vazamentos, dificuldade de ajuste da máscara facial.

q0737 [V/F]

Sobre os bloqueios de parede abdominal e membros inferiores:

Assertiva: O bloqueio TAP fornece analgesia visceral eficaz para cirurgias abdominais.

q0738 [V/F]

Você é chamado para atender uma parada cardiorrespiratória em uma criança de 4 anos que foi encontrada submersa em uma piscina. A criança está inconsciente, sem respiração e sem pulso detectável. Considerando as diretrizes específicas para ressuscitação pediátrica, julgue:

Assertiva: a profundidade das compressões torácicas deve ser de pelo menos um terço do diâmetro anteroposterior do tórax.

q0739 [V/F]

Sobre a analgesia pós-operatória de amigdalectomia:

Assertiva: bloqueios dos nervos palatino maior e palatino menor possibilitam analgesia de forma mais segura que a injeção com anestésico local na loja amigdaliana.

q0740 [V/F]

Com relação aos bloqueios de neuroeixo:

Assertiva: a queixa de dispnéia em pacientes com bloqueio alto, mesmo com a ventilação minuto normal ou até elevada, se deve à incapacidade de o paciente sentir a parede torácica e os movimentos respiratórios.

q0741 [V/F]

Sobre gerenciamento do centro cirúrgico:

Assertiva: custos fixos são aqueles custos relacionados ao volume de pacientes recebendo cuidados.

q0742 [V/F]

Com relação aos transplantes de órgãos:

Assertiva: nos cirróticos em pré-operatório de transplante hepático, a cintilografia de perfusão miocárdica com dipiridamol é de valor duvidoso devido ao estado hiperdinâmico, o que leva a rápida remoção do fármaco radioativo.

q0743 [V/F]

Com relação aos bloqueios de nervos periféricos:

Assertiva: O índice de sucesso de inserção de catéter para analgesia é maior no bloqueio infraclavicular que no axilar.

q0744 [V/F]

São considerados preditores de hipoxemia durante uma ventilação monopulmonar:

Assertiva: posição supina durante a ventilação monopulmonar.

q0745 [V/F]

Sobre bloqueios periféricos de nervos.

Assertiva: Ultrassom é um som com frequência acima da faixa audível (>20.000 ciclos por segundo).

q0746 [V/F]

Sobre bloqueios periféricos de nervos.

Assertiva: Ondas sonoras de ultra-alta frequência (UHF, maiores que 20 MHz) podem ser usadas para imagens de alta fidelidade e são capazes de obter imagens de 50% a 60% do número total de fascículos dentro de um determinado nervo periférico

q0747 [V/F]

Em relação aos anestésicos inalatórios, avalie as afirmações abaixo:

Assertiva: se tratando de observarmos efeito de amnésia anterógrada com anestésicos inalatórios, é requisitado CAM de 0,5% ou superior.

q0748 [V/F]

Com relação à anestesia e o sistema endócrino:

Assertiva: a adrenalina é a catecolamina mais comumente liberada pelos feocromocitomas.

q0749 [V/F]

São critérios amarelos de moderado risco de gravidade em lesões traumáticas em adultos, segundo o National guideline for the field triage of trauma patients americano?

Assertiva: PAS < 110mmHg. PROVA TRIMESTRAL SUBSTITUTIVA 01/04 – ME3/2025 CCA

q0750 [V/F]

Sobre o íon potássio, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: a aldosterona exerce efeito na manutenção da distribuição sérica normal do potássio, principalmente, por meio da modificação da excreção renal do potássio, ao nível do ducto coletor.

q0751 [V/F]

Sobre anestesia ambulatorial:

Assertiva: Idosos acima de 65 anos são contraindicados à cirurgia ambulatorial devido ao risco aumentado de eventos cardiovasculares adversos no intraoperatório.

q0752 [V/F]

O bloqueio do canal dos adutores é considerado essencial por muitos, dado sua facilidade de execução, área de analgesia e seletividade do bloqueio. A respeito deste bloqueio, julgue:

Assertiva: o bloqueio no canal dos adutores causa menos bloqueio motor que o bloqueio do nervo femoral para analgesia após cirurgias do joelho.

q0753 [V/F]

Com relação às particularidades do recém-nascido prematuro:

Assertiva: a hemorragia intracraniana é uma complicação, cuja incidência é diretamente proporcional à idade gestacional.

q0754 [V/F]

Com relação aos transplantes de órgãos:

Assertiva: a síndrome hepatorenal caracteriza-se pelo desenvolvimento de insuficiência renal em pacientes com insuficiência hepática crônica e, quando descompensada com acidose, distúrbio eletrolítica e sobrecarga de volume, contra-indica o transplante hepático. PROVA TRIMESTRAL 03/04 – ME3/2024 CCA

q0755 [V/F]

Sobre bloqueios periféricos de nervos.

Assertiva: A presença de uma resposta motora evocada em uma corrente de $<0,5\text{mA}$ (duração do pulso de 1 ms) indica relação íntima agulha-nervo, contato agulha-nervo ou uma colocação intraneural da agulha

q0756 [V/F]

O bloqueio do canal dos adutores é considerado essencial por muitos, dado sua facilidade de execução, área de analgesia e seletividade do bloqueio. A respeito deste bloqueio, julgue:

Assertiva: a imagem de duplo contorno no teto do canal indica localização errada.

q0757 [V/F]

Sobre os hormônios adrenocorticais:

Assertiva: a secreção de glicocorticoide é regulada pelo Fator de Liberação de Corticotrofina, liberado pela hipófise.

q0758 [V/F]

Com relação ao risco profissional do anestesiológico:

Assertiva: o anestesiológico é rotineiramente exposto tanto a radiação eletromagnética ionizantes quanto não ionizante. O primeiro é principalmente de lasers e o último principalmente de raios X.

q0759 [V/F]

Com base nas propriedades farmacológicas dos anestésicos locais, avalie as alternativas:

Assertiva: a cloroprocaína tem início de ação lento, sendo evitada em bloqueios de curta duração.

q0760 [V/F]

Com relação aos bloqueios de neuroeixo:

Assertiva: o bloqueio subaracnóideo em nível alto não provoca alterações na filtração glomerular, desde que a pressão arterial média seja mantida acima de 80 mmHg.

q0761 [V/F]

Paciente masculino, 50 anos, 175 cm de altura e 70 kg será submetido a hepatectomia por metástase hepática de carcinoma colorretal. No intraoperatório, após perda sanguínea de aproximadamente 1,5 L, observa-se PAM 72 mmHg, IC de 3,5 L.min⁻¹.m⁻², SatO₂ 98%, SvO₂ de 55%, lactato 39 mg.dL⁻¹, BE -5,6 mmol.L⁻¹ e Hb 7,0 g.dL⁻¹. Sobre este caso:

Assertiva: A SvO₂ está reduzida e expressa a diminuição da taxa de extração de oxigênio (TEO₂) neste caso.

q0762 [V/F]

Sobre anestesia para obstetrícia, responda:

Assertiva: durante a gravidez a pressão venosa central diminui 15-20%.

q0763 [V/F]

Sobre a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA):

Assertiva: visão embaçada, lacrimejamento, vermelhidão, fotofobia e sensação de corpo estranho caracterizam a complicação oftálmica mais comum no pós-operatório.

q0764 [V/F]

Com relação ao bloqueio demonstrado nas imagens abaixo, assinale V ou F.

Assertiva: a estrutura E corresponde ao plexo braquial. PROVA TRIMESTRAL 02/04 – ME2/2024 CCA

q0765 [V/F]

Julgue as afirmativas a seguir:

Assertiva: o aumento da pós-carga tende a elevar o débito cardíaco por aumentar o tempo de ejeção ventricular

q0766 [V/F]

Sobre o choque séptico:

Assertiva: o evento inicial no choque séptico parece ser a interação de um patógeno e receptores específicos (como "toll-like receptors") nas células do sistema imune nato.

q0767 [V/F]

Um paciente de 35 anos, sem comorbidades conhecidas, foi submetido a um procedimento cirúrgico para reparo de uma hérnia inguinal. Durante a cirurgia, foi administrada lidocaína a 1% como anestésico local. Após a administração, o paciente desenvolveu uma perda temporária da sensação na área operada, seguida por uma recuperação gradual após o término da cirurgia. Sobre os efeitos eletrofisiológicos dos anestésicos locais:

Assertiva: conforme a concentração do anestésico local aplicado ao nervo aumenta, ocorre uma diminuição na taxa de despolarização e na amplitude máxima do potencial de ação.

q0768 [V/F]

Com relação ao risco profissional do anestesiológico:

Assertiva: uma regra prática de limite de segurança a exposição de radiação é de 50 rem (500 mSv) por ano, com não mais que 12,5 rem (125mSv) por trimestre.

q0769 [V/F]

Sobre a farmacologia e os efeitos dos bloqueadores neuromusculares (BNMs) na anestesia:

Assertiva: os agentes inalatórios potencializam os efeitos dos BNMs não despolarizantes na seguinte sequência sevoflurano>isoflurano> halotano> Óxido Nitroso.

q0770 [V/F]

Sobre as complicações em anestesia reações anafiláticas/anafilatóides (RAA), hipertermia maligna (HM) e soluções pós-operatórios (SPO), responda:

Assertiva: As RAA em anestesia ocorrem em 90% dos casos durante a indução ou após a administração venosa do agente causador.

q0771 [V/F]

Sobre a fisiologia cardiovascular:

Assertiva: Os canais de cálcio lentos se abrem durante a fase de platô do potencial de ação.

q0772 [V/F]

No que se refere a anestesia para cirurgias bucomaxilofaciais, analise as assertivas abaixo:

Assertiva: recomenda-se o planejamento do manejo da intubação e extubação com o cirurgião-dentista, executor do tratamento, nos pacientes que possuem estruturas dentoesqueléticas reconstruídas pelo Protocolo Branemark.

q0773 [V/F]

Em relação ao fluxo sanguíneo renal é correto afirmar:

Assertiva: o débito cardíaco tem um efeito irrelevante no fluxo sanguíneo renal e filtração glomerular.

q0774 [V/F]

Mulher 68 anos, com obesidade moderada, é submetida a uma cirurgia abdominal prolongada em decúbito dorsal. Durante o procedimento, os braços foram posicionados com abdução superior a 90° e não foi empregado suporte lombar adicional. No pós-operatório, o paciente apresenta dor lombar e queixa de parestesias no braço direito. Avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: a abdução dos braços deve ser limitada a menos de 90° para minimizar o risco de lesões do plexo braquial e compressão das estruturas neurovasculares.

q0775 [V/F]

Um paciente de 35 anos, sem comorbidades conhecidas, foi submetido a um procedimento cirúrgico para reparo de uma hérnia inguinal. Durante a cirurgia, foi administrada lidocaína a 1% como anestésico local. Após a administração, o paciente desenvolveu uma perda temporária da sensação na área operada, seguida por uma recuperação gradual após o término da cirurgia. Sobre os efeitos eletrofisiológicos dos anestésicos locais:

Assertiva: o potencial de repouso da membrana do nervo é significativamente afetado por anestésicos locais.

q0776 [V/F]

Com relação a ventilação mecânica em anestesia:

Assertiva: A pressão motriz (driving pressure) é definida como pressão de platô menos a PEEP, e idealmente deve ser mantida < 25 cm H₂O.

q0777 [V/F]

Com relação ao bloqueio demonstrado nas imagens abaixo, assinale V ou F.

Assertiva: a injeção de anestésico local deve ser realizada com a agulha na posição 1 e não deve ser realizada com agulha na posição 2.

q0778 [V/F]

Com base nas recomendações para reposição volêmica em cirurgias abdominais de urgência, avalie as alternativas:

Assertiva: a infusão excessiva de cristaloides pode gerar sobrecarga hídrica e complicações associadas.

q0779 [V/F]

Sobre os sistemas de Mapleson:

Assertiva: Têm como desvantagem a formação de composto A na presença do sevoflurano

q0780 [V/F]

Sobre equilíbrio ácido básico e manejo de fluidos e de eletrólitos:

Assertiva: diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e desvio à esquerda da curva de dissociação de oxigênio são consequências da alcalemia grave ($\text{pH} > 7,6$).

q0781 [V/F]

Com relação a ventilação mecânica em anestesia:

Assertiva: A ventilação não invasiva com pressão positiva é útil para pacientes em transição da ventilação invasiva para a ventilação espontânea, que apresentam alto risco de falha na extubação.

q0782 [V/F]

Com relação a anestesia pediátrica.

Assertiva: O bloqueio do nervo zigomático-facial é efetivo para analgesia em cirurgias de correção de lábio leporiano.

q0783 [V/F]

Sobre anestesia para ortopedia:

Assertiva: doença cardiovascular, histórico prévio de tromboembolismo venoso, doença neurológica e pontuação na classificação ASA foram fatores de risco significativos e independentes para tromboembolismo venoso em pacientes submetidos a artroplastia total de quadril.

q0784 [V/F]

Com relação às particularidades anestésicas na cirurgia para correção de hérnia diafragmática congênita, deve-se:

Assertiva: puncionar acesso venoso periférico, preferencialmente, nos membros inferiores.

q0785 [V/F]

Na técnica anestésica regional do membro superior:

Assertiva: o bloqueio supraclavicular é uma boa opção em pacientes pouco cooperativos ou com comprometimento respiratório.

q0786 [V/F]

Sobre equilíbrio hidroeletrólítico e acidobásico.

Assertiva: A fórmula do delta anion GAP é $(\text{Anion GAP} - 12) / (24 - [\text{HCO}_3^-])$.

q0787 [V/F]

Sobre a anestesia para cirurgia ortopédica, julgue:

Assertiva: A fixação cimentada da prótese femoral está associada ao risco de síndrome de implantação de cimento-ósseo, resultando em hipotensão intraoperatória, hipóxia ou até mesmo parada cardíaca.

q0788 [V/F]

Sobre suporte ventilatório:

Assertiva: a ventilação com pressão positiva aumenta pressão da veia cava inferior, aumentando a pressão capilar peritubular renal reduzindo a reabsorção tubular de sódio.

q0789 [V/F]

Com relação à hemodinâmica glomerular:

Assertiva: a adenosina diminui a resistência da arteriola aferente e eferente, aumentando a taxa de filtração glomerular.

q0790 [V/F]

Sobre a fisiologia da transmissão neuromuscular e o uso de bloqueadores neuromusculares:

Assertiva: uso da cocaína induz alterações na dinâmica do receptor nicotínico da acetilcolina.

q0791 [V/F]

Em relação a pressão intraocular (PIO), analise as afirmativas abaixo:

Assertiva: o uso prolongado de acetazolamida, ocasiona acidose metabólica, hipopotassemia, hiponatremia e desidratação.

q0792 [V/F]

Sobre suporte ventilatório:

Assertiva: na ventilação protetora pulmonar utiliza-se 6 mL/kg de peso corporal predito com pressões de platô inferiores a 30 cmH₂O.

q0793 [V/F]

Sobre anestesia venosa:

Assertiva: o remifentanil detém, entre os opioides, a maior sinergia com o propofol.

q0794 [V/F]

Características da síndrome da infusão do propofol:

Assertiva: taquicardia refratária, seguida de fibrilação e assistolia.

q0795 [V/F]

Com relação à farmacologia dos anestésicos venosos.

Assertiva: Benzodiazepínicos interagem entre a subunidade α e γ do receptor GABA A, sendo a subunidade γ necessária para a ligação do fármaco.

q0796 [V/F]

Nos capnógrafos de fluxo principal (mainstream) e fluxo lateral (sidestream):

Assertiva: erro de diluição está associado ao de fluxo lateral.

q0797 [V/F]

Com relação à hemodinâmica glomerular:

Assertiva: anti-inflamatórios não esteroidais aumentam a resistência das arteríolas aferente e eferente, reduzindo a taxa de filtração glomerular.

q0798 [V/F]

Pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos estão expostos a risco variável de apresentar alterações cognitivas no período pós-operatório. Com base nisso, avalie:

Assertiva: a enolase específica do neurônio é marcador bioquímico preditor de disfunção cognitiva do pós-operatório (DCPO).

q0799 [V/F]

Sobre os sistemas e aparelhos para administração de agentes inalatórios:

Assertiva: vaporizadores quando inclinados, podem preencher a área de desvio variável com líquido anestésico, mas mesmo assim não alteram a concentração anestésica final. PROVA TRIMESTRAL 01/04 – ME2/2024 CCA

q0800 [V/F]

Com relação a anestesia para geriatria, assinale V ou F.

Assertiva: Em idoso com demência, uso de antipsicóticos apresenta risco aumentado de acidentes vasculares encefálicos e mortalidade.

q0801 [V/F]

Sobre os bloqueios de parede abdominal e membros inferiores:

Assertiva: A técnica guiada por ultrassom no bloqueio canal dos adutores posiciona o transdutor na coxa anteromedial para localizar a membrana vastoalutadora entre os músculos vasto medial e sartório.

q0802 [V/F]

Sobre avaliação e preparo pré-anestésico:

Assertiva: indivíduos com estimuladores cerebrais profundos devem manter os dispositivos ativados no pré-operatório e no perioperatório mesmo nas cirurgias que utilizam eletrocautério.

q0803 [V/F]

A respeito das complicações da anestesia, julgue:

Assertiva: raquianestesia é fator protetor para hipotermia perioperatória.

q0804 [V/F]

Sobre ética na prática da anestesiologia, responda:

Assertiva: a doação de órgãos só pode ser realizada com a autorização da família, independentemente da vontade expressa em vida pelo potencial doador.

q0805 [V/F]

Sobre anestesia em obstetrícia.

Assertiva: A atividade da colinesterase plasmática (pseudocolinesterase) aumenta aproximadamente 25% a 30% a partir da 10ª semana de gestação e dura até 6 semanas pós-parto.

q0806 [V/F]

Alguns conhecimentos são fundamentais para se iniciar uma pesquisa científica:

Assertiva: estudos de caso-controle são estudos de duração curta, adequado para doenças raras, porém inadequado para estudar incidência e prevalência.

q0807 [V/F]

O manuseio de doadores de órgão antes da captação deve seguir:

Assertiva: uso rotineiro de solução contendo dextrose.

q0808 [V/F]

Na anestesia para transplantes quais os objetivos para manutenção do potencial doador?

Assertiva: Pressão parcial de oxigênio PaO₂ ≥ 300 mmHg.

q0809 [V/F]

Em relação aos analgésicos e adjuvantes não opioides no controle da dor pós-operatória:

Assertiva: O paracetamol em doses terapêuticas é seguro nos pacientes etilistas crônicos.

q0810 [V/F]

Na metodologia científica de estudo populacionais:

Assertiva: estudos de caso controle reúnem participantes com base no seu estado de exposição (expostos e não expostos) e acompanhamos com o tempo para averiguar a presença de desfechos.

q0811 [V/F]

Durante um plantão na UTI, você é chamado para atender uma parada cardiorrespiratória. O paciente de 58 anos, diabético e hipertenso, estava internado por pneumonia. Ao chegar, a equipe de enfermagem já iniciou as compressões torácicas. O monitor mostra fibrilação ventricular.

Assertiva: A vasopressina é uma alternativa válida em substituição a epinefrina na parada cardíaca por fibrilação ventricular.

q0812 [V/F]

Você irá fazer um bloqueio periconal para realização de uma retinopexia e deseja acinesia completa do olho e da pálpebra, com relação a este bloqueio podemos afirmar:

Assertiva: acinesia do músculo elevador da pálpebra é obtida pelo bloqueio do VII par craniano.

q0813 [V/F]

Em relação aos agonistas opioides utilizados em analgesia pós-operatória, sabe-se:

Assertiva: Metadona é segura nos pacientes com intervalos QT maiores ou iguais a 500 milissegundos no ECG.

q0814 [V/F]

Sobre gerenciamento do centro cirúrgico:

Assertiva: a análise operacional baseada em dados do prontuário eletrônico de saúde e da documentação intraoperatória pode refinar estimativas de duração cirúrgica e apoiar decisões de alocação de recursos no centro cirúrgico.

q0815 [V/F]

Complicações pulmonares pós-operatórias são uma importante causa de morbimortalidade hospitalar após grandes cirurgias. Com relação às estratégias protetoras de ventilação mecânica intraoperatória:

Assertiva: o escore ARISCAT pode ser usado na predição de complicações pulmonares pós-operatórias, sendo composto por cinco variáveis.

q0816 [V/F]

Para a realização do bloqueio do nervo safeno no canal dos adutores, é importante conhecer a anatomia da região. A respeito da anatomia mostrada na imagem:

Assertiva: O músculo destacado com a legenda "B" é o vasto medial.

q0817 [V/F]

Quanto aos anestésicos locais (AL):

Assertiva: O nível sanguíneo de AL necessário para produzir toxicidade no sistema nervoso central é geralmente inferior ao que resulta em colapso circulatório.

q0818 [V/F]

Com relação aos princípios norteadores do cuidado centrado no paciente em relação a qualidade e segurança.

Assertiva: Os dois pontos-chave fundamentais do processo Seis Sigma (six sigma process) são um processo virtualmente livre de erros e intenso foco na redução da variabilidade.

q0819 [V/F]

Sobre a dor pós-operatória:

Assertiva: a dor aguda é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a dano tecidual real ou potencial.

q0820 [V/F]

No manuseio do sistema respiratório circular, valvular com absorvedor de CO₂, observa-se:

Assertiva: estabilidade da concentração do anestésico inalatório.

q0821 [V/F]

Sobre os absorvedores de CO₂ usados nos sistemas circular durante anestesia inalatória:

Assertiva: o soda lime é altamente eficiente na absorção de CO₂, e a capacidade absorvente do lime de hidróxido de cálcio é aproximadamente 50% menor do que a de absorventes que contêm bases fortes.

q0822 [V/F]

Com relação às vias aéreas e seu manejo:

Assertiva: a concha nasal suprema localiza-se no meato nasal superior.

q0823 [V/F]

Em relação ao Eletroencefalograma Processado (EEG):

Assertiva: a oscilação da voltagem do EEG é suficientemente irregular, de modo que a voltagem medida em um instante não permite uma previsão exata da voltagem no instante seguinte

q0824 [V/F]

Durante a infusão de fármacos para realização de anestesia venosa alvo- controlada aplicam-se conceitos farmacodinâmicos e farmacocinéticos:

Assertiva: a histerese é o atraso entre a concentração plasmática máxima e a concentração máxima no local do efeito.

q0825 [V/F]

Paciente foi submetido a raquianestesia para realização de desbridamento cirúrgico de membros inferiores a nível ambulatorial. Fazem parte dos critérios de alta hospitalar:

Assertiva: dor, náuseas e vômitos devem ser mínimos e isso representa uma pontuação de 2.

q0826 [V/F]

São critérios amarelos de moderado risco de gravidade em lesões traumáticas em adultos, segundo o National guideline for the field triage of trauma patients americano?

Assertiva: Queda de altura maior que > 3 metros.

q0827 [V/F]

Mulher de 74 anos, com histórico de HAS e DM2, dá entrada no pronto-socorro com dor abdominal difusa, distensão, hipotensão (PA 82×48 mmHg) e taquicardia. Exames laboratoriais mostram acidose metabólica (BE -6,5) e lactato 4,9 mmol/L. A tomografia sugere perfuração de alça intestinal com peritonite difusa. A equipe decide por laparotomia de urgência. Com base nas recomendações atuais do modelo de cuidado orientado por desfecho (ELPQuIC), avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: acesso venoso central e arterial são contraindicados na fase pré-operatória devido ao risco de atraso cirúrgico.

q0828 [V/F]

Uma paciente de 55 anos, submetida a uma cirurgia abdominal de longa duração em decúbito dorsal, apresentou no pós-operatório queixas de formigamento e fraqueza no braço esquerdo, além de queixas de dor lombar intensa. Durante a cirurgia, observou-se que os braços foram posicionados com abdução superior a 90° e que não houve suporte lombar adequado. Com base no caso clínico avalie as alternativas abaixo:

Assertiva: a abdução dos braços acima de 90° aumenta o risco de estiramento e compressão do plexo braquial, podendo levar a neuropatias perioperatórias.

q0829 [V/F]

Sobre os equipamentos para infusão alvo controlada (Target-Controlled-Infusion)- TCI observa-se que:

Assertiva: na infusão plasma há um menor tempo de equilíbrio entre concentração plasmática e a biofase.

q0830 [V/F]

Sobre ética na prática da anestesiologia, responda:

Assertiva: durante a avaliação pré-anestésica, identifica-se sorologia positiva para HIV em um paciente, que expressa o desejo de manter essa informação em sigilo. Nesse contexto, a autonomia do paciente deve ser respeitada, e o médico tem a obrigação ética e legal de garantir a confidencialidade das informações, assegurando o sigilo profissional.

q0831 [V/F]

Sobre o Estatuto da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA):

Assertiva: o Conselho Fiscal é um órgão consultivo, independente da Diretoria, constituído pelos três últimos Diretores(as) Presidentes da SBA e pelos Presidentes das Regionais.

q0832 [V/F]

Paciente chega ao centro cirúrgico para realização, em caráter de emergência, de laparotomia exploradora por ferimento de arma branca durante briga em bar há 30 minutos. Informa ingestão de álcool. Cirurgião não está no hospital. Sobre este caso, julgue:

Assertiva: o anestesiologista está autorizado a iniciar o ato anestésico mesmo antes do cirurgião estar presente no bloco cirúrgico, devido ao cenário de emergência.

q0833 [V/F]

Sobre as complicações em anestesia reações anafiláticas/anafilatóides (RAA), hipertermia maligna (HM) e soluções pós-operatórias (SPO), responda:

Assertiva: Os sintomas/sinais de RAA grave surgem nos primeiros 5 min em um terço dos casos; até 10 min em outro terço dos casos e acima de 30 min no último terço dos casos. PROVA TRIMESTRAL 04/04 – ME1/2024 CCA

q0834 [V/F]

Em relação à transfusão sanguínea e derivados:

Assertiva: a vantagem do concentrado de hemácias em relação ao sangue total é ter a mesma capacidade de transporte de oxigênio aos tecidos além da redução dos níveis de anticorpos presentes nas bolsas por conter menor quantidade de plasma.

q0835 [V/F]

Sobre a farmacologia dos anestésicos inalatórios:

Assertiva: Os efeitos analgésicos do óxido nitroso duram cerca de 2 h após o término do efeito hipnótico.

q0836 [V/F]

Em relação aos analgésicos e adjuvantes não opioides no controle da dor pós-operatória:

Assertiva: Gabapentina e pregabalina atenuam o fenômeno de tolerância decorrente do uso crônico de opioides.

q0837 [ME]

Com relação às técnicas e possíveis complicações associadas à anestesia para cirurgia plástica, podemos afirmar que:

- A)** são procedimentos que necessitam de relaxamento muscular intenso.
- B)** uma das principais manifestações clínicas da embolia gordurosa é o rash petequial.
- C)** anestesia hipotensiva, com pressão arterial média inferior a 90 mmHg, deve ser evitada.
- D)** agitação pós-operatória tem pouca repercussão no resultado cirúrgico em plásticas de face.

q0838 [ME]

Na administração de anestesia para neurocirurgia, qual das seguintes estratégias é mais apropriada para a proteção cerebral?

- A)** Administração de dexametasona imediatamente antes da cirurgia para reduzir o edema cerebral.
- B)** Uso rotineiro de diuréticos osmóticos para reduzir o volume cerebral intracelular e extracelular durante a cirurgia.
- C)** Hiperventilação induzida para redução sustentada da pressão intracraniana e relaxamento cerebral durante toda a cirurgia.
- D)** Manter a pressão de perfusão cerebral em níveis normais ou levemente elevados durante a cirurgia, especialmente após hemorragia subaracnóidea.

q0839 [ME]

Homem de 22 anos, 82 kg e 1,75 m deu entrada na emergência, após acidente automobilístico, com equimose na região do pescoço, sensibilidade, enfisema subcutâneo na região cervical e achatamento do pomo de adão. Apresentava-se lúcido e cooperativo, mas com dificuldade de respirar e FC = 120 bpm; Pa = 90 × 40 mmHg e SaO₂ = 82%. Qual a conduta mais adequada em relação à via aérea nesse caso?

- A)** Acessar a via aérea com o paciente acordado por meio de broncofibroscopia.
- B)** Proceder à cricotireostomia para garantir a via aérea, já que o paciente se apresenta instável.
- C)** Intubar com laringoscópio convencional depois da indução com cetamina e dexmedetomidina.
- D)** Realizar tomografia computadorizada na região cervical e, posteriormente, acessar a via aérea com laringoscopia convencional.

q0840 [ME]

Com o processo de envelhecimento, ocorrem as seguintes alterações fisiológicas:

- A)** resposta renal exarcebada à aldosterona e à renina.
- B)** disfunção sistólica com manutenção da função diastólica.
- C)** redução da resposta ventilatória à hipóxia e à hipercarbica.
- D)** aumento da resposta dos receptores beta adrenérgicos.

q0841 [ME]

Sobre o Estatuto, Regulamentos e Regimentos da SBA, assinale a alternativa correta:

- A)** Os novos membros aspirantes terão sua inscrição homologada após a comunicação oficial do diretor científico de sua regional à Comissão de Ensino e Treinamento da SBA e do pagamento da anuidade através de sua regional.
- B)** A SBA expedirá em convênio com a Associação Médica Brasileira (AMB), o Título de Especialista em Anestesiologia (TEA) para médicos não membros ou membros adjuntos da SBA, devidamente aprovados em concurso processado na forma do seu regulamento.
- C)** O Título Superior em Anestesiologia (TSA) é irrevogável uma vez que o candidato seja devidamente aprovado em concurso processado sob o regulamento do TSA.
- D)** São membros remidos os membros ativos e adjuntos que completem 60 anos no ano em curso, continuando com os mesmos direitos da categoria que pertenciam.

q0842 [ME]

Mulher de 28 anos, 80 Kg e 1,70 m foi submetida à laparotomia exploradora para drenagem de abscesso pélvico. Evoluiu no pós-operatório com síndrome da angústia respiratória do adulto e hipoxemia refratária, sendo colocada em posição prona. Você espera uma melhora da hipoxemia devido a (ao):

- A)** melhora da performance cardiovascular
- B)** melhora da complacência da caixa torácica
- C)** aumento da perfusão em segmentos anteriores dos pulmões
- D)** posicionamento de 2/3 dos pulmões em situação não dependente

q0843 [ME]

Homem de 56 anos, 88 Kg e 1,75 m é submetido à nefrectomia e adrenalectomia à direita além de hepatectomia segmentar por neoplasia renal avançada. Além do básico obrigatório, o paciente foi monitorizado com pressão arterial invasiva e cateter de artéria pulmonar. Cerca de 3 horas após o início da cirurgia, a perda de sangue estimada é de 1,5 litro. O paciente apresenta PAM de 70 mmHg, -1 -2 -1 IC de 3,5 L.min .m , SaO₂ de 98%, SvO₂ de 58% e Hb de 7,0 g.dL . Você opta pela transfusão de -1 -2 concentrado de hemácias e observa queda do IC para 3,0 L. min .m e elevação da SvO₂ para 65%. Que mecanismo pode explicar a redução do IC?

- A)** Aumento da pós-carga
- B)** Disfunção miocárdica associada à hipotermia
- C)** Adequação do IC à nova condição hemodinâmica
- D)** Depressão miocárdica por mediadores inflamatórios

q0844 [ME]

Você opta pela infusão contínua de propofol em bomba de infusão para realizar anestesia venosa -1 total conforme o modelo de Bristol: infusão rápida inicial de 1mg.kg para indução seguida de -1 -1 -1 -1 infusão de 10 mg.kg .h por 10 minutos, 8 mg.kg .h nos 10 minutos subsequentes e manutenção -1 -1 com 6 mg.kg .h . A explicação para esta forma de administração de propofol deve-se à (ao):

- A)** volume de distribuição reduzido
- B)** taxa de manutenção baseada na depuração
- C)** distribuição compartimental farmacocinética errática
- D)** depuração relacionada à meia vida contexto dependente

q0845 [ME]

Homem de 66 anos, 82 Kg e 1,70 m com história de hipertensão arterial controlada será submetido à ressecção transuretral da próstata. Após 35 minutos de procedimento, o paciente se torna confuso e letárgico e apresenta PA de 180x110 mmHg e FC de 45 bpm. O anestesiológista opta pela restrição volêmica associada a administração de cloreto de sódio a 3% e furosemida. A efetividade deste tratamento está relacionada à (ao):

- A)** reestabelecimento da pressão coloidal no plasma.
- B)** redução da pressão hidrostática na microcirculação cerebral
- C)** coeficiente de reflexão do sódio na barreira hemato-encefálica.
- D)** efeito reológico da solução hipertônica na microcirculação cerebral

q0846 [ME]

Mulher, 25 anos, na 39ª semana de gestação, duas semanas após resolução de uma infecção respiratória, apresenta quadro súbito e progressivo de fraqueza muscular bilateral simétrica, que se iniciou pelos membros inferiores e evoluiu para braços e tronco. Diagnosticada com Síndrome de Guillain-Barré (SGB), evolui com óbito fetal e tem indicação de cesareana. Está confinada à cama, mas sem necessidade de ventilação mecânica. Para realização de anestesia nesta paciente, pode-se afirmar que:

- A)** a succinilcolina é o relaxante muscular indicado.
- B)** os agentes inalatórios são adequados para manutenção da anestesia.
- C)** existe resistência ao uso de bloqueadores neuromusculares adespolarizantes.
- D)** a anestesia peridural é a opção mais segura.

q0847 [ME]

Homem de 78 anos, 90 Kg e 1,75 m será submetido à colectomia total. O paciente apresenta miocardiopatia dilatada com marcapasso definitivo. Você decide induzir a anestesia com etomidato, fentanil e cisatracurio. Logo após a indução o paciente cursa com assistolia sem comando do marca-passo. A melhor explicação para este evento é o(a):

- A)** inibição do comando do marcapasso por miopotenciais
- B)** efeito inibidor do nodo átrio ventricular por supressão adrenal
- C)** redução do influxo de cloro pelo bloqueio gabaérgico no feixe de His
- D)** diminuição da sensibilidade do miocárdio ao estímulo elétrico pelo bloqueio do canal de sódio

q0848 [ME]

Homem de 22 anos, 72 kg e 1,89 m foi agendado para uma ressecção eletiva de tumor da fossa posterior na posição sentada. Qual dos seguintes métodos será o melhor para monitorar a isquemia do tronco cerebral?

- A)** Índice bispectral.
- B)** EEG de 16 canais.
- C)** Potenciais evocados visuais.
- D)** Potenciais evocados auditivos.

q0849 [ME]

Mulher, 23 anos, 82 Kg e 1,65 m, será submetida à mamoplastia redutora. Recebeu anestesia -1 -1 geral balanceada com desflurano 6%, oxigênio 0,3 L.min e óxido nitroso 0,5 L.min . O anestesiológista observou um aumento inicial da concentração expirada de oxigênio seguido por uma queda gradual no analisador de gases. Qual é a possível explicação para este fato?

- A)** Efeito segundo gás do óxido nitroso
- B)** Saturação do circuito pelo desflurano
- C)** Menor absorção sistêmica do óxido nitroso inicial
- D)** Inibição da vasoconstrição pulmonar hipóxica pelo desflurano

q0850 [ME]

Mulher de 44 anos, 68 Kg e 1,60 m será submetida à histerectomia total ampliada convencional (Wertheim-Meigs). Como a paciente se recusou ao bloqueio do neuroeixo, foi instalada bomba de analgesia controlada pela paciente com morfina no pós-operatório. A programação era: infusão -1 contínua de 2 mg.h , bolus de 2 mg, intervalo de 15 minutos e limite de 4 horas de 20 mg. Após 12 horas, a paciente apresentou depressão respiratória grave. Qual parâmetro da programação descrita melhor justifica este evento adverso?

- A)** Dose de bolus
- B)** Infusão contínua
- C)** Limite de 4 horas
- D)** Intervalo de 15 minutos

q0851 [ME]

Qual é o fator de risco para perda visual pós-operatória por neuropatia isquêmica do nervo óptico após cirurgia de coluna?

- A)** Gênero feminino
- B)** Utilização de colóide sintético
- C)** Tempo anestésico prolongado
- D)** Presença de neoplasia maligna

q0852 [ME]

Quanto a ação do etomidato sobre o sistema endócrino:

- A)** diminui o 11-deoxicortisol.
- B)** aumenta a produção de aldosterona.
- C)** inibe de forma dose dependente a 11 β -hidroxilase.
- D)** estimula de forma dose dependente 17 α -hidroxilase.

q0853 [ME]

Paciente de 35 anos, gesta I, sem comorbidades prévias com gestação de 26 semanas, na consulta pré-natal refere mal-estar e cefaleia. Ao exame apresenta PA- 165/90 mmHg sem demais alterações. Encaminhada para realização de exames que mostraram: Hb de 10 g.dL-1, bilirrubinas totais aumentadas com predomínio de indiretas (3,5 mg.dL-1), aspartato aminotransferase de 70 UI.L-1, plaquetas de 80000 mm-3 e dosagem de proteína na urina de 24 horas de 350 mg.dL-1. Considerando os dados apresentados, avalie:

- A)** o uso profilático de sulfato de magnésio é contraindicado nas parturientes em pré-eclâmpsia.
- B)** os níveis elevados de proteinúria na urina de 24 horas corroboram com o diagnóstico de eclâmpsia neste caso.
- C)** o quadro descrito acima caracteriza uma síndrome HELLP associada a eclâmpsia levando a piora do prognóstico.
- D)** o nível pressórico acima deve ser tratado, pois apresenta risco elevado de hemorragia cerebral, coagulopatia e edema pulmonar.

q0854 [ME]

Homem de 45 anos, 80 kg e 1,78 m foi vítima de queimadura de segundo e terceiro grau causada por fogos de artifício há duas horas, com comprometimento de 25% da superfície corporal. A reposição volêmica nas primeiras 24 horas deve ser feita com:

- A)** Albumina humana a 20%, 160 mL.
- B)** Plasma fresco congelado, oito unidades.
- C)** Ringer lactato, 8.000 mL, sendo $\frac{1}{2}$ nas primeiras oito horas.
- D)** Albumina humana a 20%, 800 mL, sendo metade nas primeiras oito horas.

q0855 [ME]

Mulher de 56 anos, 87 kg e 1,62 m, portadora de hipertensão arterial sistêmica e diabetes, será submetida a microcirurgia para tumor cerebral sob anestesia geral, com previsão de pós-operatório em UTI. Faz uso regular de losartana e metformina, com hemoglobina glicada pré-operatória de 7%. Durante a cirurgia, foi evidenciada glicemia capilar de 212 mg/dL. Sobre esse caso:

- A)** A cirurgia deveria ter sido adiada para melhor controle glicêmico pré-operatório.
- B)** A glicemia intraoperatória está dentro de um valor aceitável, sem necessidade de intervenção terapêutica.
- C)** É recomendado iniciar infusão contínua de insulina por via endovenosa e dosagem periódica da glicemia.
- D)** Considerando ser uma neurocirurgia, o controle glicêmico deve ser rigoroso, com administração de insulina e alvo de glicemia < 110 mg/dL.

q0856 [ME]

Mulher de 24 anos, 78 Kg e 1,65 m, G1 P0 A0, com história de insuficiência cardíaca congestiva, fraqueza muscular proximal e lesão pulmonar restritiva à espirometria. Encaminhada para cesariana com 36 semanas de gestação. Realizada indução em sequência rápida com fentanil, propofol e succinilcolina. Logo após a confirmação da intubação traqueal, o paciente evoluiu com dificuldade de ventilação por rigidez muscular e parada cardiorrespiratória. A causa implícita mais provável deste evento é a:

- A)** Miastenia Gravis.
- B)** Distrofia Miotônica.
- C)** Síndrome de Lambert-Eaton.
- D)** Distrofia Muscular de Duchenne.

q0857 [ME]

Anestesiologistas devem antecipar o risco de hipoxemias mais intensas durante ventilações monopulmonares para combinar o manejo perioperatório com o time cirúrgico. Qual dos seguintes é preditor de hipoxemia durante a ventilação monopulmonar?

- A)** Pacientes com doença pulmonar crônica no lado a ser operado que apresentam diminuição de ventilação e perfusão deste lado.
- B)** Toracotomias à esquerda (em comparação com toracotomias à direita).
- C)** Pacientes que apresentam melhor PaO₂ durante a ventilação nos dois pulmões.
- D)** Pacientes com melhores funções em espirometrias pré-operatórias.

q0858 [ME]

Sobre os absorvedores de dióxido de carbono (CO₂) utilizados nos aparelhos de anestesia:

- A)** O absorvedor de CO₂ mais utilizado no Brasil é a cal baritada.
- B)** O componente com maior concentração na cal sodada é o hidróxido de sódio.
- C)** O início do processo de absorção de CO₂ se dá pela sua reação com a água contida nos grânulos.
- D)** A mudança de coloração dos grânulos se dá pela presença de um indicador de pH e ocorre pelo aumento da concentração de OH.

q0859 [ME]

Homem de 45 anos, portador de insuficiência renal crônica, faz hemodiálise há três anos. Procura o hospital por oclusão da fístula arteriovenosa. Foi encaminhado para a instalação de cateter de diálise peritoneal contínua. É sabidamente portador do vírus da hepatite B. Durante o procedimento, houve perfuração acidental no cirurgião, que refere ter recebido a segunda dose da vacina contra a hepatite B há três meses. Nesse caso:

- A)** Deve-se administrar a imunoglobulina hiperimune (HBIG) contra a hepatite B e complementar o esquema vacinal.
- B)** A frequência de transmissão do vírus da hepatite B é alta, porém métodos de autoclavagem garantem a inviabilidade do vírus.
- C)** A dosagem de anti-Hbs com valor maior ou igual a 10 mUI.mL⁻¹ demonstra imunidade adquirida e nenhum tratamento é indicado.
- D)** Deve-se solicitar dosagens do antígeno de superfície da hepatite B (HbsAg) e do anticorpo ao antígeno de superfície (anti-Hbs) e administrar a HBIG após 48 horas do contato.

q0860 [ME]

Homem de 48 anos, 57 Kg e 1,78 m com histórico de alcoolismo e cirrose será submetido à correção cirúrgica de hérnia umbilical encarcerada. Apresenta-se emagrecido, com ascite e sinais leves de encefalopatia hepática em uso de furosemida, propranolol e lactulose. Os exames laboratoriais evidenciam elevação progressiva de ureia e creatinina nas últimas semanas, além de hiponatremia e sódio urinário baixo. Durante a realização do procedimento sob anestesia geral, o paciente cursa com hipotensão e oligoanúria refratárias a volume. A melhor conduta para preservação da função renal pós-operatória nesta situação é a administração de:

- A)** manitol
- B)** dobutamina
- C)** terlipressina
- D)** fenoldopam

q0861 [ME]

Homem de 60 anos, 70 kg e 1,70 m será submetido a uma cirurgia de urgência. Durante a avaliação pré-operatória, você observa nos exames laboratoriais um clearance de creatinina de 20 mL.min⁻¹. Considerando as características farmacocinéticas dos bloqueadores neuromusculares e seus reversores, marque a opção correta:

- A)** o vecurônio tem como principal metabólito, o 3-desacetilvecurônio, que é inativo e por isso pode ser utilizado em pacientes com alteração da função renal.
- B)** o rocurônio possui excreção principalmente renal, além de possuir metabólito ativo que prolonga o bloqueio neuromuscular em pacientes com insuficiência renal.
- C)** o cisatracúrio tem 77% do clearance realizado por eliminação de Hoffman, sendo uma opção segura em pacientes com alteração da função renal.
- D)** o sugamadex é uma boa opção em pacientes com depuração de creatinina menor que 30 mL.min⁻¹, já que o complexo sugamadex rocurônio é excretado na bile.

q0862 [ME]

Paciente jovem com história de asma brônquica controlada foi submetido a cirurgia para correção de desvio de septo nasal. No pós-operatório evoluiu com epistaxe importante.

- A)** Existe uma propensão em desencadear o reflexo de Kratschmer.
- B)** Na eventualidade de manipulação dos seios paranasais está contraindicado o uso de óxido nitroso.
- C)** Em casos extremos há necessidade de ligadura da artéria esfenopalatina, ramo da artéria carótida interna.
- D)** Na reintervenção cirúrgica para tratamento do epistaxe, está contraindicada a indução em sequência rápida.

q0863 [ME]

Na abordagem endovascular de aneurisma da artéria cerebral média durante anestesia geral, um quadro de vasoespasmo se instalou. Qual a conduta indicada?

- A)** administrar cloreto de cálcio.
- B)** inserir stent cerebral.
- C)** instaurar hipotensão permissiva.
- D)** injetar milrinona intraarterial.

q0864 [ME]

Sobre a Síndrome da Dor Complexa Regional (SDCR), podemos afirmar que:

- A)** existem dois tipos de SDCR, sendo que a do tipo II era previamente conhecida como distrofia simpática reflexa.
- B)** testes diagnósticos específicos estão disponíveis na SDCR.
- C)** sua incidência atinge o pico na quinta década de vida.
- D)** é mais comum no sexo masculino.

q0865 [ME]

Mulher de 50 anos, 65 kg e 1,65 m, hipertensa, acromegálica em uso de octreotida, é submetida a hipofisectomia transfenoidal. No final da cirurgia, a paciente apresentou volume urinário de 1 L/h e queda significativa da pressão arterial sistêmica. O anestesiológista iniciou conduta de acordo com a hipótese diagnóstica:

- A)** Noradrenalina em baixa dose contínua.
- B)** Correção do desequilíbrio de magnésio, potássio e glicose.
- C)** Início da reposição hormonal da extensão da hipófise supresselar.
- D)** Reidratação vigorosa com solução salina a 0,45% até o estado de normovolemia.

q0866 [ME]

Mulher de 32 anos, 79 kg e 1,65 m, grávida de 37 semanas, com história de insuficiência cardíaca congestiva com fibrilação atrial, em uso de enoxaparina, 40 mg SC, uma vez ao dia (última dose há cinco horas), será submetida a cesariana sob anestesia geral por sofrimento fetal agudo. Após indução em sequência rápida com fentanil, propofol e succinilcolina, evolui com parada cardiorrespiratória em assistolia. As manobras de reanimação são iniciadas, e a capnometria no quarto minuto de massagem cardíaca externa é de 7 mmHg. Qual a conduta nesse momento?

- A)** Administrar atropina.
- B)** Utilizar vasopressores.
- C)** Proceder à cesariana de emergência.
- D)** Manter as manobras de reanimação por mais 10 minutos.

q0867 [ME]

Mulher de 23 anos, 55 Kg e 1,60 m é submetida à apendicectomia de urgência. Durante a cirurgia ocorre uma mudança na alça fluxo-volume (alça da esquerda para a alça da direita na figura 1) e a curva fluxo-tempo passa a se mostrar como na figura 2. Neste momento, observa-se aumento progressivo da pressão de pico de vias aéreas e queda da SpO₂ para 92%. Para melhorar a ventilação nesta paciente você deve: Figura 1 Figura 2

- A)** reduzir fluxo inspiratório
- B)** aumentar o tempo expiratório
- C)** aumentar a frequência respiratória
- D)** aumentar a pressão positiva expiratória final

q0868 [ME]

Homem, 76 anos, portador de doença de Parkinson em uso de Levodopa de 4/4 horas. Foi encaminhado para instalação de eletrodos cerebrais na tentativa de controle dos tremores.

- A)** O uso de benzodiazepínicos como medicação pré-anestésica tem ótima aceitação para melhor tranquilidade do paciente.
- B)** A sedação não deve suprimir os movimentos durante a estimulação e uma boa opção de medicamento é a dexmedetomidina em baixas doses.
- C)** A falha de bloqueio do ramo medial do nervo supraorbitário é responsável por uma analgesia insuficiente durante a instalação do arco de estereotaxia.
- D)** A primeira etapa do procedimento consta da instalação do arco de estereotaxia com o objetivo de colocação de eletrodos próximos a estruturas superficiais do cérebro.

q0869 [ME]

Homem de 27 anos, 75 Kg e 1,80 m é submetido à artroscopia de joelho sob raquianestesia. Após 25 minutos do bloqueio subaracnóideo, o paciente apresentou parada cardiorrespiratória (PCR) e o anestesiológista solicitou sua ajuda. Você percebe que todos os alarmes de monitor estão desligados inclusive o volume da oximetria de pulso. Além disso, o anestesiológista estava fora da sala no momento da ocorrência, mas refere que após o posicionamento do paciente em decúbito dorsal, o nível sensitivo do bloqueio estava em T8. Qual deve ter sido o primeiro sinal de que o paciente evoluiria para PCR?

- A) Bradicardia
- B) Dessaturação
- C) Hipotensão arterial
- D) Rebaixamento do nível de consciência

q0870 [ME]

Homem de 68 anos, 70 Kg e 1,70 m, será submetido à cineangiocoronariografia. Apresenta diabetes tipo 2 e insuficiência cardíaca congestiva há 12 anos. Imediatamente após a angioplastia da artéria descendente anterior, com reperfusão plena, o paciente evoluiu com fibrilação ventricular. A arritmogênese desencadeada pela reperfusão pode ser justificada pela ação dos receptores miocárdicos pós-sinápticos:

- A) alfa 1
- B) alfa 2
- C) beta 1
- D) beta 2

q0871 [ME]

Homem de 42 anos, 80 kg e 1,80 m, sem comorbidades, não tabagista, será submetido a artroscopia de joelho sob raquianestesia. Apresentou saturação de oxigênio de 85% ao ser monitorizado na sala de operação sem sedação prévia. O anestesiológista, para tentar corrigir tal saturação, administrou oxigênio, 5 L/min, a 100% sob máscara de Hudson, mas o paciente continuava apresentando 85% no oxímetro de pulso. Esse paciente pode apresentar:

- A) Um caso leve de sulfo-hemoglobinemia, de modo que absorve pouco a luz infravermelha (660 nm) no oxímetro de pulso.
- B) Meta-hemoglobinemia com absorção de uma quantidade significativa de luz em 660 nm e 940 nm no oxímetro de pulso.
- C) Policitemia com pouca absorção de luz vermelha e infravermelha, com saturação fixa de 85% no oxímetro de pulso.
- D) Intoxicação por monóxido de carbono, em que a carboxi-hemoglobina absorve luz a 660 nm, que é semelhante à da oxi-hemoglobina, por isso o oxímetro de pulso está falsamente em 85%.

q0872 [ME]

Um homem de 75 anos, 50 kg e 1,65 m, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, foi programado para ser submetido à lobectomia superior direita para tratamento de câncer de pulmão de grandes células. Foi submetido a anestesia geral com ventilação monopulmonar e decúbito lateral esquerdo. Depois da abertura do tórax, a pressão arterial sistólica caiu repentinamente abaixo de 80 mmHg, a saturação de oxigênio diminuiu de 90% para 70% e a capnometria diminuiu para 17-18 mmHg. Com base nessa última situação descrita, em qual ponto da curva ele se encontra no gráfico abaixo, que representa várias etapas de um paciente submetido a cirurgia torácica e sua relação entre shunt pulmonar e proporção de atelectasia.

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.

q0873 [ME]

Um homem de 30 anos será submetido a uma glossectomia parcial. Ele apresenta diagnóstico de esquizofrenia e estenose aórtica grave, mas está atualmente compensado e orientado. Ele refere sentir forte ansiedade e solicita um medicamento antes de ir para a sala operatória de forma que ele não vivencie nem a entrada no setor.

- A)** O ideal para o protocolo de cirurgia segura é usar medicação pré-anestésica em dose que permita o paciente já ir dormindo para o centro cirúrgico.
- B)** A cetamina é o medicamento pré-anestésico ideal para esse paciente, pois mesmo em doses elevadas permite a manutenção da ventilação espontânea.
- C)** A escopolamina é um pré-anestésico ideal para este paciente, por ser um opioide fraco e causar menos depressão respiratória.
- D)** Quetiapina é um bom medicamento pré-anestésico para estes pacientes.

q0874 [ME]

Ao fazer uma avaliação pré-anestésica de uma criança de 4 anos com infecção de vias aéreas superiores para uma cirurgia de herniorrafia inguinal, qual condição abaixo indicaria o cancelamento da cirurgia?

- A)** Temperatura corporal de 37,5°C
- B)** Roncos e sibilos que não cessam ao tossir
- C)** Congestão nasal com coriza hialina
- D)** Presença de tosse seca

q0875 [ME]

Considerando a complexa anatomia da laringe e suas estruturas cartilaginosas, identifique a afirmação correta a seguir sobre as cartilagens laríngeas e suas características:

- A)** a valécula é uma estrutura cartilaginosa situada na base da língua, desempenhando um papel importante na articulação da fala e na deglutição.
- B)** a cartilagem cricoide, localizada ao nível da sexta vértebra cervical, é a única cartilagem da via aérea que forma um anel completo.
- C)** as cartilagens aritenoides são as maiores cartilagens da laringe e estão localizadas na parte frontal da laringe, abaixo da cartilagem tireoide.
- D)** as cartilagens cuneiformes, situadas na parte inferior da laringe, são responsáveis pela produção principal dos sons da fala.

q0876 [ME]

O bloqueio demonstrado na figura a seguir, quando realizado bilateralmente, provê analgesia de qual parte da via aérea?

- A)** Valécula.
- B)** 2/3 anteriores da língua.
- C)** Porção superior da laringe.
- D)** Face glótica da epiglote.

q0877 [ME]

Mulher de 58 anos, 48 Kg e 1,65 m com insuficiência renal crônica dialítica está na sala de recuperação pós-anestésica devido à osteossíntese de maléolo lateral esquerdo. Apresenta hipofosfatemia e durante a correção do eletrólito evolui com convulsão tônico-clônica generalizada. A provável explicação para este quadro é a ocorrência de:

- A)** hipocalcemia
- B)** hiponatremia
- C)** hipocalcemia
- D)** hipomagnesemia

q0878 [ME]

Homem de 35 anos, 145 Kg e 1,67 m (IMC=52 Kg.m) é submetido à cirurgia bariátrica videolaparoscópica sob anestesia geral balanceada com sevoflurano e remifentanil em infusão alvo controlada conforme o protocolo de Minto. O anestesiológista utilizou para programação da bomba o peso real do paciente e uma altura fictícia de 2,00 metros. Essa medida tem como objetivo:

- A) corrigir a inacurácia do Ke_0 associada à obesidade mórbida
- B) compensar para uma maior taxa de metabolização da medicação
- C) corrigir a inacurácia do modelo associada ao uso da massa magra corporal
- D) compensar para um maior volume de distribuição do compartimento central

q0879 [ME]

Uma das explicações prováveis para o broncoespasmo associado à administração de rocurônio é o bloqueio dos receptores:

- A) muscarínicos M3
- B) histaminérgicos H1
- C) nicotínicos musculares
- D) serotoninérgicos 5-HT3

q0880 [ME]

O modelo farmacodinâmico abaixo retratado representa o efeito do remifentanil conforme a concentração sérica do mesmo em adultos jovens saudáveis. A modificação esperada das características dessa curva em uma população de idosos é o(a):

- A) redução do valor do ângulo β
- B) deslocamento do ponto D para baixo
- C) deslocamento do ponto C para a direita
- D) deslocamento do ponto A para a esquerda

q0881 [ME]

Mulher de 27 anos, 50 Kg e 1,60 m portadora de cirrose por vírus C, será submetida a transplante hepático. A monitorização inicial com cateter de artéria pulmonar evidencia saturação venosa mista -1 -2 de 93%, índice cardíaco de 10 L.min .m , pressão média de artéria pulmonar de 35 mmHg e pressão de oclusão de capilar pulmonar de 10 mmHg. Você inicia a infusão de milrinona e observa que a paciente cursa com dessaturação na oximetria de pulso. O mecanismo proposto que explica esta alteração é o aumento do(a):

- A) fluxo sanguíneo pulmonar
- B) água extravascular pulmonar
- C) extração tecidual de oxigênio
- D) índice de trabalho do ventrículo esquerdo

q0882 [ME]

Homem de 77 anos, 73 Kg e 1,65 m é submetido à correção endovascular de aneurisma de aorta toracoabdominal sob anestesia geral. No quinto minuto após a oclusão da aorta torácica com balão, o neurofisiologista acusa diminuição na amplitude dos potenciais evocados motores espinhais. Neste momento a PA é de 150x100 mmHg, a FC é de 55 bpm, SpO₂ é de 100% e pressão líquórica é de 17 mmHg. A explicação para este quadro é o (a):

- A) deslocamento líquórico crânio-medular
- B) formação de edema medular citotóxico
- C) aumento da resistência vascular periférica
- D) diminuição da sensibilidade das vias espino-talâmicas laterais

q0883 [ME]

Mulher de 50 anos, 120 kg e 1,60 m, em tratamento psiquiátrico para grave distúrbio de humor com desvenlafaxina, naltrexona e olanzapina, estável do ponto de vista psiquiátrico, vítima de acidente automobilístico com fratura-luxação de L2-L3-L4, sem déficits neurológicos. Foi submetida a laminectomia descompressiva com fixação por instrumentação de T12 a S1. Você programa analgesia pós-operatória com infusão endovenosa de morfina controlada pelo paciente (PCA). Nessa situação, você:

- A)** Suspende a olanzapina.
- B)** Suspende a naltrexona.
- C)** Suspende a desvenlafaxina.
- D)** Mantém todas as medicações psiquiátricas.

q0884 [ME]

Mulher de 28 anos e 62 kg, com três gestações anteriores e dois abortos retidos anteriormente, apresenta-se com, aproximadamente, seis semanas de idade gestacional e diagnóstico de aborto retido à ultrassonografia. É portadora de lúpus eritematoso sistêmico em remissão há dois anos. Nos exames pré-operatórios, apresenta um leve prolongamento do TTPa e teste positivo para anticoagulante lúpico. Nessa situação, pensamos em:

- A)** Deficiência de proteína C e utilizamos ácido tranexâmico.
- B)** Deficiência de antitrombina e utilizamos heparina no pós-operatório.
- C)** Síndrome antifosfolípide e utilizamos anticoagulação no pós-operatório.
- D)** Trombocitopenia e utilizamos complexo protrombínico no pós-operatório.

q0885 [ME]

Homem de 70 anos, 1,68 m e 70 Kg será submetido à prostatectomia radical. Apresenta depressão, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 1 e miocardiopatia isquêmica com implante de stent farmacológico há 2 anos. Em uso de atenolol, atorvastatina, ácido acetilsalicílico, selegilina e insulina NPH. Qual orientação você daria para este paciente quanto ao uso das medicações habituais antes do procedimento proposto?

- A)** Suspende o AAS 7 dias antes
- B)** Suspende o atenolol no dia anterior
- C)** Suspende a selegilina no dia anterior
- D)** Reduzir a insulina NPH a 1/3 da dose no dia da cirurgia

q0886 [ME]

A avaliação de fragilidade é essencial durante a avaliação pré-anestésica. O instrumento Fenótipo de Fragilidade é uma ferramenta comumente utilizada para avaliação de fragilidade em idosos. Entre seus cinco itens de avaliação, qual das opções abaixo apresenta dois deles?

- A)** Baixa atividade física e hemoglobina sérica.
- B)** Exaustão e história de queda nos últimos 6 meses.
- C)** Albumina sérica e lentidão de marcha.
- D)** Perda de peso não intencional e força de preensão palmar reduzida.

q0887 [ME]

Homem de 68 anos, 79 kg e 1,70 m será submetido à correção cirúrgica de aneurisma de aorta abdominal. Tem diagnóstico de lesão arterial coronariana, classificada como moderada na angiografia e tratada clinicamente com o uso de metoprolol (25 mg/dia), ácido acetilsalicílico (100 mg/dia), ramipril (10 mg/dia) e atorvastatina (40 mg/dia). A conduta mais adequada no pré-operatório é:

- A)** Suspende o uso da atorvastatina.
- B)** Manter o metoprolol na mesma dose.
- C)** Realizar a revascularização miocárdica.
- D)** Iniciar dupla antiagregação plaquetária.

q0888 [ME]

Homem de 52 anos, 78 Kg e 1,70 m está agendado para ressecção de tumor cerebral. É hipertenso e diabético com histórico de angioplastia com colocação de stent farmacológico em artéria descendente anterior há 9 meses. Vem em uso regular de aspirina e clopidogrel. O neurocirurgião solicita que o clopidogrel seja suspenso 7 dias antes da cirurgia, mas o cardiologista assistente alerta para o risco de evento isquêmico no perioperatório. Com base nos mecanismos da hemostasia, a principal justificativa fisiopatológica que explica a preocupação do cardiologista nesta situação é:

- A)** o aumento atividade trombogênica endotelial
- B)** a redução da atividade antifibrinolítica plaquetária
- C)** a ocorrência de hiperagregação plaquetária rebote
- D)** a exposição de componentes da matriz extracelular subendotelial

q0889 [ME]

Quanto aos ventiladores acionados por fole utilizados em anestesiologia:

- A)** são dispositivos antigos que não encontram mais aplicação nas práticas modernas de anestesiologia devido à sua ineficiência.
- B)** os pneumáticos operam com um princípio de fluxo contínuo, onde o gás de acionamento e o gás respiratório são completamente separados durante todo o ciclo respiratório.
- C)** os pneumáticos são considerados menos seguros do que os ventiladores de pistão porque dependem da pressão de gás constante para evitar o esvaziamento do reservatório.
- D)** os pneumáticos utilizam um reservatório rígido que serve como uma fonte de gás respiratório, sendo o gás de acionamento responsável por dirigir o fole para baixo durante a fase expiratória e para cima durante a inspiratória.

q0890 [ME]

Qual dos agentes abaixo relacionados tem menor transferência útero-placentária?

- A)** Fentanil
- B)** Propofol
- C)** Cisatracúrio
- D)** Succinilcolina

q0891 [ME]

Mulher de 33 anos, 60 kg e 1,60 m, após acidente automobilístico que ocorreu há uma hora, será submetida a uma laparotomia exploradora. Admitida na sala de operação lúcida e orientada, relata dor intensa na região abdominal e jejum de oito horas. O anestesiológista decide realizar uma avaliação gástrica por meio de ultrassonografia com um transdutor curvilíneo de baixa frequência. Correlacione a imagem com a conduta a ser usada para a indução anestésica:

- A)** Estômago com conteúdo sólido tardio – o antro apresenta aspecto de ecogenicidade heterogênea. Indução em sequência rápida.
- B)** Estômago com líquidos sem resíduo – o antro apresenta conteúdo anecoico homogêneo que corresponde ao líquido. Indução em sequência rápida.
- C)** Estômago com líquidos espessos – o antro apresenta-se como uma estrutura ovalada, seu conteúdo é homogêneo e levemente hiperecoico. Indução acordada com broncofibroscópio.
- D)** Estômago vazio – o antro apresenta-se como uma estrutura arredondada de contorno hipoecoico e uma parte central heterogênea acinzentada com aspecto de um alvo. Indução em sequência normal.

q0892 [ME]

A figura abaixo ilustra um sarcômero em estado relaxado e contraído. Qual o nome da Proteína X destacada na figura?

- A)** Actina
- B)** Miosina
- C)** Troponina
- D)** Titina

q0893 [ME]

Na ressuscitação neonatal:

- A)** A frequência das compressões torácicas deve ser de 5 para cada ventilação.
- B)** A oximetria deve ser instalada no pulso radial esquerdo com objetivo de monitorar a saturação de oxigênio pré- ductal.
- C)** No pré-termo abaixo de 32 semanas, deve-se titular a fração inspirada de oxigênio para manter saturação periférica entre 60 e 65% no primeiro minuto.
- D)** A compressão torácica deve englobar 2/3 da dimensão anteroposterior, com ambos os polegares sobre o esterno e o restante das mãos circundando o tórax.

q0894 [ME]

Mulher de 51 anos, 85 Kg e 1,70 m está no centro cirúrgico para realização de colecistectomia videolaparoscópica. Apresenta PA de 140x70 mmHg, FC de 70 bpm e SpO₂ de 97%. A cirurgia ocorre sem intercorrências e a cavidade abdominal é desinsuflada após 60 minutos da instalação do pneumoperitônio com pressão de 18 mmHg. Neste momento a paciente apresenta PA de 80x40 mmHg, FC de 90 bpm, SpO₂ de 94%. A causa mais provável desta hipotensão está relacionada com:

- A)** shunt pulmonar
- B)** isquemia e reperfusão
- C)** alcalose pós-hipercapneica
- D)** diminuição do tônus simpático

q0895 [ME]

Homem de 36 anos, 52 Kg e 1,70 m vítima de acidente doméstico dá entrada no pronto socorro com fratura exposta da tíbia esquerda. Há relato do uso recente de droga conhecida como "ICE" (metanfetamina). Paciente foi submetido à anestesia geral balanceada com sevoflurano e remifentanil em infusão alvo controlada. No intraoperatório o mesmo cursou com hipertensão de difícil controle a despeito do BIS de 45, aumento da dose de remifentanil e administração adicional de sufentanil. Diante deste quadro, a melhor conduta para o controle da pressão arterial é a administração venosa de:

- A)** esmolol
- B)** labetalol
- C)** verapamil
- D)** enalaprilato

q0896 [ME]

Sobre a transferência placentária de fármacos, podemos afirmar que:

- A)** Tanto a heparina quanto o glicopirrolato têm alta taxa de transferência placentária porque sua ionização é muito baixa.
- B)** A dexmedetomidina pode atravessar a barreira placentária, mas é armazenada dentro da placenta e a transferência para o feto é reduzida.
- C)** Os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes são não ionizados, têm baixo peso molecular e alta lipossolubilidade, resultando em alta transferência placentária.
- D)** A succinilcolina tem alto peso molecular, é altamente ionizada e, portanto, não atravessa facilmente a placenta, a menos que seja administrada em grandes doses não clínicas.

q0897 [ME]

Paciente em uso de dabigatrana devido evento tromboembólico prévio será submetido à neurocirurgia em caráter de emergência. Deve-se reverter o efeito desse inibidor direto da trombina com qual dos fármacos abaixo?

- A)** Protamina
- B)** Complexo pró-trombínico
- C)** Fibrinogênio sintético
- D)** Idarucizumab

q0898 [ME]

Um centro ambulatorial planeja implementar um protocolo de recuperação rápida (fast-track) para artroscopias de joelho sem reconstrução ligamentar. Anestesia venosa total com propofol e remifentanil associada a infiltração intra-articular de ropivacaína foi então padronizada para este fim e a obtenção de escores ≥ 9 na escala de Aldrete e Kroulik modificada utilizada como parâmetro de alta direto da sala de cirurgia para o quarto. A abolição da fase I de recuperação provavelmente resultará em:

- A)** menores taxas de dor na fase III de recuperação
- B)** maiores taxas de retenção urinária na fase II de recuperação
- C)** maiores taxas de náusea e vômitos na fase II de recuperação
- D)** menores tempos para passagem da fase II à fase III de recuperação

q0899 [ME]

Menino de 4 anos e 20 kg foi submetido a cirurgia de estrabismo sob anestesia geral balanceada. Apresentou episódio de taquicardia ventricular com instabilidade hemodinâmica, que rapidamente evoluiu para fibrilação ventricular. A melhor conduta a ser adotada é:

- A)** Massagem no seio carotídeo.
- B)** Cardioversão elétrica com 80 J.
- C)** Desfibrilação imediata com 40 J.
- D)** Administração imediata de adrenalina.

q0900 [ME]

Na intubação nasotraqueal, deve ser escolhida a cavidade nasal mais patente, e o tubo traqueal deve ser introduzido na narina em ângulo de 90° em direção posterior e caudal, com bisel voltado para a linha média. Essa técnica evita lesão da seguinte estrutura, localizada superiormente:

- A)** Vômer.
- B)** Turbinas nasais.
- C)** Cartilagem septal.
- D)** Placa cribiforme do osso etmoidal.

q0901 [ME]

Homem de 30 anos, 70 kg e 1,70 m, estado físico ASA 1, foi submetido a apendicectomia em jejum. A indução anestésica foi feita com propofol, fentanil e rocurníio; a manutenção, com sevoflurano. A seguir, observaram-se elevação progressiva do EtCO₂, taquicardia de 150 bpm e dificuldade de manutenção do pneumoperitônio. Não houve resposta ao aumento do volume minuto, assim como às tentativas de melhorar o plano anestésico. Evoluiu com hipoxemia e arritmia cardíaca.

- A)** A falta de elevação da temperatura torna o diagnóstico de hipertermia maligna pouco provável.
- B)** Por se tratar de um cenário de crise, deve-se, imediatamente, pedir ajuda e solicitar desfibrilador e dantrolene sódico.
- C)** Na solicitação de exames laboratoriais, espera-se encontrar hipercalemia, hipercalcemia, alcalose mista e CPK aumentada.
- D)** A hipercalemia deve ser imediatamente corrigida com infusão de bicarbonato de sódio, solução polarizante, ajuste da ventilação e bloqueador de canal de cálcio para controle da arritmia.

q0902 [ME]

Homem de 83 anos, 80 Kg e 1,75 m será submetido à drenagem de hematoma subdural. Ao exame apresenta-se em ventilação mecânica, PA de 80x40 mmHg, FC de 125 bpm e anisocoria à direita. A tomografia de crânio mostra hematoma subdural à direita com desvio da linha média e apagamento do ventrículo lateral homolateral. A conduta que necessita ser tomada neste momento para promover a proteção cerebral é a administração de:

- A)** manitol
- B)** noradrenalina
- C)** hiperventilação
- D)** solução de NaCl a 7,5%

q0903 [ME]

No contexto do manejo anestésico durante uma laringectomia total, é correto afirmar:

- A)** uma reposição volêmica vigorosa com cristaloides é recomendada para prevenir a hipotensão e garantir a perfusão adequada durante o procedimento.
- B)** a extubação do paciente é, preferencialmente, realizada na unidade de terapia intensiva devido ao risco aumentado de obstrução das vias aéreas na sala de cirurgia.
- C)** a traqueostomia é habitualmente realizada no início do procedimento, utilizando um tubo endotraqueal reforçado com fio colocado no estoma.
- D)** o bloqueio neuromuscular contínuo é utilizado para facilitar a dissecação cervical.

q0904 [ME]

Homem de 72 anos, 78 kg e 1,76 m será submetido a gastrectomia total sob anestesia geral com previsão de duas horas de duração. Será monitorizado com cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia, BIS e pressão arterial invasiva. Nessa situação, para se obter maior acurácia, a temperatura central deve ser medida:

- A)** Na região axilar.
- B)** Na artéria pulmonar.
- C)** Na membrana timpânica.
- D)** A monitorização da temperatura central só é indicada em cirurgias com duração acima de quatro horas.

q0905 [ME]

Homem de 72 anos, 68 kg e 1,60 m, sem comorbidades, foi submetido à colecistectomia videolaparoscópica sob anestesia venosa total com propofol em infusão alvo-controlada com protocolo de Marsh e remifentanil também em infusão controlada com protocolo de Minto. Contava com a monitorização habitual e BIS. Logo após a intubação orotraqueal, apresentou pressão arterial de 60 × 30 mmHg; frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto; saturação arterial de 98%; capnometria de 23 mmHg e BIS de 26. Nessa situação, você conclui que o fator principal da hipotensão arterial foi:

- A)** O propofol deveria ser reduzido porque a sensibilidade cerebral e o clearance são maiores.
- B)** O propofol deveria ser reduzido, principalmente pelo clearance e o compartimento V1 serem menores.
- C)** O remifentanil, em qualquer protocolo, não causará depressão graças ao metabolismo esterolítico muito rápido.
- D)** O remifentanil no protocolo Minto deve ser reduzido em virtude de sensibilidade cerebral maior e redução do compartimento V1, apesar de o clearance se manter.

q0906 [ME]

Você é chamado para avaliar uma gestante, 38 semanas de idade gestacional, que se apresenta inquieta, com dor em baixo ventre, para a qual deverá avaliar a viabilidade de uma analgesia de parto. Ao exame físico, percebe a presença de uma terceira bulha (B3) na ausculta cardiovascular. Ao ECG, apresenta desvio do eixo para a esquerda em comparação ao seu basal pré-gestacional, TGO, TGP e bilirrubina nos limites superiores da normalidade (eram normais antes da gravidez), leucocitose (com 12.000 leucócitos), leve taquicardia e leve taquipneia. Qual diagnóstico e conduta?

- A)** Gestação a termo. Nenhuma restrição à escolha da técnica analgésica.
- B)** Sepsis (provavelmente urinária). Não usar técnica neuraxial.
- C)** Síndrome HELLP. Indicar cesariana.
- D)** Insuficiência cardíaca. Analgesia de parto cuidadosa.

q0907 [ME]

Mulher de 41 anos, quarta gestação, com três cesáreas prévias, está na 34ª semana gestacional. Dá entrada no pronto atendimento com sangramento vaginal. Nega dor ou contração abdominal. A principal hipótese diagnóstica é:

- A) Placenta acreta.
- B) Placenta prévia.
- C) Placenta increta.
- D) Descolamento prematuro de placenta.

q0908 [ME]

Criança de 5 anos, 17 Kg, será submetido à laparotomia exploradora por abdome agudo inflamatório. Durante o procedimento apresenta sangramento aumentado de áreas cruentas que preocupa toda a equipe e você decide realizar exame de tromboelastograma. Diante do traçado obtido, qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Fibrinólise.
- B) Trombocitopenia.
- C) Deficiência de fatores da coagulação.
- D) Coagulação intravascular disseminada.

q0909 [ME]

A declaração de Helsinki em segurança do paciente em anestesiologia demanda que todas as instituições que provêm cuidados anestésicos tenham determinados protocolos, os quais são obrigatórios para todas as creditações. Indique um protocolo que está presente nesta declaração de Helsinki.

- A) Reconciliação medicamentosa.
- B) Prevenção de incêndio.
- C) Posicionamento do paciente.
- D) Anafilaxia.

q0910 [ME]

Homem de 45 anos, 1,72 m, com asma grave, é internado para ser submetido a apendicectomia por videolaparoscopia. O anestesiologista está preocupado com a ventilação do paciente no perioperatório. Quando falamos sobre fisiologia respiratória, podemos afirmar que:

- A) A complacência pulmonar é diretamente proporcional à elastância.
- B) A pressão de platô é inversamente proporcional à elastância pulmonar e torácica.
- C) O aumento do fluxo, isoladamente, leva à elevação da pressão de pico de forma isolada.
- D) A diferença de pressão entre o ambiente e o pulmão durante a expiração na ventilação espontânea permite a saída do ar e é denominada driving pressure.

q0911 [ME]

Você está conduzindo uma pesquisa para analisar a eficácia de dois tipos de anestésicos em pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos semelhantes. Você coletou dados em uma escala de intervalo para a duração do efeito anestésico e em uma escala nominal para a incidência de efeitos colaterais. Com base nessas informações, qual combinação de testes estatísticos seria a mais apropriada para analisar a duração do efeito anestésico e a incidência de efeitos colaterais, respectivamente?

- A) Teste T de Student e Qui-quadrado.
- B) Qui-Quadrado e Teste de Mann-Whitney.
- C) Teste de Fisher e ANOVA.
- D) Teste de Fisher e Teste T de Student.

q0912 [ME]

Um ensaio clínico prospectivo, duplamente encoberto e randomizado comparou as taxas de cefaleia pós-raquianestesia em dois grupos de, aproximadamente, 6 mil gestantes em cada um, submetidas a cesárea. Nas participantes do grupo A (n = 6.361), a punção lombar foi realizada com uma agulha 27G de ponta romba com orifício lateral, enquanto, nas pacientes do grupo B (n = 6.344), uma agulha 27G de orifício terminal e ponta cortante foi utilizada para esse fim. Ao final do procedimento, na análise por intenção de tratamento, intention-to-treat, os pesquisadores observaram uma taxa de ocorrência do desfecho avaliado de 3,7% (235 casos) no grupo A e de 4,8% (304 casos) no grupo B, com um valor de p de 0,002 para o risco relativo ao grupo A/grupo B. A interpretação desse estudo é compatível com a conclusão:

- A)** Com uma razão de chances (odds ratio) calculada de 0,76 entre os grupos (grupo A/grupo B), as pacientes do grupo B têm uma chance 24% maior de apresentar cefaleia.
- B)** O intervalo de confiança de 95% do risco relativo calculado passa pelo número 1, que representa o ponto de rejeição da hipótese nula, para uma comparação de superioridade.
- C)** Baseado no valor de p isoladamente, a magnitude do efeito clínico de aumento de cefaleia pós-raquianestesia com agulha de orifício terminal e ponta cortante é clinicamente muito elevado.
- D)** Caso a incidência de cefaleia na prática clínica seja equivalente à do grupo A, aproximadamente 1 em cada 91 gestantes submetidas a raquianestesia para cesárea com agulhas de características semelhantes às do grupo B vai apresentar cefaleia.

q0913 [ME]

O posicionamento do paciente em decúbito lateral direito com tórax fechado promove:

- A)** diminuição da pré-carga
- B)** efeito shunt no pulmão não dependente
- C)** aumento da resistência vascular periférica
- D)** diminuição da perfusão no pulmão dependente

q0914 [ME]

Qual dos locais abaixo apresenta melhor correlação anatômica com a temperatura hipotalâmica, região responsável pelo controle central das aferências termorregulatórias provenientes de todo organismo?

- A)** Retal
- B)** Artéria pulmonar
- C)** Membrana timpânica
- D)** Esofágica

q0915 [ME]

Mulher de 59 anos, 45 Kg e 1,53 m é submetida à lobectomia inferior direita. Após 15 minutos em ventilação monopulmonar, a paciente mantém SpO₂ de 86% a despeito de estar com FiO₂ de 100%, -1 VC de 8 mL.Kg, PEEP de 8 mmHg no pulmão inferior, FR de 16 irpm com ETCO₂ de 34 mmHg e CPAP no pulmão superior. Qual medida deve ser adotada para preservar o reflexo de vasoconstrição pulmonar hipóxica?

- A)** Reduzir a CPAP
- B)** Reduzir a ETCO₂
- C)** Aumentar a PEEP
- D)** Evitar sobrecarga hídrica

q0916 [ME]

Paciente sexo masculino, 70 anos, 65 Kg, ASA III devido hipertensão arterial sistêmica e DPOC, será submetido à artroplastia de quadril. A equipe optou por realizar um duplo-bloqueio (raquianestesia e peridural contínua) a fim de promover estabilidade hemodinâmica e evitar anestesia geral. Foi realizado inicialmente raquianestesia, em posição sentada, L3-L4, com 10 mg de bupivacaína isobárica e morfina 80 mcg, seguida da realização peridural, L2-L3. Foram necessárias duas punções devido à dificuldade na passagem do catéter peridural. A despeito dos cuidados, o paciente apresentou hipotensão significativa. Qual das medidas abaixo poderia ter sido realizada para reduzir hipotensão?

- A)** Adição de opiode lipofílico à solução subaracnoide.
- B)** Realização da peridural antes da raquianestesia.
- C)** Deixar o paciente em cefaloactive após bloqueio.
- D)** Realizar dose teste utilizando lidocaína com vasoconstrictor.

q0917 [ME]

Paciente de 16 anos, ASA II, com sequelas de paralisia cerebral em uso de anticonvulsivantes, chega ao centro cirúrgico para cirurgia odontológica. Máscara de oxigênio e óxido nitroso a 60 % foi bem aceita pela paciente com saturação de oxigênio de 99 % (SpO2). Enquanto o anestesiológista puncionava o acesso venoso, a SpO2 diminuiu para 83%. A paciente estava sem a máscara por 5 a 7 minutos. Qual a explicação mais provável para a SpO2 reduzida?

- A)** Hipóxia por difusão.
- B)** Elevação da PACO2.
- C)** Efeito do segundo gás.
- D)** Efeito da concentração.

q0918 [ME]

O gráfico abaixo representa a relação entre a capacidade metabólica, a depuração e a taxa de extração hepáticas. A partir dos seus conhecimentos de farmacocinética e dos dados obtidos pelo gráfico, conclui-se que:

- A)** a doença hepática desloca a taxa de extração calculada para a direita.
- B)** os fármacos com alta taxa de extração não dependem do fluxo sanguíneo.
- C)** a indução enzimática desloca a taxa de extração calculada para a esquerda.
- D)** as mudanças na Vm têm menos efeito nos fármacos com alta taxa de extração.

q0919 [ME]

Hoje você está escalado(a) em uma tireoidectomia total. Após discussão do caso com seu preceptor, vocês decidem realizar uma técnica de anestesia venosa total, utilizando bombas de infusão contínua. Com relação a estas bombas de infusão contínua de fármacos intravenosos:

- A)** o modo alvo-controlado (target-controlled infusion, TCI) é um sistema de controle em alça aberta com controle humano.
- B)** o desenvolvimento das primeiras bombas mecânicas de seringa iniciou-se a partir da década de 90.
- C)** bombas de infusão de seringa modernas podem operar baseadas em modelos farmacodinâmicos específicos de cada fármaco.
- D)** a maior causa de inacurácia no modelo alvo-controlado é a variabilidade biológica, que vem de duas fontes: 1) o modelo farmacocinético está errado e 2) a farmacocinética específica de dado paciente não é como a programada no modelo.

q0920 [ME]

Homem de 50 anos, 105 Kg e 1,78 m, ex-tabagista, hipertenso e dislipidêmico em uso de atenolol e atorvastatina foi submetido à revisão de artrodese de coluna. A cirurgia demorou 8 horas e o paciente recebeu 6000 mL de solução ringer com lactato. No pós-operatório, o paciente cursou com perda progressiva da visão bilateralmente. Qual é a principal hipótese diagnóstica e o mecanismo fisiopatológico envolvido?

- A) Amaurose cortical; hipotensão e embolia venosa
- B) Oclusão da veia central da retina; anemia e hipotensão
- C) Neuropatia óptica posterior; anemia e congestão venosa
- D) Oclusão da artéria central da retina; hipotensão e placa ateromatosa

q0921 [ME]

Um homem de 35 anos, 1,70 m e 80 kg, foi admitido na emergência de um hospital após ser vítima de um acidente automobilístico. A equipe médica realizou uma avaliação inicial e registrou os seguintes parâmetros clínicos: frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, pressão arterial de 100/60 mmHg, frequência respiratória de 22 incursões por minuto e um débito urinário de 25ml/h. O paciente apresenta um quadro de ansiedade e relata uma sensação intensa de fraqueza. Considerando as informações apresentadas, qual é a classe de choque hipovolêmico que melhor se aplica a esse paciente?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV

q0922 [ME]

Homem de 72 anos, 94 kg e 1,78 m, hipertenso e diabético, com quadro de diverticulite perforada, foi admitido no centro cirúrgico para laparotomia de urgência. Antes da indução da anestesia, apresentava-se sonolento, com a pele fria e pegajosa, frequência cardíaca de 125 bpm, frequência respiratória de 22 ipm e pressão arterial de 90 × 57 mmHg. Depois da indução da anestesia geral, o paciente manteve-se taquicárdico e apresentou queda acentuada da pressão arterial, a despeito da reposição volêmica. Sobre esse caso e as estratégias para o manejo hemodinâmico:

- A) É indicado iniciar infusão de noradrenalina por sua ação vasoconstritora e pequeno efeito beta-adrenérgico.
- B) Com a variação da pressão de pulso entre 5% e 10%, é indicada nova expansão volêmica com 1.500 mL de ringer lactato.
- C) Deve ser iniciada a infusão de vasopressina precocemente como primeira medida farmacológica para o tratamento do choque.
- D) A administração contínua de adrenalina promoverá aumento da pressão arterial com menor risco de arritmia e menos vasoconstrição esplâncnica.

q0923 [ME]

Com relação à anestesia combinada raqui-peridural, podemos afirmar que:

- A) o início da ação analgésica é mais demorado se comparado à anestesia peridural isolada.
- B) após a injeção de anestésico local no espaço intratecal, a adição de solução salina ao espaço peridural, por meio do cateter, aumenta a altura do bloqueio.
- C) a incidência de prurido é igual nas administrações intratecal e peridural em doses semelhantes de opioides.
- D) a administração precoce de anestesia combinada, em pacientes nulíparas em trabalho de parto, está associada ao aumento da taxa de cesariana.

q0924 [ME]

Paciente com 24 horas de vida chega ao centro cirúrgico para correção de atresia de esôfago associada a fístula traqueoesofágica. Apresenta intensa desidratação e histórico de broncoaspiração. Nesses pacientes é correto afirmar:

- A)** A ventilação com pressão positiva é indicada antes da intubação orotraqueal.
- B)** Em casos de parada cardiorrespiratória, a adrenalina na dose de 0,1 mg/kg deve ser realizada.
- C)** A parada cardiorrespiratória pode ter como causa a hipóxia, pelo deslocamento do tubo traqueal e perda da ventilação.
- D)** Nos casos de parada cardiorrespiratória por fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, a primeira carga recomendada na desfibrilação é de 4 J/kg.

q0925 [ME]

Nos últimos anos, técnicas de anestesia regional para cirurgia em obstetrícia e o manejo da dor pós-operatória têm sido usados com frequência cada vez maior. A técnica combinada raquiperidural (Combined Spinal-Epidural [CSE]), uma opção anestésica comparativamente nova, inclui uma injeção subaracnóidea inicial seguida de colocação do cateter peridural e subsequente administração de medicamentos peridurais. São aspectos relacionados com essa técnica:

- A)** O risco de lesão neurológica é o mesmo com raquianestesia simples e técnica combinada raquiperidural.
- B)** A técnica combinada raquiperidural prolonga a duração da primeira fase do trabalho de parto em pacientes primíparas.
- C)** A falha do bloqueio espinal com a técnica combinada raquiperidural de agulha através de agulha é maior com a utilização da abordagem paramediana em comparação com a mediana.
- D)** A colocação subaracnóidea de anestésico local com técnica combinada raquiperidural pode levar a níveis de bloqueio mais elevados em comparação com a raquianestesia simples.

q0926 [ME]

Este registro capnográfico é compatível com:

- A)** broncoespasmo
- B)** reabsorção de CO₂
- C)** falência da válvula expiratória
- D)** esforço para iniciar uma ventilação

q0927 [ME]

Em relação aos padrões de estimulação nervosa dos monitores de função neuromuscular, entende-se que:

- A)** Uma frequência de 50 Hz, com duração de cinco segundos, é a estratégia mais utilizada no padrão de estímulo simples.
- B)** Na sequência de quatro estímulos, a estimulação se dá na frequência de 2 Hz, e o intervalo entre as sequências não deve ser inferior a dez segundos.
- C)** O estímulo tetânico tem sido preconizado na prática clínica atual, sendo o padrão de escolha para avaliação de bloqueio neuromuscular residual.
- D)** Na contagem pós-tetânica, padrão útil para avaliar bloqueio neuromuscular profundo, aplica-se um estímulo inicial de 1 Hz por cinco segundos, seguido de estímulos simples de 50 Hz.

q0928 [ME]

Paciente de 75 anos com história de dispneia aos pequenos esforços, insuficiência coronariana, encaminhada para cirurgia de revascularização miocárdica e troca valvar. Apresenta ecocardiografia pré-operatória que demonstra disfunção valvar com uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 35% e volume sistólico final do ventrículo esquerdo de 62 mm. Neste paciente, a curva pressão/ volume do ventrículo esquerdo (VE) está representada no gráfico abaixo pela letra "A". Quanto à proteção miocárdica para o caso descrito:

- A)** A cardioplegia anterógrada é a mais indicada neste caso, com administração da solução nas artérias coronárias através da raiz da aorta.
- B)** Para induzir cardioplegia, inicia-se com solução de baixo teor de potássio e após a parada isoelétrica, a solução é trocada para com alto teor de potássio.
- C)** A cardioplegia retrógrada tem limitações por não atingir adequadamente a parede livre do ventrículo direito e o terço posterior do septo interventricular.
- D)** A hipotermia induzida promove a preservação de substratos de alta energia e aumenta a liberação de neurotransmissores excitatórios contribuindo para a proteção miocárdica.

q0929 [ME]

Um paciente com histórico de múltiplas transfusões anteriores sofre ferimento por arma branca e é submetido a laparotomia exploradora recebendo no intraoperatório 2 concentrados de hemáceas. Evolui de forma satisfatória até o 15o dia de pós-operatório quando apresenou queda no hematócrito, icterícia e hemoglobunúria. Qual a provável fisiopatologia deste evento?

- A)** Incompatibilidade HLA
- B)** Incompatibilidade ABO
- C)** Incompatibilidade Kidd
- D)** Formação de anticorpo Anti-IgA

q0930 [ME]

Adolescente de 16 anos, 65 Kg e 1,58 m, com histórico de diabetes mellitus tipo 1 há 9 anos é encaminhada ao centro cirúrgico para apendicectomia. Após indução da anestesia e início da ventilação mecânica, a paciente evolui com hipotensão e taquicardia com extra-sístoles supraventriculares frequentes. Gasometria arterial revela pH de 6,9; PaCO₂ de 24,6 mmHg; PaO₂ de -1 -1 171 mmHg; HCO₃ de 7,2 mEq.L ; BE de -20,2. Exames laboratoriais adicionais revelam: sódio de -1 -1 -1 -1 122 mEq.L , potássio de 7 mEq.L , cloro sérico de 100 mEq.L , glicemia de 645 mg.dL e lactato -1 -1 arterial de 22 mg.dL (2 mmol.L). É realizada expansão volêmica com soro fisiológico e administração venosa de bicarbonato de sódio e insulina. Ao término do procedimento, a paciente apresenta melhora dos parâmetros gasométricos, mas desperta com fraqueza muscular generalizada. Que alteração eletrolítica justifica esse sintoma na situação apresentada?

- A)** Hipocalemia
- B)** Hipocalcemia
- C)** Hipofosfatemia
- D)** Hipomagnesemia

q0931 [ME]

Após o posicionamento em cadeira de praia para uma cirurgia de artroplastia de ombro, sob anestesia geral e bloqueio interescaletico, o paciente apresentou medida de pressão arterial média de 65 mmHg e frequência cardíaca de 50 bpm. A distância entre conduto auditivo externo e o membro onde foi aferida a pressão não-invasiva era de 20 centímetros. Com relação a esse caso, é correto afirmar:

- A)** o fluxo sanguíneo cerebral está mantido.
- B)** hipercapnia permissiva deve ser evitada.
- C)** a pressão arterial média na circulação cerebral é aproximadamente 50 mmHg.
- D)** a administração profilática de cristalóide reduz o reflexo de Bainbridge.

q0932 [ME]

São particularidades do transplante renal pediátrico quando comparado ao adulto:

- A)** o enxerto do doador pediátrico apresenta menor risco de trombose que o do doador adulto.
- B)** ocorre menor instabilidade hemodinâmica na reperfusão.
- C)** pressão arterial invasiva está indicada.
- D)** a reposição volêmica deve ser restritiva.

q0933 [ME]

Homem de 62 anos, 1,80 m, 65 kg, tabagista, cirrótico por uso de álcool crônico, sofreu acidente automobilístico e apresenta múltiplas fraturas de fêmur, tíbia e cotovelo. Foi submetido a anestesia geral para correção das fraturas. Durante a cirurgia, apresentou sangramento importante com instabilidade hemodinâmica; foi realizada transfusão maciça de sangue total. Ao final da cirurgia, foi encaminhado para a UTI intubado, pois apresentou dessaturação no perioperatório após a transfusão. Depois de seis horas na UTI, apresenta febre e um quadro sugestivo de edema pulmonar. Nesse paciente, podemos afirmar:

- A)** A única terapia específica é repor o cálcio e o fibrinogênio e instituir medidas de suporte.
- B)** O paciente apresenta, provavelmente, nesse quadro, níveis mais baixos de interleucina-8.
- C)** Embora a maioria dos pacientes se recupere em 24 horas, a lesão pulmonar aguda associada à transfusão (TRALI) é a segunda maior causa de morte relacionada à transfusão.
- D)** O quadro é compatível com lesão pulmonar aguda associada à transfusão (TRALI), e um fator de risco que deve ser considerado é o sangue total utilizado ser de doadora feminina múltipara.

q0934 [ME]

Paciente masculino, 39 anos, 175 cm, 88 kg, hipertenso controlado e portador de glaucoma de ângulo aberto. Será submetido a septoplastia e vitrectomia sob anestesia geral e bloqueio regional. Neste cenário, é um fator de risco associado a aumento da pressão intraocular a administração de:

- A)** fentanil.
- B)** etomidato.
- C)** óxido nitroso.
- D)** bloqueio peribulbar.

q0935 [ME]

Na fisiopatologia da dor crônica, os conceitos estão assim descritos:

- A)** A união do neurotransmissor glutamato e n-metil-D-aspartato pode ser bloqueada pelo cálcio.
- B)** A dor neuropática ocorre pela lesão e ativação de receptores ligados às fibras nervosas C e A delta.
- C)** Receptores n-metil-D-aspartato estão envolvidos na ativação e inicialização da sensibilização central.
- D)** A dor nociceptiva surge como consequência de uma lesão ou doença que afeta o sistema somatossensitivo.

q0936 [ME]

Mulher de 45 anos, 85 Kg e 1,72 m será submetida à artroplastia de joelho. Relata episódios de palpitação paroxística. O eletrocardiograma da avaliação pré-operatória está abaixo. A redução do risco de taquiarritmia com propofol pode ser atribuído pelo seu efeito supressor no(a):

- A)** nó sinoatrial
- B)** via acessória
- C)** nó atrioventricular
- D)** sistema simpático

q0937 [ME]

Adolescente de 16 anos, sexo feminino, foi programada para cirurgia de escoliose torácica idiopática com angulação maior de 50 graus. A monitorização neurofisiológica (MNF) incluiu potencial evocado somato-sensorial (PESS), potencial evocado motor (PEM) e eletroencefalograma (EEG). O manuseio anestésico inclui:

- A) Anestesia venosa total.
- B) Hipocarbia para melhor avaliar os potenciais da MNF.
- C) Indução com etomidato e manutenção com sevoflurano e óxido nitroso.
- D) Anestesia com sevoflurano e óxido nitroso porque aumentam a amplitude dos potenciais.

q0938 [ME]

Criança de 2 anos e 12 Kg é submetida à correção de pé torto congênito sob raquianestesia. No intraoperatório, cursou com bradipnéia e hipóxia. A explicação para este evento é o(a):

- A) bloqueio espinal alto
- B) reflexo de Hering-Breuer
- C) intoxicação pelo anestésico local
- D) injeção subdural do anestésico local

q0939 [ME]

Uma droga é administrada, por via endovenosa, na dose de 2 mg.kg-1 e atinge a concentração de 4 mcg.mL-1. O volume de distribuição do medicamento em questão é:

- A) 50 mL.kg-1.
- B) 20 mL.Kg-1.
- C) 80 mL.Kg-1.
- D) 500 mL.Kg-1.

q0940 [ME]

Durante procedimento cirúrgico eletivo, o anestesiológista responsável sofreu descarga elétrica ao tocar superfície de metal na sala cirúrgica. Qual seria um fator de risco para este tipo de acidente?

- A) Uso de bisturi elétrico monopolar pelo cirurgião.
- B) Temperatura da sala inferior a 20 °C.
- C) Umidade relativa do ar de 45%.
- D) Piso da sala com boa condução elétrica.

q0941 [ME]

Em relação aos traumas de face, podemos afirmar:

- A) Le Fort 3 é uma fratura horizontal da maxila com envolvimento funcional do palato.
- B) Le Fort 2 envolve as estruturas nasais, o saco lacrimal e o assoalho orbitário.
- C) A mandíbula representa o componente mais fraco do esqueleto facial.
- D) Le Fort 1 é suprazigomática.

q0942 [ME]

Qual característica da heparina não fracionada justifica a fisiopatologia da trombocitopenia induzida pela heparina tipo II?

- A) Polaridade
- B) Peso molecular
- C) Efeito imunogênico
- D) Efeito farmacodinâmico

q0943 [ME]

Mulher 32 anos, 68 Kg e 1,58 m, previamente hígida é submetida à lipoabdominoplastia sob anestesia peridural e sedação com dexmedetomidina. Após 6 horas de procedimento, a paciente passa a não responder a doses intermitentes de efedrina (dose total 75 mg). A provável explicação para este fato é a ocorrência de:

- A) aumento do AMP cíclico na musculatura lisa vascular
- B) esgotamento de vesículas noradrérgicas pré-sinápticas
- C) feedback negativo pelo estímulo alfa-2 adrenérgico pré-sináptico
- D) redução da afinidade à noradrenalina do receptor alfa-1 adrenérgico pós-sináptico

q0944 [ME]

Quanto à responsabilidade profissional do médico:

- A) o resultado incontornável é decorrente de uma situação grave, com resultado danoso, para a qual a ciência e a capacidade profissional ainda não oferecem solução.
- B) erro médico é uma espécie de resultado indesejável e imprevisível mesmo com medidas de prudência, perícia, atenção e cuidado.
- C) o acidente imprevisível deriva de um fato onde ocorreu lesão física do paciente causado por imperícia.
- D) o erro médico é o mesmo que mau resultado.

q0945 [ME]

A metodologia Lean que visa a melhora da qualidade e segurança na assistência do paciente tem como princípio:

- A) o fluxo entre as etapas do cuidado deve ser lento e com o maior número de etapas possíveis.
- B) buscar a perfeição nos processos sem se preocupar com desperdícios.
- C) o processo deve ser desencadeado antes da demanda do paciente.
- D) o tempo gasto em cada etapa do cuidado deve ser documentado.

q0946 [ME]

Mulher de 58 anos, 83 kg e 1,58 m está sendo submetida a laparotomia por abdome agudo inflamatório sob anestesia geral. No momento, encontra-se taquicárdica e com infusão de noradrenalina para tratamento de hipotensão arterial. Exame de gasometria arterial com pH = 7,28; pO₂ = 127 mmHg; pCO₂ = 32 mmHg; HCO₃⁻ = 16 mmol.L⁻¹; BE = -6; Na = 138 mmol.L⁻¹; Cl = 105 mmol.L⁻¹; glicemia = 123 mg.dL⁻¹; lactato arterial = 3,1 mmol.L⁻¹. Considerando o distúrbio ácido-básico, qual é a conduta recomendada nesse momento?

- A) Insulinoterapia.
- B) Hidratação e suporte hemodinâmico.
- C) Infusão de 83 mL de bicarbonato de sódio a 8,4%.
- D) Hiperventilação e aumento da dose de noradrenalina.

q0947 [ME]

Homem 35 anos, 1,70 m de altura e 65 kg, sem comorbidades, planejado para realização de herniorrafia inguinal videolaparoscópica. Após indução e intubação traqueal, é instalada ventilação mecânica apresentando as seguintes configurações: volume corrente de 500 mL, frequência respiratória de 13 irpm.min⁻¹, relação inspiração/expiração (I/E) de 1:2 e pressão expiratória final positiva (PEEP) de 8 cmH₂O. Após a instalação do pneumoperitônio e posição de cefalodeclive, os dados estão apresentados no gráfico abaixo. Neste momento qual o valor da driving pressure?

- A) 22 cmH₂O
- B) 13 cmH₂O
- C) 11 cmH₂O
- D) 9 cmH₂O

q0948 [ME]

Homem de 90 anos, hipertenso, diabético, 3.5 METs, FE de 50% (Teicholz), lúcido, chega ao hospital com abscesso anal para tratamento cirúrgico. O anestesiológista indica uma anestesia espinal posterior, descrita como se segue:

- A)** Paciente em decúbito ventral, punção em L3-L4, lidocaína a 2% isobárica e posição de canivete.
- B)** Paciente em decúbito lateral, punção em L3-L4, lidocaína a 2% isobárica e posição de canivete.
- C)** Paciente em decúbito lateral, punção em L3-L4, bupivacaína a 0,5% isobárica e posição de cefalodeclive.
- D)** Paciente em decúbito lateral esquerdo, punção em L3-L4, bupivacaína a 0,5% hiperbárica seguida de cefalodeclive.

q0949 [ME]

Mulher de 53 anos, 57 Kg e 1,60 m será submetida a tratamento cirúrgico de fratura de rádio distal direito sob bloqueio do plexo braquial por via axilar. Logo após a injeção de 30 ml de ropivacaína a 0,5%, a paciente cursa com convulsão generalizada. O anestesiológista administra 5 mg de midazolam com controle efetivo da convulsão e inicia ventilação sob máscara facial. Essa última medida trará como benefício teórico no tratamento da intoxicação por anestésico local o(a):

- A)** aumento do fluxo sanguíneo cerebral
- B)** redução do aprisionamento iônico neuronal
- C)** aumento da extração pulmonar do anestésico local
- D)** redução da forma catiônica do anestésico local no plasma

q0950 [ME]

Na análise do caso de um paciente removido de um ambiente ambulatorial para a unidade de terapia intensiva de um hospital, após regurgitação e aspiração do conteúdo gástrico durante endoscopia que o levou à sepse de foco pulmonar, qual ferramenta poderia ser mais adequada para a gestão de qualidade nesse caso?

- A)** A matriz GUT.
- B)** O princípio de Pareto.
- C)** O ciclo de Deming ou PDCA.
- D)** A análise de causa raiz com diagrama de Ishikawa.

q0951 [ME]

Dentre técnicas e fármacos utilizados na analgesia multimodal para o tratamento da dor aguda pós-operatória:

- A)** a gabapentina e a pregabalina têm eliminação hepática e devem ser utilizadas com cuidado em pacientes com a função diminuída.
- B)** os bloqueios periféricos ou centrais devem ser reservados para serem realizados no pós-operatório.
- C)** a associação da cetamina por via oral tem biodisponibilidade de mais de 80%.
- D)** o cetorolaco é analgésico potente com eficácia comparável à dos opioides.

q0952 [ME]

Dois fármacos, A e B, estão disponíveis para serem usados como agentes de indução. As características farmacocinéticas de cada um estão na tabela abaixo: -1 Fármaco V1 (L) Vdpe (L) Ke0 (min⁻¹) Taxa de extração hepática A 12 75 1 0,9 B 2 6 5 0,4 V1: volume do compartimento central; Vdpe: volume aparente de distribuição no pico de efeito A explicação para o fármaco B ter a indução mais rápida se deve a (ao) menor:

- A)** V1
- B)** Vd
- C)** T_{1/2} ke0
- D)** Taxa de extração hepática

q0953 [ME]

No ciclo cardíaco, as valvas semilunares estão abertas no(a):

- A)** Sístole atrial.
- B)** Sístole ventricular.
- C)** Contração isovolumétrica.
- D)** Relaxamento isovolumétrico.

q0954 [ME]

O anesthesiologista plantonista da sala de recuperação pós-anestésica é solicitado a avaliar paciente de 80 anos que foi submetido a procedimento de ressecção transuretral de próstata sob raquianestesia. O mesmo apresenta movimentação somente dos membros superiores ao comando, encontra-se dispneico, com pressão arterial com variação de 10% dos níveis pré-anestésicos, sonolento, mas responsivo a estímulos verbais e saturando 92% com auxílio de cateter nasal de oxigênio. Qual seria a pontuação desse paciente tendo como base a escala de Aldrete-Kroulik modificada?

- A)** 5 pontos.
- B)** 6 pontos.
- C)** 7 pontos.
- D)** 8 pontos.

q0955 [ME]

Segundo a Acute Kidney Injury Network (AKIN), quais são os critérios de insuficiência renal aguda no estágio 2 baseando-se na creatinina sérica (Cr) em valores absolutos e débito urinário (DU) em mL.kg-1.min-1?

- A)** Aumento de 1,5 vezes de Cr e DU < 0,5 em 6 horas
- B)** Aumento de 1,5 vezes de Cr e DU < 0,5 em 12 horas
- C)** Aumento de 2 vezes de Cr e DU < 0,5 em 12 horas
- D)** Aumento de 2 vezes de Cr e DU < 0,3 em 24 horas

q0956 [ME]

Em relação à fisiopatologia do choque, pode-se afirmar que:

- A)** O choque obstrutivo é caracterizado por alto débito cardíaco e aumento da resistência vascular sistêmica.
- B)** O choque cardiogênico é caracterizado por baixo débito cardíaco, diminuição das pressões de enchimento cardíaco e aumento da resistência vascular sistêmica.
- C)** No choque distributivo, o padrão hemodinâmico é um débito cardíaco normal ou alto, com resistência vascular sistêmica reduzida e pressões de enchimento cardíaco reduzidas.
- D)** No choque hipovolêmico, o padrão hemodinâmico é de baixo débito cardíaco, associado ao aumento das pressões de enchimento cardíaco e aumento da resistência vascular sistêmica.

q0957 [ME]

Paciente submetido a artroplastia total de quadril. Com o objetivo de complementação da analgesia foi indicada a realização do bloqueio do nervo cutâneo lateral femoral. Sobre este bloqueio:

- A)** É detectado pelo ultrassom através de um probe curvilíneo.
- B)** Seu ramo posterior promove analgesia da porção anterolateral da coxa e trocanter maior.
- C)** Bloqueio motor ocorrerá com volumes mínimos de 5 mL de anestésico local.
- D)** Os parâmetros anatômicos a se procurar no ultrassom são: a espinha ilíaca anterosuperior, o músculo tensor da fáscia lata e músculo sartório.

q0958 [ME]

Em pacientes submetidos a cirurgia ambulatorial, pode retardar a alta:

- A) Administração de cetamina.
- B) Bloqueio de nervo periférico.
- C) Escore 1 na Escala de Ramsay modificada no pós-operatório imediato.
- D) Pontuação 2 no questionário de rastreio STOP-Bang na avaliação pré-anestésica.

q0959 [ME]

Homem de 23 anos, 82 Kg e previamente hígido, vítima de politrauma por acidente automobilístico e teste de alcoolemia positivo para embriaguez será submetido à laparotomia exploradora e fixação de fraturas de membros inferiores. Vem ao centro cirúrgico entubado em uso -1 -1 de noradrenalina 0,5 µg.Kg .min após medidas iniciais de atendimento no setor de emergência. A - -1 gasometria inicial revela: pH de 7,15; PaO₂ de 98 mmHg; PaCO₂ de 30mmHg; HCO₃ de 8 mEq.L ; BE + -1 + -1 - -1 de - 18; Na de 140 mEq.L ; K de 5 mEq.L ; Cl de 107 mEq.L e anion gap de 30. Com base na relação observada entre o aumento do anion gap e a queda do bicarbonato sérico (Δ anion gap / Δ - HCO₃ = 0,875), o paciente provavelmente apresenta uma acidose metabólica por:

- A) rabdomiólise e hipoperfusão
- B) hipoperfusão e cetoacidose alcoólica
- C) hipoperfusão e expansão volêmica com solução rica em cloreto
- D) cetoacidose alcoólica e expansão volêmica com solução rica em cloreto

q0960 [ME]

Você está escalado para uma cirurgia de herniorrafia umbilical aberta. Enquanto discute com seu preceptor qual anestesia vocês irão realizar para esse procedimento, a discussão das diferenças entre raquianestesia e peridural surgiu. Com relação a esse tema:

- A) a densidade do líquido cefalorraquidiano é de 1,00059 g.dL⁻¹, e varia com a temperatura.
- B) a concentração e a dose são os parâmetros que mais afetam a distribuição dos anestésicos locais e altura do bloqueio durante a anestesia peridural.
- C) a baricidade e o volume são os parâmetros que mais afetam a distribuição dos anestésicos locais e altura do bloqueio durante a raquianestesia.
- D) adicionar adrenalina tem efeito limitado em aumentar a duração do bloqueio peridural com levobupivacaína, uma vez que esta já possui efeito vasoconstrictor intrínseco.

q0961 [ME]

O sistema renina-angiotensina-aldosterona é um dos principais sistemas reguladores da excreção de sódio pelo organismo. Sobre esse sistema é correto afirmar:

- A) A angiotensina I tem potente ação vasoconstritora.
- B) A aldosterona estimula a excreção de sódio no ducto coletor.
- C) A renina é responsável pela conversão da angiotensina I em angiotensina II.
- D) Em situações de hipovolemia, a renina é liberada pelo aparelho justaglomerular.

q0962 [ME]

No Brasil, a doação de sangue é regulamentada pela lei nº 10.205. Os hemocomponentes são gerados do sangue total por diferentes processos físicos. Com relação aos diferentes hemocomponentes existentes e suas características peculiares, podemos afirmar que:

- A) o concentrado de hemácias deve ser mantido entre 10 e 18 °C e sua validade varia entre 16 e 24 dias, dependendo da solução conservadora.
- B) o plasma pode ser encontrado no banco de sangue em três formas plasma fresco congelado, plasma isento de crioprecipitado e plasma de 24 horas.
- C) o plasma fresco congelado tem validade por até 12 meses.
- D) os concentrados de plaquetas são armazenados em temperatura ambiente, sob agitação constante e apresentam validade de 48 horas.

q0963 [ME]

Paciente masculino, 55 anos, 175 cm, 68 kg, nega comorbidades, alergias. Refere ser ex-tabagista com carga tabágica de 30 maços/ano. Submetido a colecistectomia videolaparoscópica. Na indução anestésica foi utilizado propofol, a manutenção foi sob anestesia geral balanceada com isoflurano e remifentanil e mantido relaxamento muscular com rocurônio em bolus guiado por monitorização adequada. Ao final do procedimento, que teve duração de 90 minutos, foi suspensa a administração dos agentes inalatórios e venosos, o paciente foi extubado com razão de TOF T4/T1 = 95%. Após 15 minutos, na sala de recuperação pós-anestésica, evolui com queda da saturação periférica de oxigênio. Qual a principal hipótese diagnóstica para o ocorrido?

- A) Efeito residual do propofol.
- B) Efeito residual do isoflurano.
- C) Efeito residual do remifentanil.
- D) Efeito residual do rocurônio.

q0964 [ME]

Um valor de 60 no índice bispectral (BIS) significa que haverá:

- A) imobilidade à incisão cirúrgica
- B) probabilidade de 60% de estar acordado
- C) probabilidade de responder ao comando verbal de 40%
- D) menos de 1% de probabilidade de ter lembranças de eventos intraoperatórios

q0965 [ME]

Considerando o gráfico abaixo da relação entre a fração alveolar (FA) e fração inspirada (FI) de anestésicos inalatórios, assinale a alternativa correta:

- A) a FI independe do fluxo de gases frescos.
- B) o N2O apresenta o maior coeficiente de partição sangue:gás.
- C) o tamanho do circuito do ventilador influencia no tempo de equilíbrio FA/FI.
- D) o coeficiente de partição sangue:gás é diretamente proporcional ao aumento da FA.

q0966 [ME]

Paciente masculino, 42 anos, 167 cm, 108 kg, será submetido a cirurgia para tratamento de anquilose da articulação temporomandibular (ATM) por equipe odontológica sob anestesia geral. Após indução anestésica, realizada intubação orotraqueal por laringoscopia direta após várias tentativas. Antes do início do procedimento cirúrgico, observou-se trauma dentoalveolar de três incisivos superiores e luxação da ATM. Visando minimizar as lesões secundárias ao manuseio da via aérea, deve-se:

- A) Na luxação dentária, evitar manipular a área.
- B) Na avulsão dentária, evitar reimplantação precoce.
- C) Na luxação da ATM, prescrever dieta pastosa por 48 horas.
- D) Na avulsão dentária, higienizar o dente com água corrente.

q0967 [ME]

A respeito da equipe de tratamento multidisciplinar de dor crônica:

- A) os pacientes buscam inicialmente outros membros da equipe antes do médico especialista.
- B) para garantir a neutralidade no time, cada membro deverá realizar suas prescrições sem se deixar influenciar pelo que os outros membros do time escreveram no prontuário.
- C) a utilização de uma estratégia interdisciplinar resulta em aprimoramento significativo das capacidades físicas e sociais, porém, devido à participação de um maior número de especialistas, acarreta custos mais elevados.
- D) a presença do anesthesiologista confere credibilidade, sendo fundamental para prevenir que o paciente interprete sua dor como algo puramente psicológico ou imaginário.

q0968 [ME]

Você está realizando um bloqueio de plexo braquial com um probe ultrassom linear de alta frequência e agulha de 5 cm na janela supraclavicular, como demonstrado na figura abaixo. Qual seria a estrutura circulada na imagem do ultrassom?

- A)** Nervo axilar.
- B)** Nervo frênico.
- C)** Nervo supraescapular.
- D)** Nervo musculocutâneo.

q0969 [ME]

Paciente com indicação de artroplastia total de joelho será submetido ao bloqueio de nervo periférico ilustrado nas imagens abaixo. Com relação a este nervo:

- A)** tem como ramo sensorial final o nervo sural.
- B)** fornece analgesia do aspecto lateral da perna.
- C)** emite ramos infrapatelares para a articulação do joelho.
- D)** situa-se próximo à artéria poplítea demonstrada na imagem.

q0970 [ME]

Homem de 77 anos, 68 Kg e 1,70 m com DPOC e HAS está no centro cirúrgico para realização de colectomia videolaparoscópica. A pressão sistólica estimada de artéria pulmonar no ecocardiograma pré-operatório foi de 55 mmHg. Apresenta PA de 140x80 mmHg, FC de 65 bpm e SpO₂ de 94%. Logo após insuflação do pneumoperitônio (pressão intra-abdominal de 18 mmHg) a PA passa para 60x40 mmHg, FC de 45 bpm, SpO₂ de 88%. A explicação mais provável para esta hipotensão está relacionada com o(a):

- A)** disfunção ventricular direita
- B)** diminuição da pós-carga ventricular esquerda
- C)** desvio para a direita do septo interventricular
- D)** aumento da pressão transmural ventricular esquerda

q0971 [ME]

Criança de 4 anos e 25 kg será submetida à ressecção de meduloblastoma em fossa posterior. Possui antecedentes de hidrocefalia, convulsões e episódios de apneia. Nesse caso, devemos considerar:

- A)** A presença de grandes seios venosos, sagital e sigmoide pode causar hemorragia importante.
- B)** Como o sítio cirúrgico está acima do átrio direito, dificilmente existe o risco de embolia aérea venosa.
- C)** O controle da via aérea é essencial durante todo o procedimento, logo o paciente deve ser extubado em sala cirúrgica ao término da cirurgia.
- D)** Embora a incidência de embolia aérea na posição sentada seja semelhante entre adulto e criança, na criança, a repercussão hemodinâmica é menor.

q0972 [ME]

Mulher de 52 anos, 147 kg e 1,62 m está agendada para fazer uma cardioplastia videolaparoscópica. Refere hipertensão, diabetes tipo 2 e dislipidemia controlados com medicação específica. Avaliação da via aérea mostra Malampatti 2, extensão cervical limitada, distância interincisivos de 4,5 cm e distância tireomentoniana de 8 cm. O serviço de nutrição do hospital incentiva a administração de maltodextrinas antes da cirurgia. Como você orientaria o uso dessas soluções?

- A)** São seguras se ingeridas até duas horas antes da cirurgia.
- B)** Melhoram o pós-operatório, já que aumentam a resistência à insulina.
- C)** Sua utilização aumenta a incidência de náuseas e vômitos no pós-operatório.
- D)** As evidências são insuficientes para a utilização dessas substâncias, já que não influenciam no tempo de internação e mortalidade.

q0973 [ME]

Qual sistema é projetado para prevenir conexão incorreta das linhas de suprimento de gás hospitalar ao aparelho de anestesia?

- A)** Sistema de Segurança de Índice de Fluxo (SSIF).
- B)** Sistema de Segurança de Índice de Diâmetro (DISS).
- C)** Sistema de Segurança de Índice de Pressão (SSIP).
- D)** Sistema de Monitoramento Eletrônico Integrado (SMEI).

q0974 [ME]

No gerenciamento da segurança de um paciente, faz-se necessário atenção ao seu posicionamento. Sendo assim:

- A)** O grau de limitação da abdução do braço deve ser de, no máximo, 45 graus.
- B)** A posição de Trendelenburg produz alterações hemodinâmicas e respiratórias por aproximadamente um minuto.
- C)** Na posição supina, a anestesia geral com relaxamento muscular e bloqueio neuroaxial aumenta ainda mais o risco de dor nas costas.
- D)** Para evitar a síndrome compartimental na posição de litotomia, recomenda-se abaixar as pernas periodicamente, se o tempo cirúrgico ultrapassar quatro a cinco horas.

q0975 [ME]

Mulher de 65 anos, 84 Kg e 1,68 m será submetida à troca emergencial de válvula mitral por ruptura da cordoalha tendinosa secundária a degeneração mixomatosa. Durante a indução da anestesia, a paciente cursa com PA de 70x40 mmHg e FC de 58 bpm e o anestesiológista administra 1,0 mg de metaraminol. O efeito esperado desta conduta na monitorização da pressão capilar pulmonar se refletirá predominantemente no(a):

- A)** onda a
- B)** onda v
- C)** descenso x
- D)** descenso y

q0976 [ME]

Homem de 27 anos, sem comorbidades, foi submetido a herniorrafia inguinal bilateral por videolaparoscopia sob anestesia geral. Tem relato, na consulta pré-anestésica, de alergia a dipirona e a anti-inflamatórios não esteroidais. A operação aconteceu no final do plantão, e o anestesiológista que iniciou o procedimento precisou ser substituído por outro colega, que chegou à noite após trabalhar por 24 horas em outro hospital. No final da cirurgia, foram administrados dipirona e cetoprofeno, e o paciente apresentou choque anafilático grave, de modo que precisou ser levado à UTI em ventilação mecânica e só recebeu alta hospitalar três dias depois da cirurgia. Durante a avaliação do evento adverso pelo comitê de qualidade do serviço de anestesiologia, podem ser considerados fatores que geraram o desfecho, nesse caso:

- A)** A idade do paciente e o seu estado físico.
- B)** O adequado e rigoroso controle da farmácia na dispensação de medicamentos.
- C)** A ausência de descrição adequada do histórico do paciente na avaliação pré-anestésica.
- D)** A carga de trabalho excessiva do anestesiológista e a provável falta de sistematização e documentação da transferência do cuidado entre os profissionais.

q0977 [ME]

Na abordagem dos bloqueios periféricos com a ultrassonografia, um transdutor de alta frequência é indicado para o bloqueio:

- A)** Plexo braquial por via interescalênica.
- B)** Nervos pericapsulares (peng block).
- C)** Plexo lombar por via posterior.
- D)** Ciático infraglúteo.

q0978 [ME]

Considerando a figura esquemática abaixo de uma sequência de três fluxômetros (oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso), em qual posição o fluxômetro de oxigênio acarreta menor risco de uma mistura hipóxica em caso de vazamento em algum fluxômetro?

- A) A
- B) B
- C) C
- D) Qualquer posição

q0979 [ME]

Qual alternativa contempla um dos requisitos mínimos para a realização de atos anestésicos em ambiente fora do centro cirúrgico?

- A) Aparelho de anestesia destinado a oferecer gases anestésicos ao paciente devendo cumprir os critérios e determinações da ABNT.
- B) Disponibilidade de fonte de oxigênio confiável, bem como dispositivos como máscara facial ou cânulas nasais.
- C) Sistema de comunicação bidirecional com qualidade de som testada e aprovada pelo departamento de anestesiologia.
- D) Disponibilidade de médico provedor da anestesia certificado de ACLS nos últimos dois anos.

q0980 [ME]

Recém-nascido pré-termo com 34 semanas de gestação, agora com de 2 semanas de vida e 2 Kg, será submetido à laparotomia exploradora. Você optou por ventilação mecânica controlada a pressão. Qual característica da ventilação mecânica deste paciente justifica esta escolha?

- A) alta complacência pulmonar
- B) baixo volume de oclusão das vias aéreas
- C) alta condutância das vias aéreas superiores
- D) baixo volume corrente em relação ao volume do circuito

q0981 [ME]

Com relação aos bloqueios contínuos para analgesia pós-operatória:

- A) solução de lidocaína associado a opioide lipofílico é a mais recomendada.
- B) as bombas elastoméricas necessitam de ajuste da dose de bolus.
- C) bloqueio interescalênico está indicado para analgesia de cirurgia de úmero distal.
- D) bloqueio infraclavicular, comparado ao axilar, apresenta menor risco de deslocamento de cateter.

q0982 [ME]

O vecurônio tem seu efeito reduzido na presença de:

- A) lítio
- B) carbamazepina
- C) dantrolene sódico
- D) sulfato de magnésio

q0983 [ME]

Homem de 62 anos e 60 Kg com história de miocardiopatia dilatada e doença pulmonar obstrutiva crônica será submetido à revascularização do membro inferior direito. Vem em uso regular de digoxina, enalapril, espironolactona e furosemida além de salmeterol e fluticasona. Refere piora dos sintomas respiratórios na última semana com dispneia aos esforços habituais. Qual é o melhor exame pré-operatório para avaliar a descompensação cardíaca como causa de dispneia e fator de risco perioperatório neste paciente?

- A) Espirometria
- B) Teste ergométrico
- C) Ecocardiograma transtorácico
- D) Peptídeo natriurético tipo B (BNP)

q0984 [ME]

Durante as anestесias fora do centro cirúrgico, muitas vezes existe a utilização de equipamentos que emitem radiação ionizante, portanto:

- A)** os aventais de chumbo são pouco eficientes para bloquear a radiação espalhada e estão em franco desuso.
- B)** a exposição à radiação pode ser diminuída com o uso de ângulos oblíquos para a obtenção da imagem.
- C)** a intensidade da radiação espalhada é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte.
- D)** a exposição à radiação é menor perto da cabeceira da cama.

q0985 [ME]

Dentre os efeitos farmacológicos da acetilcolina está o (a):

- A)** resposta endotelial vasodilatadora
- B)** relaxamento da musculatura lisa da íris
- C)** relaxamento da musculatura lisa brônquica
- D)** diminuição da pressão do esfíncter esofágico inferior

q0986 [ME]

Qual das alternativas caracteriza o bloqueio despolarizante na monitorização da junção neuromuscular?

- A)** Queda da relação T4:T1
- B)** Presença de facilitação pós-tetânica
- C)** Aumento da resposta muscular a estímulos de baixa frequência
- D)** Resposta mantida à estimulação tetânica com amplitude reduzida

q0987 [ME]

Uma equipe de anestesiolóгistas viajou para um país em desenvolvimento para fornecer anestesia para seus colegas cirurgiões que planejam realizar procedimentos reconstrutivos em crianças com fissura palatina e anormalidades craniofaciais. Os anestesiolóгistas levaram uma grande quantidade de sevoflurano, mas descobriram que não havia vaporizadores para esse agente anestésico no hospital onde eles iriam trabalhar. Em termos de precisão na liberação, a menor diferença entre as concentrações definidas e liberadas de sevoflurano resultará se ele for administrado através de qual desses vaporizadores?

- A)** Vaporizador de desflurano.
- B)** Vaporizador de halotano.
- C)** Vaporizador de enflurano.
- D)** Vaporizador de isoflurano.

q0988 [ME]

Com relação aos bloqueios neurolíticos para tratamento da dor crônica, é correto afirmar:

- A)** A injeção de fenol deve ser repetida em intervalos de 30 dias.
- B)** São contraindicados em nervos intercostais e no gânglio simpático lombar.
- C)** Os corticoides são considerados os agentes neurolíticos de escolha em pacientes com curta expectativa de vida.
- D)** Como agente neurolítico, o álcool promove alívio da dor com maior duração, quando comparado com o fenol.

q0989 [ME]

Paciente de 45 anos, 75 kg e 1,75 m, ASA I, foi submetido à anestesia geral para cirurgia de laparotomia. Indução: fentanil, 300 mcg; lidocaína, 2 mg/kg; propofol, 200 mg; rocurônio, 50 mg. Intubação orotraqueal (IOT) com sucesso. Manutenção com desflurano a 3% e N₂O a 60%. Dados hemodinâmicos antes da IOT: pressão arterial (PA) = 140/70 mmHg; frequência cardíaca (FC) = 85 bpm; após a IOT: PA = 110/80 mmHg; FC = 70 bpm. Depois do início da cirurgia, PA = 160/110 e FC = 125 bpm. Para controlar a PA e a FC, o anestesiológista decidiu aumentar o desflurano para 10%; depois de cinco minutos, houve elevação da PA para 210/130 mmHg e da FC para 145 bpm. Observa-se nessa situação:

- A)** Elevação da pressão parcial do desflurano acima de 1.500 mmHg.
- B)** Elevação dos níveis das catecolaminas por desflurano acima de 1,0 CAM.
- C)** Aumento de bolhas no vaporizador e diminuição da taxa de vaporização.
- D)** Diminuição na temperatura do vaporizador e queda na pressão parcial do gás fresco.

q0990 [ME]

Com o objetivo de reduzir o risco de fogo na via aérea em procedimentos com o uso de laser, algumas medidas devem ser tomadas, entre elas:

- A)** Usar eletrocautério pelo menor tempo possível, evitando-se o modo bipolar.
- B)** Depois da intubação, o balonete do tubo endotraqueal deve ser preenchido com solução salina.
- C)** Utilizar a menor fração inspirada de oxigênio e manter o ambiente seco com a inserção de gazes secas nas vias aéreas.
- D)** Na vigência de fogo na via aérea, deve-se remover o tubo traqueal e iniciar a ventilação sob máscara facial com oxigênio a 100%.

q0991 [ME]

Um homem de 45 anos, 75 kg, 1,75m com estenose subglótica prévia é levado para a sala de operação para uma apendicectomia por videolaparoscopia. Durante a indução anestésica, o anestesiológista tenta em três ocasiões distintas ventilar o paciente usando máscara facial, sem sucesso, chamou ajuda. Em seguida o anestesiológista mais experiente, tenta intubar o paciente em três tentativas, mas não consegue. Também tenta por três vezes a utilização de um dispositivo supraglótico, mas novamente não tem êxito. Dentre as opções apresentadas abaixo, utilizando o Vortex como orientação qual delas é a melhor opção para abordar a via aérea nesse paciente?

- A)** Traqueostomia de emergência.
- B)** Laringoscopia direta com lâmina reta.
- C)** Cricotireoidostomia cirúrgica.
- D)** Ventilação por pressão positiva usando máscara facial.

q0992 [ME]

Homem de 54 anos, 67 kg e 1,78 m, portador de fibrose pulmonar idiopática, foi submetido a transplante pulmonar sob anestesia geral e ventilação monopulmonar. Logo depois do clampeamento da artéria pulmonar, o paciente evoluiu com piora da hipoxemia, aumento da pressão da artéria pulmonar, instabilidade hemodinâmica e sinais de disfunção do ventrículo direito ao ecocardiograma transesofágico. Quanto ao manejo dessa situação clínica:

- A)** Em casos refratários, o suporte mecânico com circulação extracorpórea deve ser considerado.
- B)** É recomendado aumento das pressões ventilatórias e da fração inspirada de oxigênio.
- C)** É contraindicado o uso de óxido nítrico inalatório pelo seu efeito vasoconstritor pulmonar e o risco de piora da hipertensão pulmonar.
- D)** Reduzir o volume-minuto e permitir hipercapnia acentuada leva à diminuição da pressão de artéria pulmonar e melhora a contratilidade do ventrículo direito.

q0993 [ME]

Você planeja realizar anestesia ambulatorial para ressecção de tumor glômico em I pododáctilo com duração planejada de 45 minutos. Decide por realizar bloqueio de nervo fibular superficial e sedação com infusão contínua de propofol. A escolha do propofol neste caso deve-se:

- A)** à sua ação antitumoral evidenciada pela capacidade de inibição específica de mutações genéticas em células tumorais.
- B)** à sua capacidade de proporcionar um despertar rápido e lúcido.
- C)** ao seu padrão eletroencefalográfico semelhante ao sono fisiológico.
- D)** à potencialização da ação dos anestésicos locais nos bloqueios periféricos.

q0994 [ME]

Paciente do sexo masculino, 4 anos, portador de distrofia muscular de Duchenne, está agendado para correção cirúrgica de deformidade óssea e contratura nos membros inferiores. No manuseio anestésico observa-se que:

- A)** A succinilcolina é indicada para a intubação traqueal.
- B)** A anestesia com sevoflurano está associada a reações metabólicas no perioperatório, como a rabdomiólise.
- C)** Os anticolinesterásicos são indicados para a reversão do bloqueio neuromuscular adespolarizante, enquanto o sugamadex continua em estudo.
- D)** Os relaxantes musculares adespolarizantes têm início de ação rápido e são indicados para facilitar o manuseio das contraturas dos membros inferiores.

q0995 [ME]

Mulher de 26 anos, 70 Kg e 1,65 m foi submetida a parto cesariano sob anestesia espinhal há 12 horas tendo evoluído inicialmente sem complicações. Nas últimas horas vem apresentando fadiga e letargia com PA de 79x51 mmHg, FC de 118 bpm, temperatura de 37,1°C, FR de 22 irpm e SpO₂ de -1 94% em ar ambiente, além de extremidades frias e edemaciadas com hemoglobina de 9 g.dL . Um bolus de fluidos foi administrado sem melhora dos sinais vitais tendo sido optado pela inserção de cateter venoso central e linha arterial que revelaram PVC de 21 mmHg e débito cardíaco diminuído pela análise da forma da onda arterial. O diagnóstico mais provável nesta situação é:

- A)** sepse.
- B)** hipovolemia.
- C)** cardiomiopatia.
- D)** embolia pulmonar.

q0996 [ME]

Homem 70 anos, 75 Kg, 168 cm, agendado para prostatectomia radical. Em uso de atenolol, rosuvastatina, ezetimiba, ácido acetilsalicílico, selegelina e olmesartana. Aponte a medicação que deve ser suspensa vinte quatro horas antes da cirurgia:

- A)** selegilina
- B)** ezetimiba
- C)** olmesartana
- D)** ácido acetilsalicílico

q0997 [ME]

Homem de 19 anos, 72 kg e 1,75 m é levado para o centro cirúrgico para ser submetido a uma laparotomia exploradora, após sofrer vários ferimentos por projéteis de arma de fogo no tórax e no abdome. O paciente foi submetido a massagem cardíaca aberta no pronto-socorro e recebeu um total de 10 unidades de concentrado de hemácias (CH) e 8 unidades de plasma fresco congelado (PFC). O pronto-socorro enviou uma amostra de sangue total do paciente para tromboelastografia (TEG), e os resultados estão demonstrados abaixo: Com base nesse tromboelastograma, de qual produto sanguíneo o paciente mais se beneficiaria nesse momento?

- A) Plaquetas.
- B) Crioprecipitado.
- C) Ácido tranexâmico.
- D) Plasma fresco congelado.

q0998 [ME]

Menino de 5 anos e 20 kg foi submetido a anestesia inalatória com sevoflurano a 2% e óxido nitroso a 25% para postectomia. Sobre os agentes inalatórios, podemos afirmar:

- A) O desflurano aumenta o fluxo sanguíneo renal, a taxa de filtração glomerular e o débito urinário.
- B) O sevoflurano sofre biotransformação na taxa de 2% a 3% da quantidade captada, produzindo ácido trifluoracético potencialmente nefrotóxico em animais de experimentação.
- C) O isoflurano possui um efeito cardiovascular com desvio do fluxo sanguíneo coronariano de áreas com vasculatura normal para áreas isquêmicas denominado "roubo coronariano".
- D) A exposição ao óxido nitroso por mais de seis horas determina depressão da atividade da metionina sintetase e eritropoiese megaloblástica, por causa da oxidação irreversível da vitamina B12.

q0999 [ME]

Mulher de 38 anos, 82 kg e 1,72 m, data da última menstruação há 26 dias, será submetida a litotripsia extracorpórea por ondas de choque para desintegrar uma pedra alojada dolorosamente no ureter superior. A paciente solicita anestesia peridural e opta por permanecer acordada e cooperativa com seu posicionamento e procedimento. Nesse caso:

- A) É necessário um teste de gravidez documentado antes da litotripsia.
- B) Na ventilação espontânea, a excursão do cálculo é limitada a aproximadamente 5 mm.
- C) Com os litotriptores modernos, observam-se de 20% a 59% de casos de disritmia, por isso ele é contraindicado em cardiopatas.
- D) A anestesia venosa total e a ventilação controlada seriam as melhores indicações para manter a mobilidade da pedra < 60 mm.

q1000 [ME]

Condição clínica na síndrome da resposta inflamatória sistêmica:

- A) Hipoglicemia.
- B) Hiperomotilidade intestinal.
- C) Insuficiência adrenal relativa.
- D) Elevação da Proteína C Reativa.

q1001 [ME]

Homem de 65 anos, 60 Kg e 1,70 m, será submetido à prostatectomia radical. É tabagista 40 maços.ano, diabético e hipertenso em uso de metformina, losartana e hidroclorotiazida. Na visita pré-anestésica, o paciente relata tontura com frequentes episódios de lipotimia ao se levantar. Ao medir a pressão arterial com o paciente deitado e logo após se levantar, você nota uma redução de 20 mmHg na pressão sistólica e de 15 mmHg na diastólica. Qual é o mecanismo fisiopatológico desse achado?

- A) Perda da elasticidade da rede arterial
- B) Superposição sistólica da onda de pulso na rede arterial
- C) Diminuição da resposta vasoconstritora arterial e venosa
- D) Diminuição da concentração plasmática de noradrenalina

q1002 [ME]

Qual é a contraindicação absoluta para a utilização venosa de amiodarona?

- A)** Hipotireoidismo
- B)** Fibrose pulmonar
- C)** Neuropatia óptica
- D)** Bloqueio atrioventricular

q1003 [ME]

Com relação à cirurgia torácica ilustrada nas imagens abaixo.

- A)** O tubo de escolha para a maioria dos pacientes é o duplo lúmen.
- B)** Pneumotórax é a complicação mais grave.
- C)** Monitorar o pulso no braço direito é mandatório.
- D)** Pós-operatório em UTI é recomendado na maioria dos casos.